



2023.10.

국회예산정책처 | 현안보고서

2023~2032년 건강보험 재정전망

National Health Insurance Fiscal Projections 2023~2032

임슬기



국회예산정책처
NATIONAL ASSEMBLY BUDGET OFFICE

2023~2032년 건강보험 재정전망

2023~2032년 건강보험 재정전망

총 괄 | 신 항 진 추계세제분석실장

기획·조정 | 심 해 정 조세분석심의관
이 진 우 사회비용추계과장

작 성 | 임 슬 기 사회비용추계과 추계세제분석관

지 원 | 박 미 현 사회비용추계과 행정실무원
김 희 원 사회비용추계과 자료분석지원요원

「2023~2032년 건강보험 재정전망」은 건강보험에 대한 중기 재정소요 분석을 통하여 국회의 예산안 및 법률안 심사를 지원하기 위한 목적으로 발간되었습니다.

문 의 : 추계세제분석실 사회비용추계과 | 02) 6788-3729 | sce@nabo.go.kr

이 책은 국회예산정책처 홈페이지(www.nabo.go.kr)를 통하여 보실 수 있습니다.

2023~2032년 건강보험 재정전망

2023. 10.

이 보고서는 「국회법」 제22조의2 및 「국회예산정책처법」 제3조에 따라
국회의원의 의정활동을 지원하기 위하여, 국회예산정책처 「보고서발간심의위원회」의
심의(2023. 09. 26.)를 거쳐 발간되었습니다.

발 간 사

우리나라는 1963년 의료보험을 처음 도입한 후 26년만인 1989년에 전 국민 대상의 의료보험을 실시하였습니다. 다른 선진국과 비교해 도입 시기가 늦고 실시 기간이 짧았음에도 현행 우리나라 건강보험제도는 수혜대상 및 보장성 등의 측면에서 가장 선진적인 의료보장 체계의 하나로 평가받을 만큼 발전해왔습니다.

이러한 성공적인 평가에도 불구하고 건강보험제도는 미래의 안정성과 지속가능성을 불안하게 하는 다양한 요인들에 의한 도전에 직면해 있습니다. 빠른 속도로 증가하는 노인 인구는 의료비 지출의 급증을 견인하고 있고 초저출산으로 인한 미래 생산가능인구의 감소는 건강보험의 주요 재원인 보험료 수입의 감소를 초래할 것으로 예상됩니다.

최근 건강보험 재정은 코로나19로 인한 의료이용 감소로 누적 준비금이 2022년 기준 23.8조에 달할 정도로 재정 상태가 양호해 보입니다. 그러나 보험급여 지출은 곧 코로나19 이전의 급증 추이를 재현할 것으로 보이며 보험료 수입 증가폭을 둔화시키는 것으로 전망된 건강보험료 부과체계 개편(2022.9.)과 같은 수입 감소 요인도 상존합니다.

이러한 상황에도 불구하고 건강보험 재정은 국가재정 외로 운용되어 보험재정에 대한 심도 있는 탐색과 논의가 진행되고 있지 않고 그에 따라 건강보험 재정 불안요소에 대응할 수 있는 분석과 재정전망 결과 등에 대한 공개된 정보도 부족한 상황입니다.

이에 본 보고서는 향후 10년간의 건강보험 재정전망 결과를 제시하여 국가재정에 포함되지 않은 건강보험에 대한 충분한 재정 정보를 제공하고자 합니다. 더불어 보험료율, 국고지원율 등 각 정책 시나리오별 전망 결과를 함께 제시하여 정부가 “제2차 건강보험종합계획” 발표를 앞두고 있는 시점에 제도의 안정성 및 지속가능성 제고 방안을 위한 다양한 논의가 이루어질 수 있도록 하고자 합니다.

본 보고서가 건강보험 재정에 대한 논의 시 기초자료로 활용될 뿐만 아니라, 건강보험 제도에 대하여 관심을 가지고 계신 국회의원님들의 의정활동에 유용한 참고자료가 될 수 있기를 바랍니다.

2023년 10월

국회예산정책처장 조 의 섭

차 례

요 약

I. 서 론 / 1

- 1. 연구 배경 및 목적 1
- 2. 연구 내용 및 방법 3

II. 건강보험 제도 및 재정 현황 / 4

- 1. 연혁 4
- 2. 제도 개요 및 현황 6
 - 가. 운영체계 6
 - 나. 건강보험 적용대상 7
 - 다. 건강보험료 부과체계 10
 - 라. 건강보험 급여 13
- 3. 건강보험 재정구조 및 추이 19
 - 가. 총괄 19
 - 나. 건강보험 수입 구조 및 현황 21
 - 다. 건강보험 지출 구조 및 현황 26
- 4. 세부 항목별 급여 현황 28
 - 가. 연령군별 급여 현황 28
 - 나. 진료형태별 급여 현황 30
 - 다. 자격유형별 급여 현황 31
 - 라. 요양기관 종별 급여 현황 32

III. 건강보험 재정전망 / 33

- 1. 전망 방법 33
 - 가. 전망 모형 33

나. 주요 가정	35
2. 기본전망 결과	40
가. 수입 전망	40
나. 지출 전망	42
다. 재정수지 및 준비금	43

IV. 재정전망 심층 분석 / 47

1. 주요 정책 변화에 따른 재정전망	47
가. 보험료율 조정	47
나. 국고지원율 변화	50
2. 필요 보험료율 분석	54
가. 재정목표별 가정	54
나. 전망 결과	56

V. 결 론 / 60

1. 분석결과 요약	60
2. 정책적 시사점	62
가. 수입 확충을 위한 건강보험 제도 및 관련 법령에 대한 논의 필요	62
나. 건강보험 지출효율화	64
다. 재정전망 수행 및 결과 공개의 필요성	66

부 록 / 67

참고문헌 / 77

표 차례

[표 1] 건강보험 가입 제도 개요	8
[표 2] 건강보험 가입유형별 적용인구 현황	8
[표 3] 건강보험료 부과 방식(2023년 기준)	11
[표 4] 의료기관 종별, 환자 구분별 본인부담률	14
[표 5] 건강보험 보험급여 유형	15
[표 6] 하위분류별 보험급여비 추이: 2018~2022년	16
[표 7] 의료기관 유형별 수가 인상률 추이: 2018~2024년	18
[표 8] 건강보험 재정 추이: 2013~2022년	20
[표 9] 건강보험 재정구조 개요	21
[표 10] 보험료율 및 부과점수당 금액 추이: 2017~2023년	22
[표 11] 건강보험에 대한 국고지원 관련 법령 연혁	23
[표 12] 건강보험 실 국고지원을 추이: 2017~2023년	24
[표 13] 건강보험 수입 추이: 2013~2023년	25
[표 14] 건강보험 재정구조 개요	26
[표 15] 건강보험 지출 추이: 2013~2022년	27
[표 16] 연령별 이용 현황(2022년 기준)	28
[표 17] 진료형태별 급여 현황	30
[표 18] 자격유형별 급여 현황	31
[표 19] 요양기관 종별 급여 현황	32
[표 20] 건강보험 전망의 주요 가정: 주요 인구 변수	36
[표 21] 건강보험 전망의 주요 가정: 주요 거시경제변수	37
[표 22] 건강보험 전망의 주요 가정: 주요 제도변수	38
[표 23] 건강보험료 보험료율 가정: 2023~2032년	38
[표 24] 건강보험 납부자 수 전망: 2023~2032년	41
[표 25] 건강보험 수입 전망: 2023~2032년	42
[표 26] 건강보험 지출 전망: 2023~2032년	43
[표 27] 건강보험 재정수지 및 준비금 전망: 2023~2032년	44
[표 28] 보험료율 조정에 따른 시나리오 개요	47
[표 29] 시나리오별 보험료율 가정: 2023~2032년	48

[표 30] 보험료율 시나리오별 재정수지 전망: 2023~2032년	49
[표 31] 보험료율 시나리오별 준비금 전망: 2023~2032년	49
[표 32] 국고지원을 조정에 따른 시나리오 개요	50
[표 33] 국고지원을 시나리오별 재정수지 전망: 2023~2032년	53
[표 34] 국고지원을 시나리오별 준비금 전망: 2023~2032년	53
[표 35] 필요 보험료율 분석 시나리오 개요	54
[표 36] 보험료율 가정: 재정수지 균형 유지	56
[표 37] 보험료율 가정(2023~2032년): 국고지원 종료 후 균형 유지	57
[표 38] 보험료율 가정: 준비금 소진 방지	58

그림 차례

[그림 1] 국민건강보험제도 주요 연혁	5
[그림 2] 우리나라 건강보험 운영체계	7
[그림 3] 가입유형별 가입자 수 추이: 2007~2022년	10
[그림 4] 의료비 구조	14
[그림 5] 건강보험 수가 및 소비자물가지수 인상률 추이	18
[그림 6] 건강보험 재정수지 추이: 2013~2022년	20
[그림 7] 연령군별 급여비 현황: 2012~2022년	29
[그림 8] 연령군별 1인당 급여비 추이: 2012~2022년	29
[그림 9] NABO(2023) 건강보험 재정전망 모형 개요	33
[그림 10] 급여비 지출 결정요인	35
[그림 11] 장래인구추계: 2023~2032년	36
[그림 12] 건강보험 가입자 유형별 전망: 2023~2032년	41
[그림 13] 건강보험 수입, 지출 및 준비금 전망: 2023~2032년	44
[그림 14] 재정수지 균형 유지 보험료율 전망 결과: 2023~2032년	56
[그림 15] 국고지원 종료 후 재정수지 균형 유지 보험료율 전망 결과: 2023~2032년	57
[그림 16] 준비금 소진 방지 보험료율 전망 결과: 2023~2032년	59
[그림 17] 재정목표별 필요 보험료율 전망 결과 요약: 2023~2032년	59

요 약

I. 서론

- 코로나19 기간 중 국민의 의료이용이 감소하고 보험료 수입이 증가함에 따라 2022년 건강보험 누적 준비금은 23.8조원으로 역대 최대 수준을 기록
- 그러나 급격한 고령화 추세로 예상되는 건강보험 지출 증가와 보험료율 8% 법정 상한 규정, 국고지원 한시 규정¹⁾ 등 보험료 수입 증가를 제약하는 요인들로 인해 중장기적으로는 재정이 한계에 직면할 것으로 예상
- 이에 본 보고서는 최근의 의료이용 및 정책 변화를 반영한 재정전망 결과와 정책 시나리오별 전망 결과를 제시하여 건강보험 제도의 안정적인 운용 및 관련 법 개정 등의 논의에 기여하고자 함

II. 건강보험 제도 및 재정 현황

1. 연혁

- 우리나라는 1963년 12월 「의료보험법」 제정을 시작으로 임의가입 의료보험을 실시하였으며, 이후 의무가입 조항과 대상이 추가되며 1989년 7월 전 국민 의료보험이 실현
- 2000년 7월에는 「국민건강보험법」을 시행하고 국민건강보험공단을 설립함으로써 단일보험자 조직의 관리운영체계를 마련
- 건강보험에 대한 국고지원은 2002년 「국민건강보험재정건전화특별법」 제정·시행에 따라 일정 비율로 지원하기 시작하였으며, 2003년 7월부터 직장가입자와 지역가입자의 건강보험 재정을 통합하여 운영

1) 「국민건강보험법」 제108조의2에 따라 국가는 매년 당해연도 보험료 예상 수입액의 14%에 상당하는 금액을 일반회계에서 국민건강보험공단에 지원하여야 하며, 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항에 따라 당해연도 보험료 예상수입액의 6%에 상당하는 금액을 국민건강증진기금에서 공단에 지원하여야 한다. 두 조항 모두 2027년 12월 31일에 일몰되는 한시 규정이다.

2. 제도 개요 및 현황

- 건강보험의 운영체계는 보험자인 보건복지부 산하의 국민건강보험공단, 의료 서비스 공급기관인 의료기관, 가입자인 국민으로 구성²⁾
- 적용대상은 국내 거주 국민과 외국인 및 재외국민이며, 보험료를 부과하는 가입자의 경우 직장가입자(근로자, 공무원, 사립학교 교원) 및 지역가입자로 구분하고, 직장가입자에 생계를 의존하면서 일정 요건에 부합하는 경우 직장 피부양자³⁾에 해당
 - 2022년 기준 적용인구는 5,141만명으로 전 국민의 97.2%⁴⁾이며, 직장가입자와 지역가입자는 매년 증가 추이
- 건강보험료는 가입자 유형에 따라 서로 다른 부과체계를 적용하며, 직장가입자와 지역가입자의 형평성을 개선하기 위한 ‘소득 중심’ 부과체계 개편이 두 차례에 걸쳐 시행(2018.7., 2022.9.)
 - (직장가입자 보험료) 보수월액과 보수외소득에 보험료율을 곱하여 산정
 - (지역가입자 보험료) 소득, 재산, 자동차 등을 기준으로 정한 부과점수에 점수당 금액을 곱하여 산정
- 건강보험은 가입자와 피부양자의 질병과 부상에 대한 예방, 진단, 치료 등에 대하여 법령이 정하는 바에 따라 현물 또는 현금의 형태로 보험급여를 제공

3. 건강보험 재정구조 및 추이

- 건강보험 수입은 보험료수입, 국고지원금, 기타수입으로 구성되며, 지출은 보험급여비와 관리운영비 등으로 구성
- 2022년 기준 수입은 88.78조원, 지출은 85.15조원으로 3.63조원 당기수

2) 건강보험심사평가원은 의료기관이 진료비 심사를 청구하면 이를 심사 및 평가하는 역할을 수행한다.

3) 「국민건강보험법」 제5조제2항에 따르면, 직장가입자의 배우자, 직장가입자의 직계존속(배우자의 직계존속 포함), 직장가입자의 직계비속(배우자의 직계비속 포함)과 그 배우자, 직장가입자의 형제·자매를 포함한다.

4) 그 외는 의료급여 수급자에 속한다.

지 흑자를 보였으며, 누적 준비금은 23.87조원으로 당해연도 지출액의 3.4개월 수준을 적립

[건강보험 재정 추이: 2013~2022년]

(단위: 조원)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
수입(A)	45.17	48.50	52.40	55.72	58.00	62.12	68.06	73.42	80.49	88.78
지출(B)	41.53	43.92	48.23	52.63	57.29	62.29	70.89	73.77	77.67	85.15
재정수지(A-B)	3.64	4.59	4.17	3.09	0.71	-0.18	-2.82	-0.35	2.82	3.63
누적 준비금	8.22	12.81	16.98	20.07	20.77	20.60	17.77	17.42	20.24	23.87

주: 결산 기준

자료: 국민건강보험공단 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

4. 세부 항목별 급여 현황

- (연령군별) 고령층일수록 급여비 지출총액과 1인당 급여비 지출이 증가
 - 특히, 전기(65~74세) 및 후기(75세 이상) 고령자의 2022년 기준 1인당 급여비는 2012년 대비 각각 61%, 68% 증가한 169만원, 272만원 수준
 - 후기고령자의 2022년 기준 1인당 급여비는 55세 미만(79만원)의 5배 수준
- (자격유형별) 지역가입자의 1인당 급여비 지출이 직장가입자를 상회하며, 이는 지역가입자의 65세 이상 인구 비율이 20%로 직장가입자(15%)보다 높기 때문
 - 2022년 기준 직장 및 지역가입자의 1인당 급여비 지출액은 각각 143만원, 164만원 수준
- (요양기관종별) 종합병원의 급여비 지출 비중이 전체 요양기관 지출의 34%로 가장 높게 나타나는 등 상급병원 쏠림 현상 관찰
 - 2022년 기준 급여비는 종합병원급 26.3조원, 병원급 12조원, 의원급 23조원, 보건기관 등 0.1조원, 약국 15.3조원

Ⅲ. 건강보험 재정전망

- NABO(2023) 모형에서 건강보험 수입은 조성법, 지출은 인구구조, 소득 및 잔차 요인을 고려하는 OECD(2006, 2013) 모형을 토대로 전망
- 기본전망 전망 결과, 건강보험은 2024년부터 적자로 전환된 후 2028년에 준비금 소진이 예상되며 2032년 누적 적자액은 61.6조원에 달할 전망
 - 2023, 2024년 보험료율은 기결정된 7.09%를 준용하며 이후에는 최근 3년(2021~2023년) 평균 2.06% 증가율만큼 증가하되, 2030년에 보험료 상한 8%에 도달하는 것으로 가정

[건강보험 재정수지 및 준비금 전망: 2023~2032년]

(단위: 조원, %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	연평균 증가율
수입	93.3	98.8	106.5	114.9	123.9	133.7	144.3	155.6	165.0	175.2	7.2
지출	92.0	100.2	109.7	121.6	132.7	144.4	154.8	166.1	180.1	195.1	8.7
재정수지	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-10.7	-10.5	-10.5	-15.2	-20.0	
누적 준비금	25.2	23.8	20.6	13.9	5.2	-5.5	-16.0	-26.5	-41.6	-61.6	

주: 1. 누적 준비금은 결산상 잉여금을 뜻하며, 음수로 표기된 준비금은 준비금 소진 후 발생한 누적 적자액을 뜻함

2. 2023, 2024년 건강보험료율은 기결정된 7.09%, 2025~2032년은 매년 2.06%(최근 3년 평균)씩 인상하는 것으로 가정하되, 2030년부터 8% 상한 유지를 가정

자료: 국회예산정책처

IV. 재정전망 심층분석

- 보험료를 조정, 국고지원을 변화 등 주요 정책 변화에 따른 시나리오 구성
- 보험료를 조정에 따른 분석 결과, 보험료를 8% 상한을 폐지하는 경우 기본전망 대비 적자 전환 시점 변화는 없었으며, 향후 10년간 누적 적자액은 11조원 감소
 - 보험료를 상한 폐지는 2028년 이후 적용되므로 준비금 소진 시점의 변화 없음

[보험료를 조정에 따른 시나리오 개요]

	가정	기본전망과의 보험료율 차이	근거
기본전망	◦ (2023~2024년) 7.09% ◦ (2025~2029년) 2.06% 인상 ◦ (2030~2032) 8% 상한	-	◦ 최근 3년(2021~2023년) 평균 인상률(2.06%) ◦ 「국민건강보험법」 제73조제1항
시나리오 1	◦ (2023~2024년) 7.09% ◦ (2025~2032년) 2.06% 인상	8% 상한 폐지	-

주: 2023~2024년은 기결정 보험료율 준용

자료: 국회예산정책처

[보험료 시나리오별 재정수지 전망(2023~2032년)]

(단위: 조원)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	누적적 자 증감
기본전망 수지	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-107	-105	-105	-152	-200	-
시나리오 1: 8% 상한 폐지	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-107	-105	-102	-116	-127	11.0

주: 2023년은 예산액을 준용하므로 변동하지 않음

자료: 국회예산정책처

[보험료 시나리오별 준비금 전망(2023~2032년)]

(단위: 조원)

	준비금 소진	2032년 누적 준비금
기본전망	2028년	-61.6
시나리오 1: 8% 상한 폐지	2028년 (+0년)	-50.5 (11.0)

주: 1. 괄호는 기본전망과 각 시나리오 간 차이를 나타냄

2. 2023년은 예산액을 준용하므로 변동하지 않음

자료: 국회예산정책처

- 국고지원을 변화에 따른 분석결과, 일반회계 및 국민건강증진기금 법정 지원
을 준용 시 재정적자 전환 시점은 기본전망 대비 1~2년 연기, 향후 10년간
누적 적자액은 27.6~73.7조원 감소
- 누적 준비금 소진 시점의 경우, 법정 지원율을 준용하고 기금 단서조항을 고
려할 시(시나리오 2-1) 기본전망 대비 2년 연기, 기금 단서조항을 고려하지
않고 보험료 예상수입액의 6%를 지원할 경우(시나리오 2-2) 전망 기간 내
소진되지 않으며, 일반회계는 현행을 유지하되 기금은 보험료 예상수입액의
6%를 지원할 시(시나리오 3) 기본전망 대비 3년 연기됨

[국고지원을 변화에 따른 시나리오 개요¹⁾]

	가정	기본전망과의 국고지원을 차이	근거
기본전망	◦ (일반회계) 11.4% ◦ (기금) 담배부담금 65%²⁾	-	◦ 최근 3년(2020~2022년) 실 국고지원율 ◦ 「국민건강보험법」 제108조의2 ◦ 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항
시나리오 2-1	◦ (일반회계) 14% ◦ (기금) 담배부담금 65%²⁾	법정 지원율 준수 (기금 단서조항 ³⁾ 고려)	◦ 「국민건강보험법」 제108조의2 ◦ 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항
시나리오 2-2	◦ (일반회계) 14% ◦ (기금) 6%	법정 지원율 준수 (기금 단서조항 ³⁾ 미고려)	
시나리오 3	◦ (일반회계) 11.4% ◦ (기금) 6%	일반회계 현행 유지 및 기금 법정 지원율 준수 (기금 단서조항 ³⁾ 미고려)	

주: 1) 국고지원이 전망 기간 중 유지되는 것으로 가정함. 국고지원 규정은 2027년 12월 31일부로 일
몰 예정이지만, 과거 4차례(2011년, 2016년, 2017년, 2023년) 연장된 연혁을 고려하여
2028~2032년에도 5년간 연장되는 것으로 가정

2) 2024년 예산(안)상 담배부담금 예상수입액의 65%가 전망기간 중 유지된다고 가정

3) 기금 지원금은 당해연도 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없음

자료: 국회예산정책처

[국고지원을 시나리오별 재정수지 전망(2023~2032년)]

(단위: 조원)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	누적적 자 증감
기본전망 수지	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-10.7	-10.5	-10.5	-15.2	-20.0	-
시나리오 2-1: 법정 지원을 준수, (단서조항 고려)	1.3	0.8	-0.8	-4.1	-6.0	-7.6	-7.2	-6.9	-11.4	-16.0	(27.6)
시나리오 2-2: 법정 지원을 준수 (단서조항 미고려)	1.3	4.0	2.8	-0.1	-1.4	-2.6	-1.6	-0.7	-4.7	-8.8	(73.7)
시나리오 3: 일반회계 현행유지 (단서조항 미고려)	1.3	1.8	0.4	-2.7	-4.2	-5.6	-4.9	-4.3	-8.5	-12.7	(46.2)

주: 2023년은 예산액을 준용하므로 변동하지 않음

자료: 국회예산정책처

[국고지원을 시나리오별 준비금 전망(2023~2032년)]

(단위: 조원)

	준비금 소진	2032년 누적 준비금
기본전망	2028년	-61.6
시나리오 2-1: 법정 지원을 준수 (단서조항 고려)	2030년 (+2년)	-34.0 (27.6)
시나리오 2-2: 법정 지원을 준수 (단서조항 미고려)	전망 기간 내 미소진	12.1 (73.7)
시나리오 3: 일반회계 현행 유지 (단서조항 미고려)	2031년 (+3년)	-15.4 (18.6)

주: 2023년은 예산액을 준용하므로 변동하지 않음

자료: 국회예산정책처

□ 재정수지 균형, 준비금 소진 방지 등 재정목표 시나리오별로 필요 보험료율 분석

[필요 보험료율 분석 시나리오 개요]

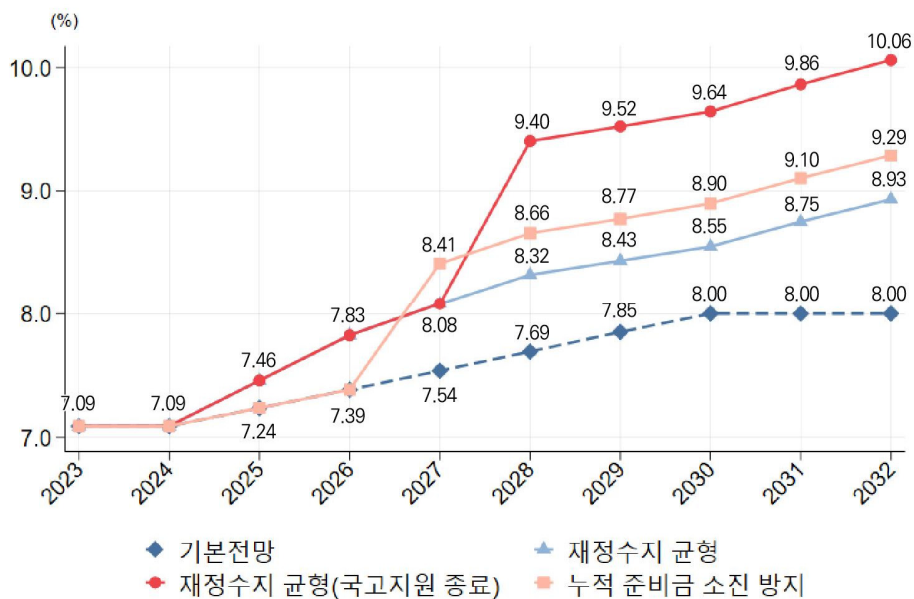
	가정	근거
기본전망	◦ (2023~2024년) 7.09% ◦ (2025~2029년) 2.06% 인상 ◦ (2030~2032년) 8% 상한	◦ 최근 3년(2021~2023년) 평균 인상률(2.06%) ◦ 「국민건강보험법」 제73조제1항
분석1	◦ 재정수지 균형 유지	◦ 단기보험의 특성
분석2	◦ 재정수지 균형 유지 ◦ 2027년 12월 31일 국고지원 종료	◦ 「국민건강보험법」 제108조의2 ◦ 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항
분석3	◦ 준비금 소진 방지 - 보험급여비의 1개월분 수준 유지 - 준비금 소진 전까지는 재정수지 적자 허용	◦ 2022~2026년 건강보험공단 중장기 재무관리계획 - 1~1.5개월 수준 유지 목표 제시

주: 2023~2024년은 기결정 보험료율 준용

자료: 국회예산정책처

□ 재정목표별 필요 보험료율은 2032년 기준 8.93~10.06%까지 증가

[재정목표별 필요 보험료율 전망 결과 요약: 2023~2032년]



자료: 국회예산정책처

V. 결론

□ 건강보험 수입 확충을 위한 건강보험 제도 및 관련 법령에 대한 논의를 개시할 필요

- (국고지원 안정화) 현재 보험료 예상 수입액 대비 국고지원율을 산출함에 따라 발생하는 국고지원금의 변동성을 줄이고 국고지원 비율을 법정 수준으로 상향하는 방안 등을 살펴볼 필요
- (국민건강증진기금 지원 현실화) 보험료 예상 수입액의 6%에 해당하는 금액을 건강보험에 지원하도록 법령에 명시되어 있지만, 단서조항⁵⁾으로 인해 2022년 결산 기준 2.4% 수준만을 지원하고 있으므로 기금 지원액의 현실화 필요
- (보험료를 상한 논의) 기본전망에서 2030년에 도달할 것으로 예상되는 보험료를 8% 상한에 대한 논의 필요

□ 건강보험 지출효율화 필요

- 수입 확충방안 마련에도 불구하고 고령화와 보장성 확대에 따른 건강보험 지출 증가율이 지속적으로 상승한다면 제도는 지속 가능하지 않음
- 행위별수가제를 근간으로 하는 현행 지불제도에서는 의료비용이 지속적으로 증가할 수 밖에 없으므로 지불 구조 개혁을 위한 구체적 안이 마련될 필요
 - 현재 7개 질병군에 대한 포괄수가제(DRG)와 정액수가제, 실포괄수가제 등이 제한적으로 시행되고 있음
 - 정부가 올 하반기 발표할 “제2차 건강보험종합계획”에 관련 방안 제시될 필요

□ 재정전망 및 결과 공개의 필요

- 건강보험은 단기성 보험이며 재정안정화를 위한 제도변수(보험료율, 보장성 범위 등) 조정이 가능할지라도, 건강보험료는 준조세의 성격을 가지므로 건강보험정책심의위원회나 정부가 제약 없이 주요 제도변수를 조정하는 것은 바람직하지 않음
- 정부의 재정전망 결과를 투명하게 공개하고 그에 기반하여 향후 제도변수 및 정책 방향에 대해 논의할 필요

5) 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항에 따라 기금지원액은 담배부담금 예상 수입액의 65%를 초과할 수 없다.

I. 서 론

1. 연구 배경 및 목적

우리나라 건강보험제도는 1989년부터 전 국민을 가입 대상으로 하는 사회보험으로 국민의 보편적 의료보장과 건강증진을 목표로 운영되고 있다. 건강보험은 가입자 보험료를 주요 재원으로 하여 국민 진료비를 보전해주는 방식으로 운용되므로 가입자 구조와 의료비 확대 등을 유발하는 대외적 환경에 민감할 수 밖에 없다.

2017년 “제4차 보장성 강화 대책” 시행 후 2017~2019년 건강보험 평균 급여비 증가율은 2017년 8.87%, 2018년 9.10%, 2019년 13.95%로 점차 증가하는 추세에 있었으나, 코로나19의 영향을 받은 최근 3년(2020~2022년)의 평균 급여비 증가율은 6.4% 수준으로 이전에 비해 증가세가 둔화되었다.¹⁾ 이는 마스크 착용, 손씻기 등 개인위생 관리가 강화되고 국민들이 의료기관 방문을 자제하는 등 전반적인 의료수요가 감소했기 때문이다.

또한 명목임금상승률 증가 등의 이유로 2021년, 2022년 보험료 수입은 약 11% 수준²⁾으로 크게 증가했으며 건강보험 재정수지는 흑자로 전환되었다. 그 결과 2022년 결산 기준 누적 준비금은 23.8조원을 기록하여 역대 최대 수준을 기록하였다.

그러나 이러한 재정수지 흑자와 준비금 수준이 지속되기는 어려울 전망이다. 엔데믹과 함께 의료체계 및 의료이용이 점진적으로 정상화되는 동시에 급격한 고령화 추세가 지속될 것으로 보이며³⁾, 향후 국민 의료비와 그에 따른 건강보험 급여비 지출은 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 더불어 고령화로 인한 생산연령인구 감소와 소득 중심 부과체계 개편(2022.9.) 시행 등으로 보험료 수입 증가율은 둔화할 것으로 보여 추후 건강보험 재정건전성이 악화될 것으로 전망된다.

건강보험 지출 확대 추이에 대응하고 수입 기반 확충을 위해 정부와 국민건강보험공단은 지출효율화 정책, 보험료율 인상, 건강보험 정부지원 규모 확대 등을 점진적으로 추

1) 보험급여비 증가율은 2020년 2.77%로 급감하고, 2021년 7.96%, 2022년 8.57%로 회복하는 추세를 보이고 있다.

2) 2017~2019년 평균 보험료 수입 증가율은 7.5% 수준이었다.

3) 통계청 「장래인구추계」(2021.12.)에 따르면 2025년에 65세 이상 인구 비중이 20.6%에 도달하여 초고령사회에 진입할 예정이며, 2032년에는 전체 인구의 27%를 차지할 전망이다.

진하고 있으나, 보험료를 8% 법정 상한 규정, 국고지원 한시 규정⁴⁾ 등 보험료 수입의 증가를 제약하는 요인들로 인해 중장기적으로는 한계에 직면할 것으로 예상된다.

이처럼 건강보험 재정이 증대한 국면을 맞이하였으나, 건강보험 재정에 대한 심도 있는 논의는 진행되고 있지 않은 실정이다. 건강보험 재정은 국민건강보험공단의 회계로 운영되고 국가재정에 포함되지 않아 국회의 감시를 받지 않기 때문이다. 건강보험에 대한 일부 의무지출⁵⁾만이 국가재정에 포함되는 심사대상이며, 그에 따라 정부의 건강보험 재정전망 결과가 투명하게 공개되지 않고 있다. 국가재정 내에서만 건강보험 현황을 파악하는 것에 한계가 있으므로 건강보험 재정 전체에 대한 별도의 검토가 필요한 상황이다.

이에 본 보고서는 코로나19와 고령화 등으로 인한 의료이용 행태 변화와 보험료를, 부과체계 개편 등의 정책 및 제도 변화를 반영하여 2023년부터 2032년까지 향후 10년간의 건강보험 재정건전성을 전망하고자 한다. 나아가 건강보험료를 상한 폐지, 국고지원 비율 등 다양한 정책 시나리오에 따른 분석과 재정목표별로 필요 보험료를 등을 제시함으로써 향후 건강보험 제도 운용 방안 및 관련 법 개정 등의 논의에 기여하고자 한다.

4) 「국민건강보험법」 제108조의2에 따라 국가는 매년 당해연도 보험료 예상 수입액의 14%에 상당하는 금액을 일반회계에서 국민건강보험공단에 지원하여야 하며, 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항에 따라 당해연도 보험료 예상수입액의 6%에 상당하는 금액을 국민건강증진기금에서 공단에 지원하여야 한다. 두 조항 모두 2027년 12월 31일에 일몰되는 한시 규정이다.

5) 정부가 건강보험가입자 지원을 위해 배정하는 국고지원금(일반회계와 국민건강증진기금)과 공무원·사립학교교원 보험료 부담금에 해당한다.

2. 연구 내용 및 방법

본 보고서는 전 국민을 가입 대상으로 하는 건강보험 제도와 가입자의 의료이용 현황 및 재정전망 결과 등을 제시한다. 특히 다양한 정책 가정에 따른 건강보험 재정의 변화를 비교 및 분석함으로써 향후 제도 운영의 시사점을 도출하고자 하였다.

보고서의 구성은 다음과 같다. 제Ⅱ장에서는 우리나라 건강보험제도와 재정 현황에 대해서 살펴본다. 1963년 의료보험으로부터 시작된 건강보험제도의 주요 변화를 살펴보고 수입 및 지출의 구성요소를 정리하여 제시한다. 또한 건강보험 수입 및 지출과 관련된 가입자, 급여 등 주요 현황을 수치로 제시하여 건강보험 제도에 대한 전반적인 정보를 제공하고자 한다.

다음으로 제Ⅲ장에서는 국회예산정책처(NABO) 건강보험 재정전망 모형에 대한 소개와 향후 10년(2023~2032년)에 대한 전망 결과를 제시한다. 재정전망은 현재의 제도와 건강보험료율 인상 추이가 유지될 경우(기본전망)를 기본으로 하며, 전망의 기본 전제와 전망에 활용한 각 변수들의 가정 등을 상세히 설명한다.

제Ⅳ장에서는 기본전망 결과를 토대로 주요 정책 변화에 따른 시나리오 분석을 수행한다. 우선 건강보험료율 법정 상한, 국고지원을 상향 등에 따른 재정 변화를 살펴본다. 다음으로 각 재정목표별로 제도를 유지하기 위해 필요한 보험료율을 도출하여 추후 제도 지속성을 위해 선택 가능한 조건들을 분석한다.

마지막으로 제Ⅴ장은 이상의 분석 내용을 요약하고 재정전망 결과의 활용방안 등을 제시한다. 재정전망 결과를 바탕으로 향후 건강보험 재정건전성 제고와 제도의 효율적 운영을 위한 제도 개선 방안 등을 제안한다.

II. 건강보험 제도 및 재정 현황

1. 연혁

우리나라 건강보험제도는 1963년 12월 「의료보험법」이 제정되면서 시작되었다. 당시 제도는 임의가입을 원칙으로 출발하였으며, 대부분 국민들의 소득수준은 의료보험 가입에 관심을 둘 만큼 높지 않았고 사회보험의 필요성에 대한 인식도 부족하여 가입률이 저조할 수 밖에 없었다. 이에 1976년 12월 「의료보험법」 개정을 통해 의무가입 조항이 추가되면서 실질적인 의료보험 체계를 갖추는 계기를 마련하였다.

1977년 7월에는 우리나라 최초로 500인 이상 사업장(486개 조합) 근로자에게 의료보험을 제공하는 직장의료보험이 실시되었다.⁶⁾ 이후 의무가입 대상은 점차 확대되어 1979년 1월에는 공무원 및 사립학교 교직원, 1988년에는 농어촌 지역, 1989년 7월에는 도시지역으로 확대 시행되어 의무가입이 시행된 1977년 이후 12년, 의료보험이 처음 도입된 지 26년 만에 전 국민 의료보험이 실현되었다.

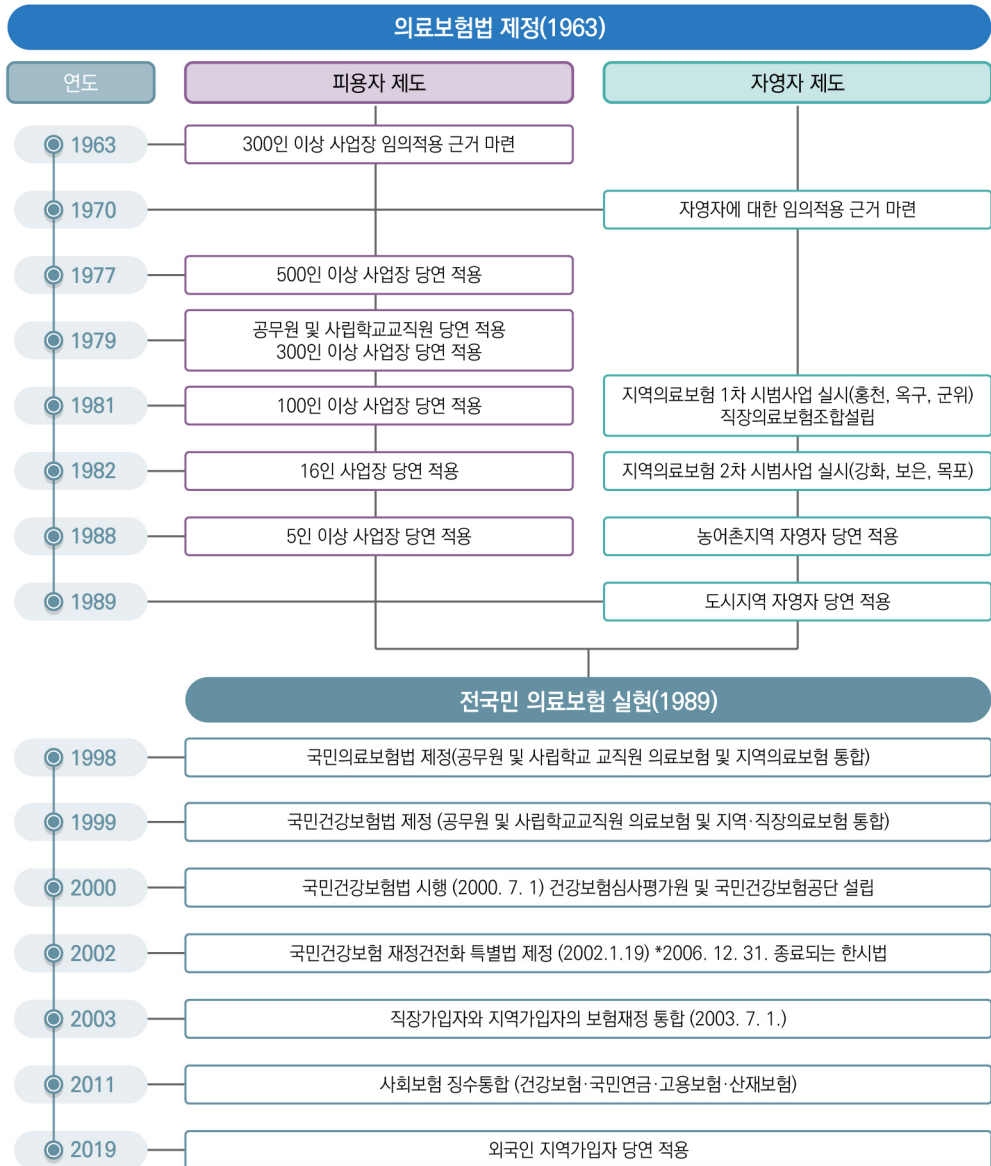
전 국민 의료보험은 100년 이상의 기간이 걸린 유럽 등 다른 국가들과 비교했을 때 단기간에 이루어낸 성과로 평가할 수 있다. 다만, 다수의 지역 및 직장조합으로 분리·운영되던 방식은 업무의 중복과 비효율, 관리비용의 낭비뿐만 아니라 상이한 보험료 부과체계로 인해 형평성 측면에서 문제가 제기되었다. 이에 1998년 공무원·사립학교교직원 의료보험과 지역의료보험조합 통합을 시작으로 2000년 7월에는 「국민건강보험법」을 시행하고 국민건강보험공단을 설립함으로써 단일보험자 조직의 관리운영체계를 마련하게 되었다.

또한 2000년에는 의약분업 실시에 따라 수가 인상 등으로 보험 지출이 크게 증가하면서 2002년 1월 19일 「국민건강보험재정건전화특별법」이 제정·시행되었으며, 건강보험 재정에 대한 국가의 지원 규정이 최초로 마련되었다. 이후 2003년 7월에는 직장가입자와 지역가입자의 건강보험 재정을 통합 운영함에 따라 현재와 같은 건강보험 제도가 확립되었으며, 이후에는 제도의 보장성을 넓히는 방향으로 운영되고 있다.⁷⁾

6) 직장의료보험은 1981년 100인 이상 사업장 근로자, 1988년 5인 이상 사업장 근로자, 2001년 모든 사업장으로 확대 적용되었다.

7) 보건복지부는 2005년부터 중장기 계획을 수립하여 총 네 차례 보장성 강화 대책을 발표하는 등 보장

[그림 1] 국민건강보험제도 주요 연혁



자료: 건강보험심사평가원

성 확대 정책을 지속해왔다. 2017년 8월 발표한 「건강보험 보장성 강화대책」의 경우 당시 누적 준비금이 20조원을 초과함에 따라 정책 추진을 위한 적기로 보았으며, 건강보험 보장률을 70%까지 확대하겠다는 목표를 제시하였다. 이후 윤석열 정부는 「필수의료 지원대책-중증·응급, 분만, 소아진료를 중심으로」(2023.1.31.)와 「건강보험 지속가능성 제고방안」(2023.2.28.)을 발표하며 필수의료에 대한 지원을 확대하되 기존 보장성 강화 항목(MRI, 초음파 등) 및 계획을 재점검할 것을 밝혔다. 구체적인 개편 방안은 2023년 하반기 발표 예정인 「제2차 건강보험종합계획(2024~2028)」에 담길 예정이다.

2. 제도 개요 및 현황

가. 운영체계

우리나라 건강보험 운영 체계는 보험자인 국민건강보험공단과 공급자인 의료기관, 가입자인 국민⁸⁾으로 구성된다. 단일 보험자인 국민건강보험공단은 보건복지부의 국고지원금과 가입자 및 사업장의 보험료를 통해 재원을 마련한다. 건강보험 가입자인 국민이 의료서비스를 이용할 경우, 진료비의 일정부분(본인부담금)을 의료기관(공급자)에 지불하고⁹⁾, 그 외 진료비(급여비)는 건강보험심사평가원의 심사·평가 후 건강보험공단이 의료기관에 지불한다.

운영 주체별로 보면, 보건복지부장관은 「국민건강보험법」 제2조에 따라 건강보험사업을 주관하며, 건강보험 관련 정책을 결정하고 건강보험 업무 전반을 총괄한다. 국민건강보험공단은 동법 제13조에 따른 건강보험의 보험자로서 가입자 자격 관리, 보험료의 부과·징수 및 보험급여의 관리 및 비용 지급 등의 업무를 수행한다. 건강보험심사평가원은 동법 제62조에 따라 요양기관으로부터 청구된 요양급여비용을 심사하고 요양급여의 적정성을 평가한다.¹⁰⁾

마지막으로 건강보험정책심의위원회¹¹⁾는 보건복지부장관 소속으로 건강보험사업에 관한 주요 정책(종합계획, 요양급여의 기준, 직장가입자의 보험료율, 지역가입자의 보험료 부과점수당 금액 등)을 심의·의결한다.

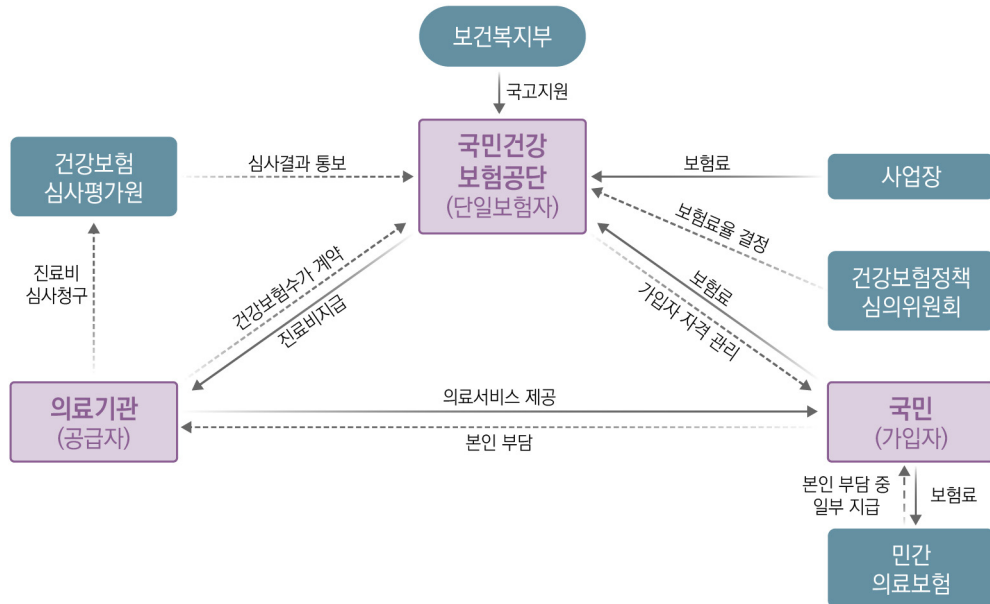
8) 「국민건강보험법」 제5조에 따라 국내에 거주하는 국민과 동법 제109조(외국인 등에 대한 특례)에 따른 국내에 체류하는 외국인과 재외국민이 가입자가 될 수 있다.

9) 민간의료보험이 있을 시 본인부담금의 일부를 민간보험회사에서 지불하기도 한다.

10) 참고로, 요양기관은 진료일로부터 3년 이내에 요양급여비용을 청구하여야 하며(법 제47조·제91조, 동법 시행규칙 제19조), 건강보험심사평가원은 심사청구를 받은 날부터 40일 이내에 심사결과통보서를 공단 및 요양기관에 송부해야 한다(법 제47조, 동법 시행규칙 제20조). 마지막으로, 심사결과통보서를 받은 공단은 지체 없이 요양급여비용을 해당 요양기관에 지급해야 한다(법 제47조, 동법 시행규칙 제20조).

11) 건강보험정책심의위원회는 「국민건강보험법」 제4조에 따라 근로자 및 사용자 대표, 시민단체·소비자단체·농어업인단체·자영업자단체 대표, 의료계 및 약업계 대표, 국민건강보험공단 이사장 및 건강보험심사평가원 원장 추천인 각 1명, 건강보험에 관한 학식과 경험이 풍부한 4명 등 25명의 위원으로 구성된다.

[그림 2] 우리나라 건강보험 운영체계



자료: 이은경, “우리나라 건강보험제도에 관한 고찰”, 「재정포럼」(2010) 자료를 바탕으로 국회예산정책처 재작성

나. 건강보험 적용대상

「국민건강보험법」 제5조·제109조에 따라 국내에 거주하는 국민과 외국인 및 재외국민은 건강보험의 가입자 또는 피부양자가 되며, 이를 통칭하여 건강보험 적용인구라고 한다.¹²⁾ 건강보험 가입자는 직장가입자와 지역가입자로 구분하며, 가입자 유형에 따라 보험료 부과방식과 자격 취득방식 등에 차이가 있다. 직장가입자는 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원, 교직원이며, 지역가입자는 직장가입자와 그 피부양자를 제외한 가입자(자영업자, 프리랜서 등)를 말한다. 피부양자는 직장가입자에게 생계를 의존하면서 소득 및 재산이 일정 요건에 해당하는 경우에 해당되며¹³⁾, 보험료를 부과하지 않는다. 반면에 지역가입자는 피부양자 제도가 없으며, 지역세대주와 지역세대원으로 구분한다.

12) 「의료급여법」 또는 「독립유공자예우에 관한 법률」 및 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따라 의료급여와 의료보호를 받는 사람은 제외하며, 이들을 모두 포함할 경우 ‘의료보장 적용인구’라고 한다.

13) 「국민건강보험법」 제5조제2항에 따르면, 직장가입자의 배우자, 직장가입자의 직계존속(배우자의 직계존속 포함), 직장가입자의 직계비속(배우자의 직계비속 포함)과 그 배우자, 직장가입자의 형제·자매를 포함한다.

[표 1] 건강보험 가입 제도 개요

	주요내용
적용 대상	국내 거주하는 국민과 국내에 체류하는 외국인 또는 재외국민 (단, 「의료급여법」에 따른 의료급여수급권자와 「독립유공자예우에 관한 법률」 및 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따라 의료보호를 받는 자는 제외)
적용 대상 구분	◦ (직장가입자) 사업장의 근로자와 사용자 그리고 공무원 및 교직원 ◦ (피부양자) 직장가입자에게 주로 생계를 의존하는 사람으로서 소득 및 재산이 일정 요건에 해당하는 자 ◦ (지역가입자) 지역세대주와 지역세대원으로 구분하며, 직장가입자 및 그 피부양자를 제외한 자영업자, 프리랜서 등 포함 ※ 외국인 및 재외국민의 경우, 6개월 이상 체류자 중 건강보험 미가입자는 지역가입자로 당연 가입 - 유학(D-2), 비전문취업(E-9), 영주(F-5), 결혼이민(F-6) 등은 입국일 가입 - 사업장의 근로자, 공무원, 교직원이고 일정 요건 충족 시 직장가입자 가입
건강보험 적용인구	2022.12월 기준 5,141만명(의료보장인구의 97.2%)

자료: 국회예산정책처

[표 2] 건강보험 가입유형별 적용인구 현황

(단위: 천명, 천세대, %)

		2018	2019	2020	2021	2022	연평균 증가율
합계		51,072	51,391	51,345	51,412	51,410	0.17
직장	소계	36,990	37,227	37,150	37,180	36,633	-0.24
	가입자	17,480	18,123	18,543	19,090	19,594	2.90
	피부양자	19,510	19,104	18,607	18,090	17,039	-3.33
	부양률(명)	1.12	1.05	1.00	0.95	0.87	-6.12
지역	소계	14,082	14,164	14,195	14,232	14,777	1.21
	세대수	6,678	6,957	7,133	7,335	7,702	3.63
	세대원	7,404	7,207	7,062	6,897	7,075	-1.13
	부양률(명)	1.11	1.04	0.99	0.94	0.92	-4.59

주: 연도 말 적용인구 기준, 직장가입자는 이중가입자 포함, 세대수는 비가입세대주 제외

자료: 보건복지부와 국민건강보험공단 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 제작성

건강보험 적용인구는 2018년 5,107만명에서 2022년 5,141만명으로 최근 5년간 연평균 0.17%의 완만한 증가율을 보였다. 가입자 유형별로 보면, 직장가입자 수는 매년 꾸준히 증가(연평균 2.9%)하여 2022년 1,959만명에 이르는 반면에 직장 피부양자 수¹⁴⁾는 지속적으로 감소하여 2022년 1,704만명 수준을 보인다. 이는 2018년 7월과 2022년 9월에 시행된 건강보험료 부과체계 개편으로 피부양자의 인정기준과 범위가 강화된 결과로 파악된다. 그에 따라 직장가입자 1명당 부담하는 피부양자 비율인 부양률은 2018년 1.12명에서 2022년 0.87명으로 감소하였다.

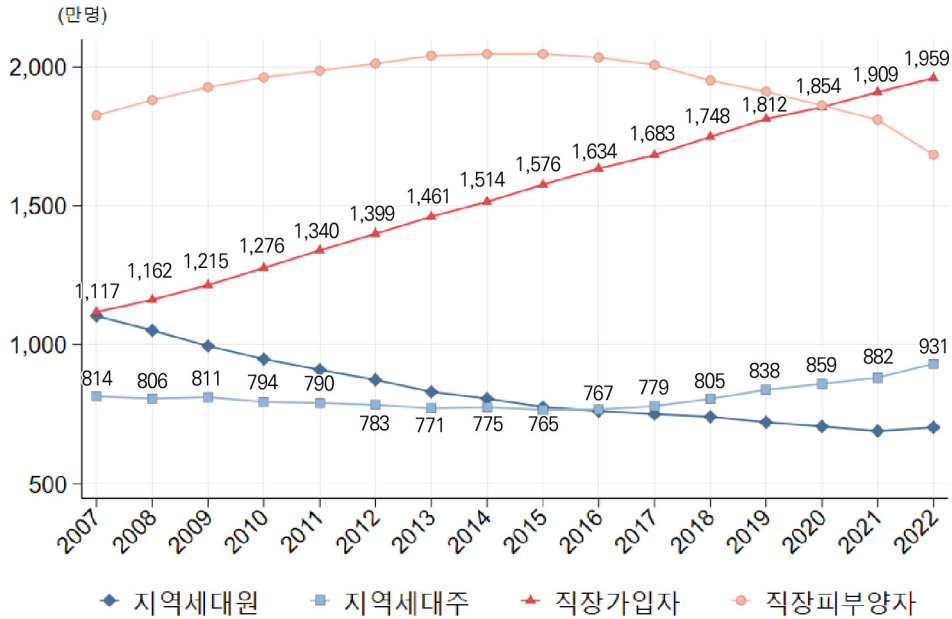
지역가입자의 경우 연평균 3.63%씩 증가하여 2022년 7,702세대에 달했으나, 각 세대에 속한 세대원¹⁵⁾ 수는 연평균 1.13%씩 감소하는 추세이다. 이는 최근 1인 가구 증가 추세가 반영된 것으로 보인다. 지역가입자 부양률도 2018년 1.11명에서 2022년 0.92명으로 감소하였으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 보인다.

14) 「국민건강보험법」 제5조제2항제1항의 피부양자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 직장가입자에게 주로 생계를 의존하는 사람으로서 소득 및 재산이 보건복지부령으로 정하는 기준 이하에 해당하는 사람을 말한다.

1. 직장가입자의 배우자
2. 직장가입자의 직계존속(배우자의 직계존속을 포함한다)
3. 직장가입자의 직계비속(배우자의 직계비속을 포함한다)과 그 배우자
4. 직장가입자의 형제·자매

15) 「국민건강보험법」 제77조제2항에 따르면, 지역가입자의 보험료는 그 가입자가 속한 세대의 지역가입자 전원(미성년자 제외)이 연대하여 납부하여야 하므로 직장가입자와 같은 피부양제도는 없다. 다만, 보험료의 실질적 부과는 세대주를 대상으로 이루어지며, 국민건강보험공단 통계연보에서도 지역가입자의 부양률 현황을 제공하고 있으므로 본 보고서에서도 참고자료로 제공한다.

[그림 3] 가입유형별 가입자 수 추이: 2007~2022년



자료: 국민건강보험공단 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

다. 건강보험료 부과체계¹⁶⁾

건강보험료는 직장가입자와 지역가입자 간에 서로 다른 방식으로 산정된다. 직장가입자의 경우 소득에 기반한 부과체계로, 보수월액에 대한 보험료와 보수외소득에 대한 보험료를 합하여 산정한다. 보수월액 보험료는 가입자의 보수월액에 보험료율을 곱하여 보험료를 산정하며, 해당자의 경우 경감률¹⁷⁾ 등을 적용하여 가입자 단위로 부과한다. 보수외소득 보험료는 보수월액에 포함된 보수를 제외한 직장가입자의 소득(이자·배당·사업·기타소득 및 근로·연금소득)에서 연간 2,000만원을 초과하는 금액에 대해 월 단위(12)로 나누고 소득평가율¹⁸⁾과 보험료율을 곱하여 산출한다. 2023년 기준 보험료율은 7.09%이며, 매년 「국민건강보험법 시행령」에 따라 월별 보험료의 상한과 하한 금액을

16) 국민건강보험공단 홈페이지 및 「국민건강보험법」, 동법 시행령을 참조하여 작성하였다.

17) 「국민건강보험법」 제75조에 따라 보건복지부령으로 정하는 가입자에 대하여 보험료의 일부를 경감해주고 있다. 건강보험료 경감 종류에는 국외근무자 경감, 섬·벽지 경감, 군인 경감, 휴직자 경감, 임의계속가입자 경감 등이 있다.

18) 이자·배당·사업·기타소득은 「소득세법」에 따라 산정한 소득금액 100%, 근로·연금소득은 「소득세법」에 따른 소득의 금액 합계액 50%를 보수외소득 산정에 포함한다.

설정한다.¹⁹⁾ 전체 보험료의 절반은 사업주가, 나머지 절반은 가입자 본인이 납부한다. 이때, 가입자가 공무원인 경우 보험료의 절반을 소속된 국가 또는 지방자치단체가 부담하며, 사립학교 교원의 경우 국가가 총 보험료의 20%, 소속 법인이 30%를 부담한다.

지역가입자의 건강보험료는 가입자의 소득, 재산(전월세 포함), 자동차 등을 기준으로 정한 부과요소별 점수를 합산한 보험료 부과점수에 점수당 금액을 곱하여 산정하되, 연소득 336만원을 기준으로 부과 방식을 달리한다.²⁰⁾ 2023년 기준 점수당 금액은 208.4원이며, 재산점수는 60등급, 자동차 점수는 차량 잔존가액이 4천만원 이상인 승용차만을 대상으로 사용연수(3등급) 및 배기량별(7등급) 21등급을 고려하여 산정한다. 직장가입자와 달리 지역가입자 보험료 전액을 본인이 부담한다.

[표 3] 건강보험료 부과 방식(2023년 기준)

	직장가입자	지역가입자
부과기준	◦ 보수월액과 보수외소득* (연간 2,000만원 초과 시) * 보수외소득: 종합과세되는 이자·배당·사업·근로·연금·기타소득	◦ 소득*, 재산**, 자동차 * 이자·배당·사업·근로·연금·기타소득 ** 주택·건물·토지·전세금·월세 등
보험료 산정	◦ (보수월액×건강보험료율) + (소득월액*×건강보험료율) * (연간 보수외소득 중 2,000만원 초과분 × 1/12)×소득평가율** ** 이자·배당·사업·기타소득: 100%, 근로·연금소득: 50%	◦ (보험료 부과점수*×점수당 금액) - 소득점수는 소득에 건강보험료율을 곱한 것과 동일하게 보험료가 산정되도록 설정(정률제) * 재산 60개 등급, 자동차 사용연수 및 배기량 별 21개 등급
보험료 부담	◦ 보수월액: 사용자 50%, 근로자 50% ◦ 소득월액: 소득월액은 근로자 본인 100% 부담	◦ 지역가입자(세대주, 세대원) 100%
	◦ 피부양자* 제도 존재 * 직장가입자에게 주로 생계를 의존하는 사람으로, 보험료를 부담하지 않음	◦ 지역가입자 모든 세대원의 재산, 소득 등을 포괄하여 보험료를 부과하며, 전원이 보험료를 부담할 의무가 있음

자료: 「국민건강보험법」, 「국민건강보험법 시행령」 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

19) 2023년 기준 보수월액 상한은 전전년도 직장 평균 보수월액 보험료의 30배(7,822,560원), 하한은 전전년도 직장평균 보수월액보험료의 8%수준(19,780원)이다. 소득월액 상한은 전전년도 직장 평균 보수월액 보험료의 15배(3,911,280원)이며, 하한은 정하지 않는다.

20) 연 소득 336만원 이하 세대는 지역가입자의 월별 보험료 하한액 19,780원 부과, 336만원 초과~6억 6,199만원 이하 세대는 95.25911708점+(336만원을 초과하는 소득 1만원 당 1만분의 2,835.0928점), 6억 6,199만원 초과 세대는 18,768.13점을 적용한다.

[참고] 부과체계 1·2단계 개편²¹⁾

- 현재의 부과제도는 두 차례(2018.7., 2022.9.)에 걸쳐 추진된 부과체계 개편 정책에 따른 결과이며, 저소득층의 건강보험료 부담을 경감시키고 직장가입자와 지역가입자의 형평성을 개선하기 위해 ‘소득 중심’ 부과체계를 구축하는 것을 골자로 함

[참고표] 건강보험 부과체계 개편 주요 내용

		1단계 개편 (2018.7)	2단계 개편 (2022.6)
지역 가입 자	소득 보험료	소득, 재산, 자동차 각각에 대한 등급별 점수제	소득: 정률제 재산, 자동차: 등급별 점수제
	최저 보험료	연소득 100만원 이하 (14,650원/월)	연소득 336만원 이하 (19,500원/월) ※ 직장가입자와 일원화
	공적연금·일시 근로소득 평가율	30%	50%
	재산 보험료	500~1,200만원 공제	5,000만원 공제
	자동차 보험료	1,600cc 이하 소형차 면제 1,600cc 초과 3,000cc 이하 자동차 보험료 30% 인하	4,000만원 이상 차량만 부과
직장 가입 자	보수외소득 보험료 부과	3,400만원 초과 시	2,000만원 초과 시
	보험료 상한	前前년도 직장가입자 평균 보수월액보험료의 30배 ※ 직장(보수, 보수 외 소득)보험료 및 지역보험료 동일 적용)	
피부 양자	연소득 탈락 기준	3,400만원 초과 (2인 가구 기준중위소득 100%)	2,000만원 초과 (2인 가구 기준중위소득 60%)
	재산 탈락 기준	과표 9억원 초과 혹은 과표 5.4억원 초과&연 소득 1천만원 이상 취약계층 제외하고 형제·자매 피부양자 탈락	
	형제·자매 인정기준	65세 이상, 30세 미만, 장애인 (국가유공·보훈대상 상이자 포함) 형제·자매 중 소득·재산 기준 충족 시 인정	
	피부양자 경감	피부양자 보험료 30% 경감	1년차 80%, 2년차 60%, 3년차 40%, 4년차 20% 경감

자료: 국회예산정책처, 「NABO 재정추계&세제 이슈」, 2022, pp. 73~79를 재편집함

21) 부과체계 개편에 대한 구체적인 내용과 재정변화는 국회예산정책처(2022) pp. 73~79 참조

라. 건강보험 급여

(1) 의료비 구조

건강보험 가입자가 부담하는 의료비의 구조를 이해하기 위해서 OECD 국민보건계정 작성 기준(System of Health Accounts 2011)에 따른 경상의료비 개념을 살펴본다. 경상의료비는 보건의료서비스와 재화의 소비를 위한 국민 전체의 1년 간의 지출 총액으로, 재원별 분류에 따라 공공의료비와 민간의료비로 구분한다. 건강보험 지출은 공공의료비의 대부분을 차지하며, 건강보험 외 의무가입보험에는 장기요양보험, 산재보험 등이 포함된다. 민간의료비의 경우 가계직접부담과 임의가입제도로 구분되며, 임의가입제도에는 민간의료보험이 해당된다.²²⁾

건강보험 가입자가 의료기관에서 요양급여 서비스를 받을 경우, 전체 진료비(그림의 (D))²³⁾ 중 일부인 본인부담금(B)만을 부담하게 되며, 그 외의 비용은 공단이 부담(A)하게 된다. 반면에, 요양급여 대상이 아닌 비급여 의료서비스를 받을 시에는 의료비용 전액을 가입자가 부담(C)한다. 따라서 의료비는 공단과 가입자가 부담하는 급여 및 비급여 총액으로 이해할 수 있다.

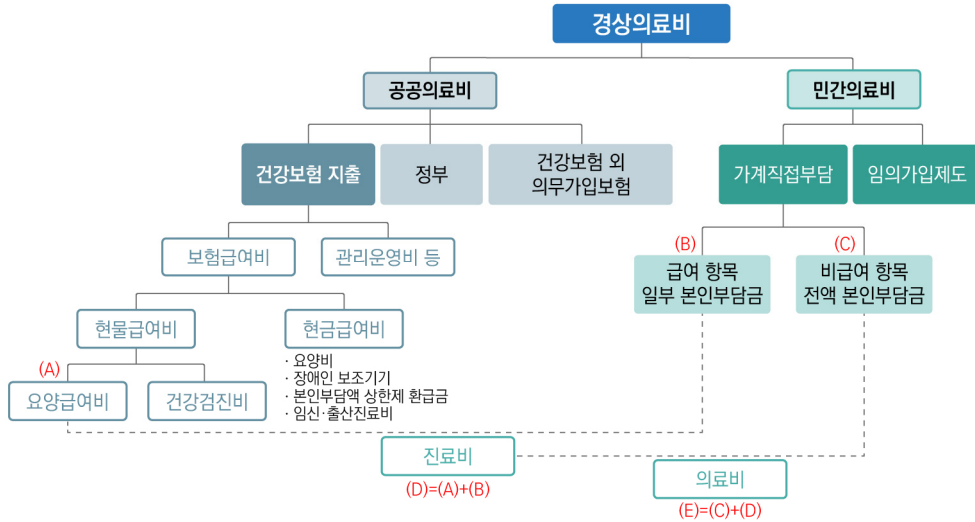
건강보험은 진료행위와 치료재료의 경우 전체 항목 중 비급여 대상으로 지정한 항목을 제외하고 모두 요양급여대상이 되는 ‘비급여목록 제도(Negative List System)’를 적용하고 있으며, 약제의 경우 보건복지부장관이 고시한 항목만 요양급여대상이 되는 ‘선별등재목록 제도(Positive List System)’로 운영하고 있다.²⁴⁾

22) 보건복지부, 「2020년 국민보건계정」(2022)

23) 진료비는 ‘요양급여비용’ 이라고도 하나, ‘보험급여비’의 하위분류인 ‘요양급여비’와 용어 혼동의 가능성이 있으므로 본 보고서에서는 진료비로 통일한다.

24) 김윤희, 「건강보험 보장성 강화대책 재정추계」, 국회예산정책처, 2017, p.10

[그림 4] 의료비 구조



주: 위 분류는 OECD 국민보건계정 체계를 기반으로 함. 경상의료비는 재원별 분류에 따라 공공의료비 (집합보건의료비)와 민간의료비(개인의료비)로 구분할 수 있는데, 공공의료비의 대부분을 차지하는 건강보험 지출 구성을 시각적으로 파악하고자 지출의 구성요소를 병기함
 자료: 국회예산정책처

[표 4] 의료기관 종별, 환자 구분별 본인부담률

	환자 구분	본인부담률		종별	환자구분	본인부담률	
입원	일반환자	20%	외래	상급 종합 병원	일반	진찰료 100% (그 외 60%)	
	고위험임신부	10%			임신부	40%	
					1세 미만	20%	
	제왕절개	5%		종합 병원	일반	50% (읍면지역 45%)	
					임신부	30%	
					1세 미만	15%	
	15세 이하 아동	면제		병원급	일반	40% (읍면지역 35%)	
	임신부				20%		
	1세 미만				10%		
	자연분만	면제		의원	65세 미만	일반	30%
	신생아					임신부	10%
뇌사자 장기 적출 등	1세 미만		5%				
요양병원 선택입원군	40%			65세 이상	노인외래정책제		

자료: 보건복지부

(2) 건강보험 급여 구조

건강보험은 가입자 및 피부양자의 질병과 부상에 대한 예방, 진단, 치료, 재활, 출산, 사망 및 건강증진에 대하여 법령이 정하는 바에 따라 현물 또는 현금의 형태로 보험급여를 제공하고 있다.

[표 5] 건강보험 보험급여 유형

법안	내용	수급권자
현물급여	요양급여	가입자 및 피부양자
	건강검진	가입자 및 피부양자
현금급여	요양비	가입자 및 피부양자
	장애인 보조기기	가입자 및 피부양자 중 장애인복지법에 의해 등록한 장애인
	본인부담액 사후환급금	가입자 및 피부양자
	임신·출산 진료비	임신·출산 진료비 수급권자 - 임신·출산(유산·사산 포함)이 확인된 건강보험 가입자 또는 피부양자 - 2세 미만인 가입자 또는 피부양자의 법정대리인 (출산한 가입자 또는 피부양자가 사망한 경우에 한정)

자료: 보건복지부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 재작성

현물급여는 요양급여와 건강검진을 포함한다. 이때, 요양급여는 건강보험 가입자 및 피부양자가 의료기관과 약국 등에서 제공받는 진찰·검사, 약제·치료재료, 처치·수술 및 치료, 예방·재활, 입원, 간호 및 이송(移送) 서비스 일체를 말한다. 한편, 요양급여는 의료행위에 따라서는 기본진료료, 진료행위료, 약품비, 치료재료비로 구분하기도 한다.

현금급여는 요양비, 본인부담상한제 사후환급금 등과 같이 가입자와 피부양자 중 해당자에게 직접 지급하는 급여를 말한다. 요양비는 요양기관이 아닌 곳에서 질병·부상·출산 등에 대하여 요양을 받는 경우 지급하며, 본인부담상한액은 본인부담금의 총액이 대통령령으로 정한 본인부담상한액보다 높을 경우 그 초과 금액을 지급한다.²⁵⁾

2022년 기준으로 보험급여비 각 항목별 규모를 살펴보면, 현물급여비가 보험급여비의 96.5%로 대부분을 차지하며, 현금급여비는 3.5%에 불과하다. 현물급여비 중에서도 요양급여비가 전체의 94.1%로 비중이 가장 높고 건강검진비는 2.4%로 일부에 해당한다. 보험급여비의 각 항목별 비중은 연도별로 큰 차이가 없으나, 요양비, 본인부담액상한제 사후환급금, 임신·출산 진료비 등의 현금급여비 비중은 2018년 2.5%에서 2022년 3.5%로 소폭 상승하였다. 이는 최근 본인부담액상한제나 임신·출산 진료비 지원 등 가입자 의료비 부담을 경감하기 위한 제도의 범위가 확대되고 있음을 시사한다.

[표 6] 하위분류별 보험급여비 추이: 2018~2022년

(단위: 조원, %)

	2018	2019	2020	2021	2022
보험급여비 (A=B+E)	61.67 (100.0)	68.73 (100.0)	69.35 (100.0)	74.61 (100.0)	81.53 (100.0)
현물급여비 (B=C+D)	60.14 (97.5)	66.83 (97.2)	67.10 (96.8)	71.99 (96.5)	78.71 (96.5)
요양급여비 (C)	58.58 (95.0)	65.17 (94.8)	65.47 (94.4)	70.17 (94.0)	76.72 (94.1)
건강검진비 (D)	1.56 (2.5)	1.66 (2.4)	1.63 (2.4)	1.83 (2.5)	1.98 (2.4)
현금급여비 (E)	1.53 (2.5)	1.90 (2.8)	2.25 (3.2)	2.61 (3.5)	2.82 (3.5)

주: 1. 지급기준 작성(보험급여비 세부항목은 현금흐름으로 산출 불가)

2. 괄호 안은 보험급여비 대비 비중

자료: 국민건강보험공단

25) 국민건강보험공단·건강보험심사평가원, 「2020 건강보험통계연보」, 2021, p.775

(3) 건강보험 수가

우리나라 건강보험 지불제도는 의료인이 제공하는 의료서비스(행위, 약제, 치료재료 등)에 대해 서비스별로 가격(수가)을 정하고 사용량과 가격에 의해 진료비를 지불하는 행위별수가제(fee-for-service)를 기본으로 한다. 수가는 행위별 상대가치 점수에 환산지수(점수당 단가)와 가산율²⁶⁾을 곱하여 산출한다. 상대가치 점수는 요양급여에 드는 시간·노력 등 업무량과 자원의 양, 사회적 편익 등을 고려하여 각 급여의 가치를 상대적인 점수로 나타내는 것이며, 개편 필요(원칙상 5년 주기)에 따라 건강보험정책심의위원회의 심의·의결을 거쳐 고시한다.²⁷⁾ 환산지수는 매년 건강보험정책심의위원회에서 공단과 의료단체가 협상을 거쳐 계약을 체결하며, 2008년부터는 의료기관 유형별로 각각 결정되고 있다. 마지막으로 가산율은 의료기관 종별, 의료서비스 제공 시간 등에 따라 추가로 부여되는 비율이다. 수가를 구성하는 요소 중 환산지수만이 매년 변화하므로, 일반적으로 환산지수 인상률을 건강보험 수가 인상률로 간주한다.

수가는 2020년까지 2%대 수준으로 소비자물가상승률보다 높은 경향을 보였으나, 2021년 이후에도 물가상승률이 예년보다 높아짐에 따라 수가상승률은 물가상승률을 하회하고 있다. 2024년 수가는 2023년 6월 결정되었으며, 종별 평균은 1.98%, 병원급은 1.9%, 의원급 1.6% 등 인상되었다. 의료 수요량과 공급량이 동일하게 유지될 때, 수가 인상은 요양급여비 증가를 유발하며, 이는 건강보험 총지출 증가에 영향을 미칠 수 있다.

26) 의료기관 종별, 진료시간 등에 따른 가산율을 말한다.

27) 상대가치점수는 2001년 도입 후, 1차 개정연구(2003~2006년) 수행 후 5개년(2008~2012년)에 걸쳐 단계적 개정을 거쳤으며, 2차 개정연구(2010~2016년) 수행 후 4개년(2017~2020년)에 걸쳐 2차 개정을 반영하였다. 이후 2018~2020년 기간 동안 3차 개정연구를 수행하였으며, 이를 기반으로 3차 개편을 추진 중이다.

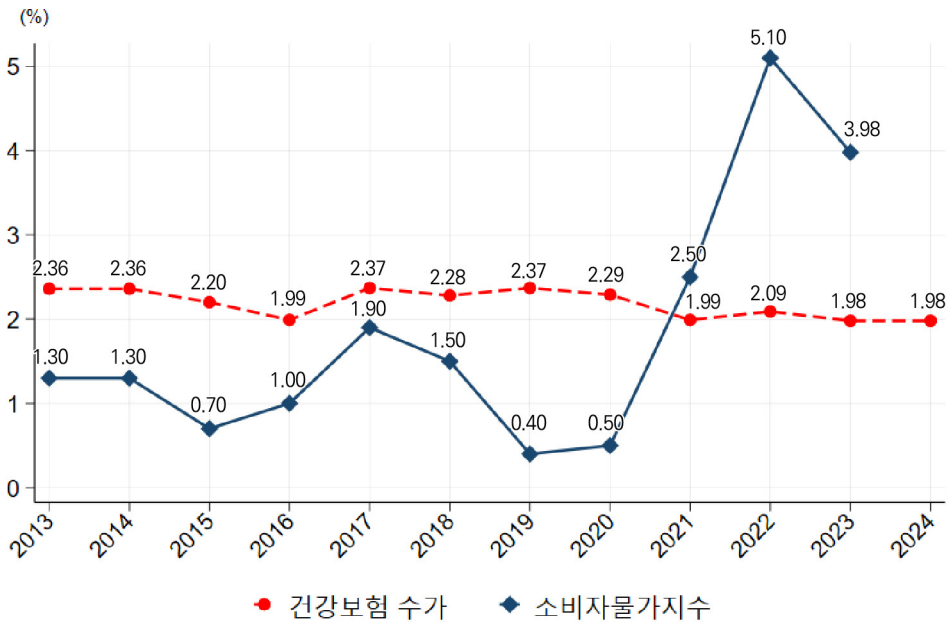
[표 7] 의료기관 유형별 수가 인상률 추이: 2018~2024년

(단위: %)

구분	평균	병원	의원	치과	한방	약국	보건기관	조산원
2018	2.28	1.7	3.1	2.7	2.9	2.9	2.8	3.4
2019	2.37	2.1	2.7	2.1	3.0	3.1	2.8	3.7
2020	2.29	1.7	2.9	3.1	3.0	3.5	2.8	3.9
2021	1.99	1.6	2.4	1.5	2.9	3.3	2.8	3.8
2022	2.09	1.4	3.0	2.2	3.1	3.6	2.8	4.1
2023	1.98	1.6	2.1	2.5	3.0	3.6	2.8	4.0
2024	1.98	1.9	1.6	3.2	3.6	1.7	2.7	4.5

자료: 보건복지부

[그림 5] 건강보험 수가 및 소비자물가지수 인상률 추이



주: 2023년 소비자물가지수는 상반기 기준임

자료: 보건복지부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

3. 건강보험 재정구조 및 추이

건강보험 재정은 다른 사회보험들과 달리 사업관리운용기관인 국민건강보험공단(이하 “공단”이라고 함) 회계로 편성되며 국가재정에 포함되지 않는다. 공단은 「국민건강보험법」 제36조에 따라 회계연도마다 예산안을 편성하여 이사회의 의결을 거친 후 보건복지부장관의 승인을 받는다. 건강보험 수입(수익)은 가입자가 납부하는 보험료 수입과 국고지원금, 기타수입으로 구성되며, 지출(비용)은 보험급여비와 관리운영비 등으로 구분된다.

가. 총괄

최근 10년의 건강보험 재정 추이를 살펴보면, 2017년까지 흑자를 유지하였으나 2018년부터 적자로 전환되어 3년간(2018~2020년) 누적 3.36조원의 재정수지 적자를 기록한 후 2021년 이후 다시 흑자로 전환되었다. 이는 문재인 정부의 “4차 보장성 강화 대책”(2017.8.)의 본격 이행에 따라 2018년 보험급여비 등의 지출이 수입 대비 큰 폭으로 증가한 것에 기인한다.²⁸⁾ 이후 코로나19 확산에 따른 의료이용 감소²⁹⁾와 높은 보험료 수입 증가율로 2021년과 2022년은 다시 흑자로 전환되었다. 2022년 말 기준 준비금³⁰⁾은 23.87조원으로, 당해연도 지출액의 3.4개월 수준을 적립하고 있다.

28) 보건복지부는 「건강보험 보장성 강화대책」(2017.8.)과 「제1차 건강보험종합계획」(2019.5.)에서 치료에 필요한 비급여 항목의 급여화 등 건강보험 보장성을 지속적으로 확대(초음파, MRI, 선택진료비 폐지 등 47개 항목 급여화 등)하겠다고 발표하였으나, 윤석열 정부 출범 후 「건강보험 지속가능성 제고방안」(2023.2.28.) 발표를 통해 잔여 급여화 검토 대상 항목과 기급여화 항목의 재검토 계획을 밝혔다.

29) 마스크 착용, 손씻기 등 개인위생 관리가 강화되고 국민들의 의료기관 방문이 감소하는 등 전반적인 의료수요가 감소하였다.

30) 준비금은 결산상의 잉여금을 적립한 금액을 의미하며, 「국민건강보험법」 제38조제2항에 따라 준비금은 부족한 보험급여 비용에 충당하거나 지출할 현금이 부족할 경우에만 사용할 수 있다.

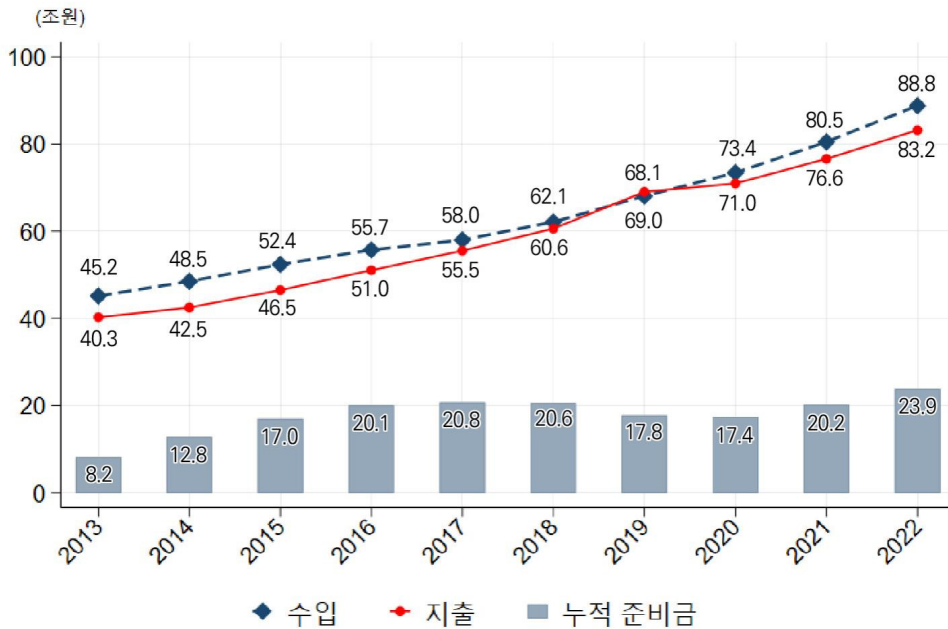
[표 8] 건강보험 재정 추이: 2013~2022년

(단위: 조원)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
수입(A)	45.17	48.50	52.40	55.72	58.00	62.12	68.06	73.42	80.49	88.78
지출(B)	41.53	43.92	48.23	52.63	57.29	62.29	70.89	73.77	77.67	85.15
재정수지(A-B)	3.64	4.59	4.17	3.09	0.71	-0.18	-2.82	-0.35	2.82	3.63
누적 준비금	8.22	12.81	16.98	20.07	20.77	20.60	17.77	17.42	20.24	23.87

자료: 국민건강보험공단 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

[그림 6] 건강보험 재정수지 추이: 2013~2022년



자료: 국회예산정책처

나. 건강보험 수입 구조 및 현황

건강보험 수입은 보험료수입과 국고지원금, 기타수입으로 구성된다.

[표 9] 건강보험 재정구조 개요

항목			내용
수입	보험료 수입	직장 보험료	- 직장가입자부담금 - 직장가입자(근로자)가 납부하는 보험료(총 보험료의 100분의 50) - 임의(계속)가입자가 납부하는 보험료(총 보험료의 100분의 50) - 소득월액보험료(보수 외 종합과세소득이 2,000만원 이상인 직장가입자에게 추가 부과되는 보험료) - 사용자부담금 - 직장가입자(근로자)가 소속되어 있는 사업장의 사업주가 납부하는 보험료(총 보험료의 100분의 50)
		공무원·교원 보험료	- 가입자부담금 - 공공가입자가 납부하는 보험료(총 보험료의 100분의 50) - 국가부담금 - 공무원의 경우 소속된 국가 또는 지방자치단체가 부담하는 보험료(총 보험료의 100분의 50) - 사립학교 교원의 경우 국가가 부담하는 보험료(총 보험료의 100분의 20) - 사립학교 법인 부담금 - 사립학교 교원의 경우 소속 법인이 부담하는 보험료(총 보험료의 100분의 30)
		지역 보험료	지역가입자가 납부하는 보험료(보험료 부과점수×부과점수당 금액) * 보험료부과점수: 소득 및 재산을 기준으로 산정하는 점수
	국고지원금	일반 회계	- 해당 연도 보험료 예상 수입액의 14%에 상당하는 금액 * 「국민건강보험법」 제108조의2 - 과징금³¹⁾ 수입의 50%³²⁾ * 「국민건강보험법」 제99조 및 「국민건강보험법 시행령」 제71조제1항제1호
		국민 건강 증진 기금	- 해당 연도 보험료 예상 수입액의 6%에 상당하는 금액(단, 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없음) * 「국민건강보험법」 제108조의2 및 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항
	기타수입		연체금, 기타징수금, 이자수입 등

자료: 보건복지부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 재작성

31) 요양기관이 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 보험자나 가입자, 피부양자에게 요양급여비용을 부담하게 한 경우 부과한다.

32) 건강보험에 대한 과징금 수입 지원 규정을 삭제하는 시행령 개정안이 2023년 11월 시행될 예정이다.

(1) 보험료 수입

건강보험료는 건강보험 가입자를 대상으로 부과되며, 가입자 유형별로 부과체계에 따라 보험료를 납부한다.

직장가입자의 건강보험료율은 「국민건강보험법」 제73조제1항에 따라 8% 상한 내에서 건강보험정책심의위원회의 의결을 거쳐 정해진다. 보험료율은 통상 매년 8월 말 결정되며,³³⁾ 2023년 보험료율은 7.09%로 전년 대비 1.49% 인상, 2024년 보험료율은 동결되었다. 2018년 이후 보험료율은 보장성 강화 등 지출 증가 요인으로 인해 매년 인상되었으나, 2024년 보험료율은 2017년 이후 7년 만에 동결이 결정되었다. 보건복지부는 현재 건강보험 재정이 비교적 안정적인 상태이며 어려운 국민경제 여건을 고려하여 건강보험료율을 동결하기로 했다고 밝혔다.³⁴⁾

지역가입자의 보험료를 결정하는 부과점수당 금액 또한 동법 제73조제3항에 따라 건강보험정책심의위원회의 의결을 통해 정해진다. 부과점수당 금액은 2017년 179.2원에서 2023년 208.4원으로 인상되었으며, 건강보험료율과 동일하게 2024년은 동결되었다.

[표 10] 보험료율 및 부과점수당 금액 추이: 2017~2023년

(단위: %, 원)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
보험료율	6.12 (0.00)	6.24 (2.04)	6.46 (3.49)	6.67 (3.20)	6.86 (2.89)	6.99 (1.89)	7.09 (1.49)	7.09 (0.00)
부과점수당 금액	179.2 (0.00)	183.3 (2.29)	189.7 (3.49)	195.8 (3.22)	201.5 (2.91)	205.3 (1.89)	208.4 (1.51)	208.4 (0.00)

주: 괄호 안은 인상률을 의미함

자료: 보건복지부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

33) 최근 10년(2013~2023년)간 건강보험료율은 매년 8월 말 건강보험정책심의위원회에서 의결되었으나, 올해 8월(2023.8.) 위원회에는 '보험료 인상 동결안'과 '낮은 인상폭' 간의 이견으로 인해 2024년도 보험료율이 안건으로 상정되지 않았다. 이후 2024년 건강보험료율은 제19회 건강보험정책심의위원회(2023.9.26.)에서 동결하는 것으로 결정되었다.

34) 또한 2011년부터 2016년까지 건강보험은 지속적인 흑자를 보였으며, 2016년 누적 준비금이 20조원에 달하면서 2017년 보험료율은 동결되었다.

(2) 국고지원금

현행 건강보험에 대한 국고지원은 보건복지부의 “건강보험 가입자지원(일반회계)” 사업과 “건강보험가입자지원(국민건강증진기금)” 사업을 통해 수행되고 있다. 일반회계의 경우, 「국민건강보험법」 제108조의2에 따라 당해연도 보험료 예상 수입액의 14%에 상당하는 금액과 과징금 수입의 50%에 해당하는 금액을 지원하고 있다.³⁵⁾ 국민건강증진기금의 경우, 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항에 따라 당해연도 보험료 예상 수입액 6%에 상당하는 금액을 지원할 것을 명시하는 한편, 당해연도 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없음을 단서조항으로 명시하고 있다.

[표 11] 건강보험에 대한 국고지원 관련 법령 연혁

	법령	내용	용도
'00 ~ '01	◦ 「국민건강보험법」 제92조	◦ 국가는 건강보험사업의 운영에 필요한 비용 부담할 수 있음	◦ 일반회계에서 지역보험급여비와 지역가입자 관리운영비 지원
'02 ~ '06	◦ 「국민건강보험재정건전화 특별법」 제15조	◦ 지역가입자 보험급여비의 50% 지원(일반회계 40%, 건강증진기금 10% 지원, 2005년 이후 일반회계 35%, 건강증진기금 15%)	◦ 일반회계: 지역보험급여비, 지역가입자 관리운영비 ◦ 담배부담금: 65세 이상 노인급여비
'07 ~ 현재	◦ 「국민건강보험법」 제92조 (이후 제108조, 제108조의2로 개정) ◦ 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항 ※ 한시적 특례 조항	◦ 당해연도 보험료 예상수입액의 20%에 상당하는 금액을 지원(일반회계 14%, 건강증진기금 6%) ◦ 건강증진기금 지원 금액의 경우 지원금액이 당해 연도 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없도록 하는 단서조항 존재	◦ 일반회계: 가입자 등 보험급여비, 건강보험 관리운영비, 보험료 경감에 대한 지원 ◦ 담배부담금: 건강검진 등 건강증진 사업, 흡연 질병 급여비, 65세 이상 노인급여비

자료: 보건복지부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 재작성

35) 「국민건강보험법」 제99조제8항제1호(용도 제한)와 동법 시행령 제71조제1항제1호(지원 규모 명시)에 따라 과징금 수입의 50%를 공단의 요양급여비용에 지급하도록 명시되어 있으며, 이에 근거해 보건복지부는 ‘건강보험가입자지원(일반회계)’ 사업에서 예산을 배정해왔다(2023년 기준 130억원). 그러나 보건복지부는 「국민건강보험법 시행령」 제71조제1항(2023.11.20. 시행 예정)을 입법예고(2023.07.26.~2023.09.04) 함에 따라 건강보험에 대한 과징금 수입 지원 규정을 삭제하고, 2024년 “건강보험 가입자지원(일반회계)” 예산안에 별도의 예산을 책정하지 않았다.

국고지원 조항은 2006년에 5년 한시조항으로 신설된 후, 2011년(5년), 2016년(1년), 2017년(5년) 등 「국민건강보험법」 개정을 통해 지속적으로 연장되고 있으며, 최근에는 2023년 6월 개정을 통해 2027년까지 5년간 기한이 연장되었다.

과거 「국민건강보험법」 제정(1999.2.8.) 당시에는 국고지원 규모 및 지원방식이 구체적으로 제시되지 않아³⁶⁾ 국고지원에 대한 논란이 지속되었다. 그러나 2000년 7월 의약분업 시행에 따라 수가 인상 등으로 보험지출이 크게 증가하면서 건강보험 재정이 위기를 맞게 되자 2002년 1월 「국민건강보험재정건전화특별법」이 제정되었다. 동법은 2002년부터 2006년까지 한시적으로 운영되었으며, 건강보험에 대한 국고지원을 일반 회계뿐만 아니라 국민건강증진기금에서도 받을 수 있도록 명시하였다. 동법 제15조는 국고지원 규모를 지역보험재정의 50%(일반회계 40%, 국민건강증진기금 10%)로 규정 하였으며, 2005년부터는 지원비율을 일반회계 35%, 국민건강증진기금 15%로 하향 조정하였다.

국고지원금 중 일반회계는 보험료 수입에 연동되어 매년 증가하고 있으며, 정부는 2023년 보험료 예상수입액의 14.4%인 10.97조원을 배정하였다.³⁷⁾ 반면 국민건강증진기금은 법률상 건강보험료 예상수입액의 6%에 해당하는 금액을 지원하도록 규정되어 있지만, 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없다는 단서조항으로 인해 실제 건강보험료 수입의 3%를 하회하는 금액을 지원하고 있으며 보험료 수입이 증가함에 따라 그 비중은 감소하고 있는 추세이다.

[표 12] 건강보험 실 국고지원을 추이: 2017~2023년

(단위: %)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
실 국고지원율 (일반회계+기금)	13.6	13.2	13.2	14.8	13.8	13.7	(14.4)	(14.4)
일반회계	9.8	9.7	10.2	11.8	11.1	11.3	(12.0)	(12.2)
기금	3.8	3.5	3.1	3.0	2.8	2.4	(2.4)	(2.2)

주: 2023년, 2024년은 보건복지부 예산(안) 상 예상수입액 대비 국고지원금 비율

자료: 국회예산정책처

36) 「국민건강보험법」(1999.2.8. 제정, 시행) 제67조 ③ 국가는 대통령령이 정하는 바에 의하여 예산의 범위 안에서 지역가입자가 부담할 보험료의 일부를 부담할 수 있다.

37) “건강보험가입자 지원” 사업의 일반회계 지원은 ① 보험료 예상수입액 14%에 해당하는 금액과 ② 과징금의 50%에 해당하는 금액으로 이루어져 있으나, 본 고에서는 이를 ‘일반회계’로 통칭한다.

(3) 수입 추이

2022년 기준 건강보험 총수입 88.78조원 중 보험료 수입은 76.55조원(86.2%), 국고지원금은 10.5조원(11.8%), 기타수입은 1.72조원(1.94%)이었으며, 보험료 수입 대비 국고지원금 비율은 13.7%였다. 건강보험 수입은 매년 증가하고 있으며, 최근 10년(2013~2022년)간 보험료 수입은 연평균 7.9%씩 인상되었고, 특히 최근 3년(2020~2022년)의 평균 증가율은 9.3%로 과거 인상률을 상회하였다.

보험료 수입 증가는 지속적인 보험료율 인상과 임금상승 및 가입자 수 증가에 기인한다. 보험료율은 2017년 이후 매년 증가하여 2023년 기준 7.09%이며, 가입자 수도 매년 증가하고 있다. 특히 보험료를 부과하지 않는 직장피부양자의 수와 비중이 감소한 반면 직장가입자와 지역세대주의 수는 증가하였다. 직장피부양자는 감소했는데, 이는 부과체계 개편으로 인한 피부양 자격 강화 효과로 해석할 수 있으며, 감소한 직장 피부양자가 지역가입자로 전환된 것으로 볼 수 있다. 직장가입자의 경우 취업자 수의 증가와 노인 임금근로자 수 증가에 기인한다. 2022년 연도 말 기준 직장가입자는 1,959만명으로 건강보험 적용인구의 38.1%를 차지하며, 이는 10년 전인 2012년 28.2% 대비 약 560만명이 증가한 수준이다.

기타수입은 연체금, 기타징수금, 이자수입 등이며 2017년, 2021년은 전년도 대비 하락하는 등 일정한 추세를 보이지 않는데, 이는 이자율 등 외부 요인의 영향에 의한 것으로 보인다.

[표 13] 건강보험 수입 추이: 2013~2023년

(단위: 조원)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
수입	45.17	48.50	52.40	55.72	58.00	62.12	68.06	73.42	80.49	88.78	-
보험료 수입	38.61	41.24	44.05	47.31	50.01	53.64	58.74	62.48	69.23	76.55	-
국고지원금	5.81	6.32	7.10	7.10	6.78	7.08	7.78	9.23	9.57	10.50	10.97
일반회계	4.81	5.31	5.58	5.21	4.88	5.20	5.97	7.35	7.65	8.68	9.15
기금	1.00	1.02	1.52	1.89	1.90	1.88	1.81	1.88	1.92	1.81	1.82
기타	0.75	0.94	1.26	1.32	1.21	1.39	1.54	1.71	1.69	1.72	-

주: 2023년 국고지원금은 예산 기준임

자료: 보건복지부

다. 건강보험 지출 구조 및 현황

건강보험 지출은 크게 보험급여비와 관리운영비 등으로 나눌 수 있다. 보험급여비는 앞서 살펴본 바와 같이 현물 또는 현금, 그리고 그 하위 분류별로 재정이 구성된다. 보험급여비는 급여의 범위, 수가, 의료수요 등에 의해 그 규모가 결정되며, 일부 대상자에게 급여를 정액으로 지급하는 현물급여의 경우 정책 기준 변화에 따라 그 규모가 달라질 수 있다. 관리운영비 등은 국민건강보험공단 운영을 위한 비용이다. 인건비, 기본경비 등을 포함하며, 사업비로 건강보험심사평가원 부담금 등 타기관부담금을 포함한다.

[표 14] 건강보험 재정구조 개요

항목		내용
지 출	보험급여비	◦ 현물급여 - (요양급여) 가입자 및 피부양자의 질병·부상 등에 대하여 요양기관에서 제공하는 의료서비스(진찰, 치료, 입원 등) - (건강검진) 가입자 및 피부양자에 대하여 질병의 조기발견과 그에 따른 요양급여를 위해 실시하는 검진(일반건강검진, 암검진, 영유아 건강검진) ◦ 현금급여비 - 요양비(당뇨소모성재료, 산소치료 등), 장애인 보조기기, 본인부담액 상한제 환급금, 임신·출산진료비 등 가입자 및 피부양자에게 직접 지급되는 급여비
	관리운영비 등	◦ 인건비, 기본경비, 사업비(사업경비+건강보험심사평가원부담금) 등

자료: 보건복지부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 재작성

2022년 기준 건강보험 총지출 85.15조원 중 보험급여비가 83.17조원으로 대부분 (97.7%)을 차지하며, 관리운영비는 1.98조원으로 총지출의 2.3% 수준이다. 보험급여비의 96.5%는 현물급여(요양급여 및 건강검진비)가 차지하고 있으며, 현물과 현금급여 모두 매년 증가하고 있다. 최근 10년(2013~2022년)간 보험급여비는 연평균 8.4%씩 증가하였으나, 코로나19의 영향으로 2020년 증가율은 2.77%에 그쳤다. 요양급여비선지급은 코로나19로 인해 재정악화를 겪는 의료기관을 지원하기 위한 일시적 지원으로,³⁸⁾ 2020년에 선지급금을 지불한 후 2021년부터 사후정산을 진행하였다.

그러나 2021~2022년 보험급여비 증가율은 각각 7.96%, 8.57%로 다시 증가하여 코로나19가 의료이용에 미치는 영향이 축소되고 의료시스템이 정상화되는 과정에 있는 것으로 보인다. 보험급여비 증가는 요양급여 확대와 노인 인구 증가 등에 따른 의료 이용량 증가 및 수가 인상 등에 기인한다. 최근에는 보장성 강화 대책에 따라 상급병실, 뇌·뇌혈관 및 복부·흉부 MRI 등 급여의 범위가 확대되고 있으며, 수가도 인상되고 있다.

[표 15] 건강보험 지출 추이: 2013~2022년

(단위: 조원)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
지출	41.53	43.92	48.23	52.63	57.29	62.29	70.89	73.77	77.67	85.15
보험급여비	40.27	42.49	46.50	51.05	55.54	60.59	69.04	70.95	76.60	83.17
요양급여비선지급 (코로나19)	-	-	-	-	-	-	-	0.88	-0.87	-
관리운영비 등	1.26	1.42	1.73	1.58	1.75	1.70	1.85	1.94	1.94	1.98

주: 현금흐름기준 작성

자료: 국민건강보험공단

38) 통상 급여비 심사와 지급에 3개월 이상의 시간이 소요되나, 이를 생략하고 우선 일시금을 지급한다.

4. 세부 항목별 급여 현황

가. 연령군별 급여 현황³⁹⁾

2022년 1년간 건강보험 요양급여를 받은 인원은 5,553만명이며(지급기준),⁴⁰⁾ 55세 미만이 전체의 65.2%, 55세 이상이 34.8%를 차지한다. 1인당 진료비는 높은 연령 그룹일수록 증가하며, 75세 이상 그룹의 1인당 진료비는 524만원으로 55세 미만 그룹 1인당 진료비의 4.9배 수준이다. 급여비는 전체 진료비 중 공단이 부담하는 금액으로 연령별로 진료비와 유사한 추이를 보인다. 연령별 본인부담비중은 75세 이상(후기고령자)이 23.3%로 가장 낮는데, 이는 65세 이상을 대상으로 시행되는 ‘노인외래 정액제’와 중증질환, 중증치매 등 질환자의 본인부담비중을 낮춰주는 ‘산정특례제도’ 대상자 중 후기고령자의 비율이 높기 때문으로 보인다.

[표 16] 연령별 이용 현황(2022년 기준)

	진료실인원		진료비 (공단부담금+본인부담금)		급여비 (공단부담금)		본인부담 비중 (%)
	인원 (천명)	비중 (%)	전체 (조원)	1인당 (만원)	전체 (억원)	1인당 (만원)	
0~55세 미만	36,207	65.2	38.7	106.9	28.6	79.1	26.0
55~64세	9,030	16.3	19.6	217.2	14.5	160.2	26.2
65~74세	5,957	10.7	21.4	359.2	16.2	272.1	24.2
75세 이상	4,335	7.8	22.7	524.2	17.4	401.8	23.3
전체	55,528	100	102.4	184.5	76.7	138.2	25.1

주: 1. 지급기준

2. 진료실인원은 요양기관에서 진료받은 실제 인원 수(약국처방 제외)를 의미하며, 각 분류(요양기관별, 질병별, 월별)간 중복인원을 제거한 수치임. 다만, 진료시점에 따른 연령 변동으로 인한 연령그룹 간 중복 인원이 생길 수 있으므로 각 그룹별 단순 합과 전체 값이 다를 수 있음

3. 본인부담 비중은 전체 진료비 중 본인부담금(진료비-급여비)가 차지하는 비중이며, 비급여 본인부담은 포함되지 않음

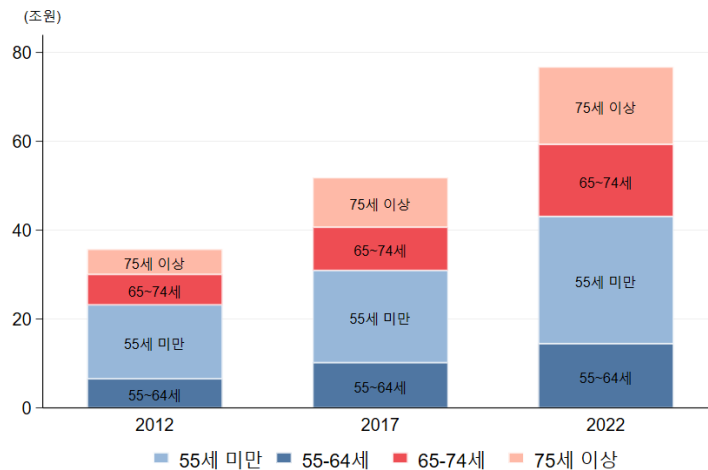
자료: 보건복지부 제출자료

39) 본 소절은 고령인구 증가에 따른 의료비 변화를 상세히 살펴보기 위해 55세 미만, 장년층(55~64세), 전기고령자(65~74세), 후기고령자(75세 이상)로 구분한다.

40) 당해연도에 지급된 건을 대상으로 집계된 인원이며, 진료일 기준과는 차이가 있다. 2023년 9월 현재 기준으로 국민건강보험공단의 진료일 기준 수치는 아직 발표되지 않았다.

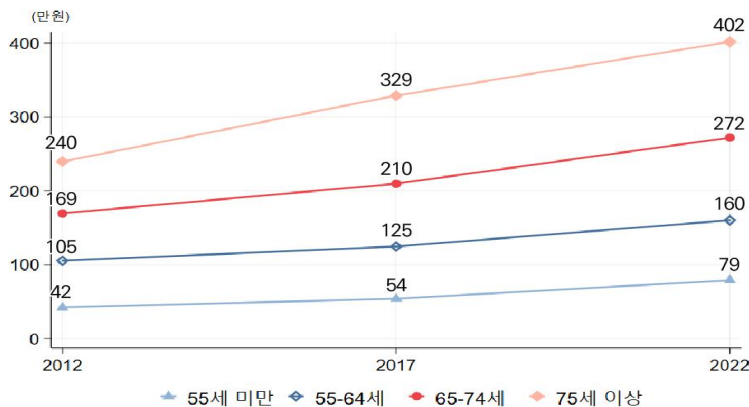
연령대가 높은 그룹일수록 본인부담비중이 낮다는 점은 향후 고령화에 따라 건강보험 공단이 부담할 급여비 비중이 더욱 높아진다는 것을 의미한다. 연령군별 급여 추이를 살펴 보면 그 변화가 더욱 명확하다. 2012년 대비 2022년 전체 급여비와 1인당 급여비가 모두 2배 이상 증가하였으며, 고령층일수록 그 증가폭이 더 크게 나타남을 확인할 수 있다. 특히 1인당 급여비의 경우, 전기고령자(65~74세)는 2012년 169만원에서 2022년 272만원으로 61%, 후기고령자(75세 이상)는 240만원에서 402만원으로 68% 각각 증가하였다. 2022년 기준, 후기고령자의 1인당 급여비 수준은 55세 미만 그룹의 약 5배 수준이므로 고령화가 건강보험 재정에 미칠 영향을 가늠해볼 수 있다.

[그림 7] 연령군별 급여비 현황: 2012~2022년



자료: 국민건강보험공단 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

[그림 8] 연령군별 1인당 급여비 추이: 2012~2022년



자료: 국민건강보험공단 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

나. 진료형태별 급여 현황

진료형태별로 살펴보면, 전체 의료기관 급여비 중 외래 급여비가 입원 급여비보다 높게 나타난다. 2022년 입원 급여비는 28.2조원으로 전년 대비 소폭 감소한 반면, 외래 급여비는 33.3조원으로 2021년 대비 17.6% 증가하였다. 약국 급여비의 경우도 전년도 대비 11.7% 증가한 15.3조원이 소요되었다.

다만, 2022년의 입원 급여비의 감소는 일시적 현황으로 보인다.⁴¹⁾ 입원 및 외래 급여비의 10년간(2012~2022년) 연평균 증가율은 각각 7.8%, 9.0%로 지속적인 상승 추이를 나타내고 있는 것으로 미루어보아 향후 진료형태별 급여비 비중도 과거와 비슷한 수준에서 유지될 것으로 보인다.

[표 17] 진료형태별 급여 현황

(단위: 조원, %)

	2021		2022		증가율	
	진료비	급여비	진료비	급여비	진료비	급여비
의료기관	74.6	56.5	81.4	61.4	9.1	8.8
입원	34.7	28.2	34.7	28.2	-0.2	-0.1
외래	39.9	28.3	46.7	33.3	17.1	17.6
약국	18.9	13.7	21.0	15.3	11.5	11.7

주: 지급기준

자료: 보건복지부

41) 국민건강보험공단은 2022년 입원 급여비 감소는 실질적인 의료이용의 증감보다는 전년도 심사·지급 지연 등으로 인한 결과로 해석했다.

다. 자격유형별 급여 현황

다음은 자격유형별로 급여 현황을 살펴본다. 아래 표에서 직장은 직장가입자와 피부양자의 급여 현황을 포함하며, 지역은 지역세대주와 지역세대원을 포함한다. 2022년의 급여 총액은 두 그룹 모두 전년 대비 9% 내외로 증가하였다. 직장가입자와 피부양자의 수(3,663만명)가 지역가입자(1,478만명)의 2배 이상이므로 직장 그룹의 전체 급여비가 지역가입자보다 높게 나타나지만, 1인당 평균 급여비의 경우 각각 143만원(직장)과 164만원(지역)으로 지역가입자에게서 더 높게 나타난다.

지역가입자의 1인당 급여비가 직장가입자보다 높은 이유는 지역가입자의 고령층 비율로부터 유추해볼 수 있다. 직장가입자는 임금근로자를 가입 대상으로 하므로 65세 이상 노인 비율이 약 15% 수준인 반면에, 자영업자와 은퇴 인구 등을 포함한 지역가입자의 노인 비율은 약 20%로 차이를 보인다.

[표 18] 자격유형별 급여 현황

(단위: %)

		진료비				급여비			
		전체 (억 원)	세대당 (천 원)	1인당 (천 원)	전체 증감률	전체 (억 원)	세대당 (천 원)	1인당 (천 원)	전체 증감률
'21	직장	64.3	3,367	1,729	6.8	47.9	2,512	1,290	6.4
	지역	29.2	3,314	2,053	9.2	22.2	2,520	1,561	8.9
	전체	93.5	3,351	1,819	7.5	70.2	2,514	1,365	7.2
'22	직장	70.5	3,597	1,924	9.6	52.5	2,679	1,433	9.5
	지역	31.9	3,430	2,162	9.3	24.2	2,601	1,640	9.0
	전체	102.4	3,543	1,992	9.5	76.7	2,654	1,492	9.3

자료: 보건복지부 제출 자료

라. 요양기관 종별 급여 현황

요양기관 대분류 기준으로 2022년 급여비가 가장 높은 기관은 종합병원급으로 1년간 공단이 26.3조원을 지불하였으며, 일반 의원과 치과의원, 한의원을 포함하는 의원급 기관의 급여비 또한 23조원 상당으로 전체 급여비 지출의 높은 비중을 차지한다. 전체 요양기관 수에서 종합병원급이 차지하는 비중이 절대적으로 적음에도 불구하고⁴²⁾ 급여비가 가장 높다는 점은 우리나라의 상급병원 쏠림 현상을 일부 보여준다.⁴³⁾ 또한 전년 대비 급여비 증가율이 상대적으로 높은 기관은 의원급(18.2%), 약국(11.7%)이다. 개별 의료기관 중에는 정신병원 급여비의 증가율이 53.5%로 가장 높아 우울증, 코로나19로 인한 정신건강 후유증 등의 최근 정신질환 증가 추이를 나타낸다.

[표 19] 요양기관 종별 급여 현황

(단위: 조원, %)

	진료비			급여비		
	2021	2022	증감율 (%)	2021	2022	증감율 (%)
종합병원급	33.1	34.5	4.2	25.6	26.3	3.0
상급종합	17.0	17.3	2.0	13.4	13.6	1.5
종합병원	16.1	17.2	6.6	12.1	12.7	4.8
병원급	15.2	16.1	5.9	11.4	12.0	5.6
병원	8.2	9.0	9.2	6.0	6.5	8.7
요양병원	5.7	5.6	-2.4	4.4	4.3	-2.3
정신병원	0.4	0.7	53.8	0.3	0.5	53.5
치과병원	0.3	0.3	0.8	0.2	0.2	0.8
한방병원	0.5	0.6	8.6	0.4	0.4	8.9
의원급	26.2	30.6	17.0	19.5	23.0	18.2
의원	18.8	23.0	22.6	14.1	17.5	24.1
치과의원	4.9	5.1	3.8	3.5	3.6	3.7
한의원	2.5	2.6	1.3	1.9	1.9	1.3
보건기관 등	0.1	0.1	-2.2	0.1	0.1	-1.8
약국	18.9	21.0	11.5	13.7	15.3	11.7

주 1. 지급기준, 반올림 계산하여 실제 값과 차이가 있을 수 있음

2. 2021년 3월 의료법 개정에 따른 '정신병원' 요양기관 종별 분리 및 신설

자료: 보건복지부 제출 자료

42) 2021년 기준 98,479개의 요양기관 중 종합병원급 기관은 45개로 전체의 0.05%에 불과하다.

43) 보건복지부는 이에 대한 대책으로 요양기관 종별 기능을 정립하기 위해 경증질환(105개) 상급종합병원 초진 외래 진료는 본인부담상한제 대상에서 제외할 것을 발표했다.("건강보험 지속가능성 제고 방안", 2023.2.28.)

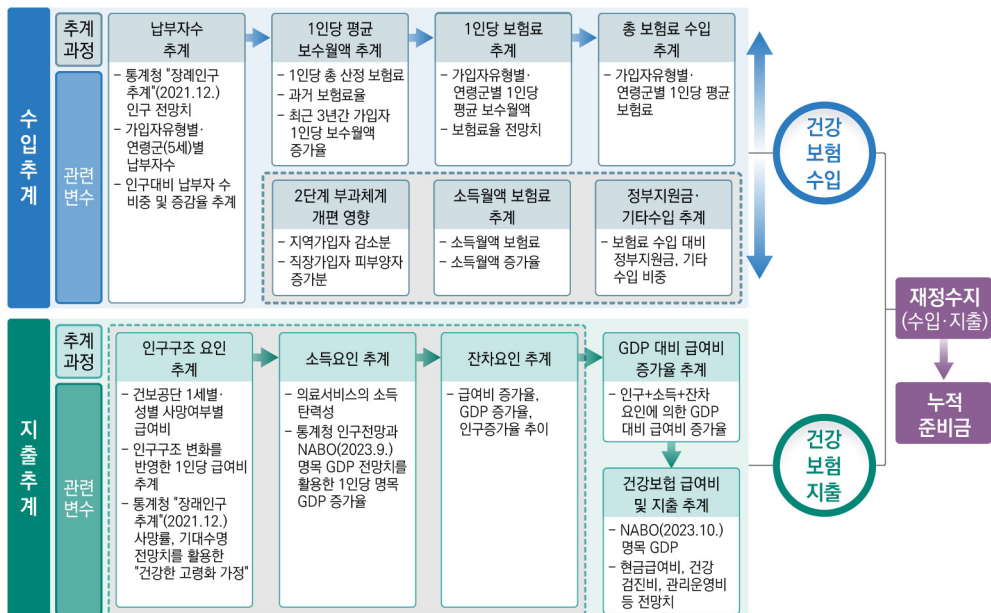
III. 건강보험 재정전망

1. 전망 방법

가. 전망 모형44)

국회예산정책처의 건강보험 전망 모형은 인구변수와 거시경제변수, 제도변수를 활용하여 건강보험 수입 및 지출을 각각 추계하고 연도별 재정수지와 누적 준비금을 산출한다. 인구변수는 전망기간(2023~2032년)의 연령별 인구, 기대수명 및 사망률이며, 거시경제변수는 명목 GDP와 명목 GDP 성장률이다. 제도변수는 건강보험 가입 및 납부자 수, 보험료 납부액, 건강보험 급여액 등 제도 운영에 따른 실적치로부터 도출한 변수나 외생적으로 결정되는 정책 변수를 포함한다. 본 장에서는 NABO 기본 모형을 소개하고 기본모형에서의 전망(이하 “기본전망”) 결과를 제시한다.

[그림 9] NABO(2023) 건강보험 재정전망 모형 개요



자료: 국회예산정책처

44) 본 소절에서는 전망 모형의 전체적인 틀과 주요 개요만을 소개하며, 모형의 상세 내용은 부록에 제시하였다.

먼저 건강보험 수입 전망은 (1) 보험료 수입, (2) 일반회계 및 국민건강증진기금을 합산한 국고지원금, (3) 기타 수입을 각각 추계하여 합산한다. 보험료 수입은 유형별(근로자·공무원·교원·지역) 납부자 수에 1인당 평균 보수월액과 보험료율, 징수율을 곱하고 직장가입자의 보수외 소득 보험료를 합산하여 전망한다. 이때 유형별 납부자 수는 연령군별(5세 단위), 가입자 유형별 장래인구추계 대비 납부자 수 분포와 추이 등을 반영하여 추계한다. 1인당 평균 보수월액도 마찬가지로 연령군별·가입자 유형별로 구분하고, 연도말 기준 본인부담 보험료에 보험료율과 본인부담 비율⁴⁵⁾ 등을 역산하여 산출한다. 전망기간 증가율은 최근 직역별 보수월액 증가율 실적을 고려하여 추계한다. 국고지원금과 기타수입은 보험료 수입 대비 비중 추이를 적용하여 전망한다.

건강보험 지출모형은 인구구조, 소득 및 잔차(신의료기술, 정책 등) 요인을 고려하여 의료비 지출을 추계하는 OECD(2006, 2013) 모형⁴⁶⁾을 근간으로 구축한다. 건강보험 급여비는 GDP 대비 급여비 비중을 추계 후 명목 GDP 전망치를 곱하여 전망한다. 각 전망연도의 GDP 대비 급여비 비중은 2022년 GDP 대비 급여비 비중에 전망기간의 각 연도별 급여비 비중 증가분을 더하여 산출한다. 이때 각 연도별 GDP 대비 급여비 비중 변화는 인구, 소득 및 잔차요인에 의한 GDP 대비 급여비 비중 변화의 합이다. 급여비 전망 후, 급여비 외 지출 구성요소(건강검진비, 현물급여비, 관리운영비 등)의 급여비 대비 최근 비중을 적용하여 추계한다.

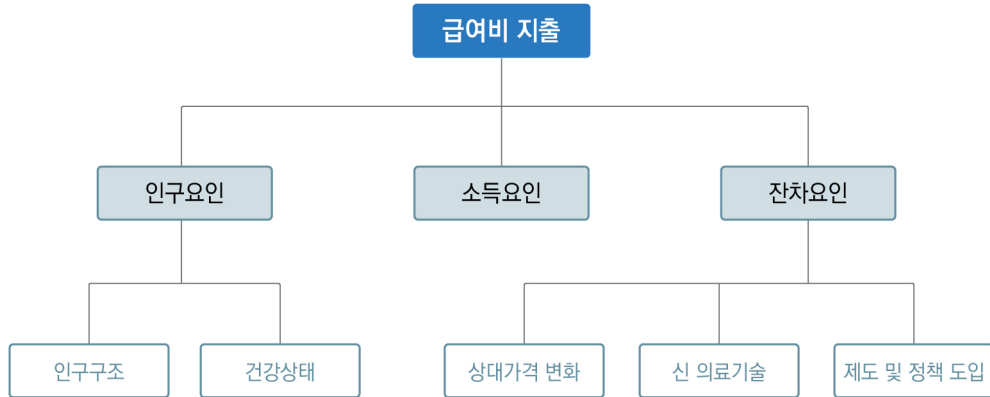
OECD(2006, 2013) 모형에 따른 각 요인을 간략하게 설명하면 다음과 같다. 인구요인은 고령화와 같은 인구구조의 변화와 국민의 건강상태 변화 등이 급여비 증가에 미치는 영향을 분석하기 위해 연령별 급여비, 사망률, 기대수명 등을 고려한다. 소득요인은 국가 소득 증가에 따른 국가 의료비 지출 변화(의료비 소득탄력성)정도를 측정하며, 잔차요인은 인구와 소득 요인을 제외한 모든 의료비 증감 요인을 의미한다. 대표적으로 의료 서비스의 상대가격 변화, 신 의료기술 발전, 제도 및 정책 도입 등이 포함되며, 급여비 증가율

45) 직장가입자 중 근로자와 공무원은 가입자 본인이 보험료의 50%, 사업장(공무원의 경우 국가)이 50%를 부담하며, 사립학교 교원의 경우 본인이 50%, 학교 30%, 국가가 20%를 부담하고 있다.

46) OECD(2013) 모형은 공공의료비(건강보험+장기요양보험+정부지원 등)를 전망하였으며, 이를 활용한 국민건강보험공단(2015) 모형은 국민의료비(경상의료비+보건의료 인프라 투자), 한국조세연구원(2018) 모형은 경상의료비(공공의료비+민간의료비)를 전망한 후 건강보험 지출이 차지하는 비중을 가정하여 건강보험 지출을 전망하는 하향식(top-down) 방식을 적용하였다. 이와 달리, NABO(2023) 모형은 건강보험 급여비를 직접 전망한 후 건강보험 재정을 전망하는 상향식(bottom-up) 방식을 적용한다. 코로나19와 보장성 강화 대책 등으로 인해 상위 의료비 범주 내에서 건강보험 급여비가 차지하는 비중이 내생적으로 변화했음에 따라, 과거 추이를 반영하여 향후 건강보험 재정이 차지하는 비중을 합리적으로 가정하는 것이 어렵다고 판단하였기 때문이다.

에서 인구와 소득요인으로 인한 증가율을 차감하여 산출한다. 이 밖에 지출 모형과 각 요인에 대한 구체적인 내용은 부록에서 확인할 수 있다.⁴⁷⁾

[그림 10] 급여비 지출 결정요인



자료: 국회예산정책처

나. 주요 가정

(1) 인구변수

건강보험 재정전망의 인구변수는 통계청이 2021년 12월 발표한 「장래인구추계」의 2023~2032년 전망 결과(중위 기준)를 활용한다. 이는 2020년 인구주택총조사 결과를 바탕으로 2020년 7~10월 발생한 출생·사망·국제이동 등의 인구변동요인을 반영하여 산출한 값이다. 본고에서는 장래인구추계, 인구 성장률, 기대수명, 사망률을 활용한다. 장래인구는 2023년 5,156만명에서 지속적으로 감소하여 2032년 5,108만명에 이를 것으로 전망된다. 반면에 65세 이상 인구는 정반대의 추이를 보이는데, 2023년 950만명에서 매년 증가하여 2032년 1,391만명으로 전체 인구의 27%를 차지할 전망이다. 특히 2025년에는 노인 인구 비중이 20.6%에 도달하여 초고령사회에 진입할 것으로 예상된다. 2032년 기대수명은 86.1세로 2023년 대비 1.8세 높아지는 것으로 전망되며, 이에 따라 75세 이상의 후기고령자 수와 비중, 사망률도 증가하는 추세로 나타난다.

47) 본고는 기본모형에서 “건강한 고령화”(설명은 [부록 2]참조)를 가정하였으며, 이를 가정하지 않은 재정전망 결과는 [부록 3]에 수록하였다.

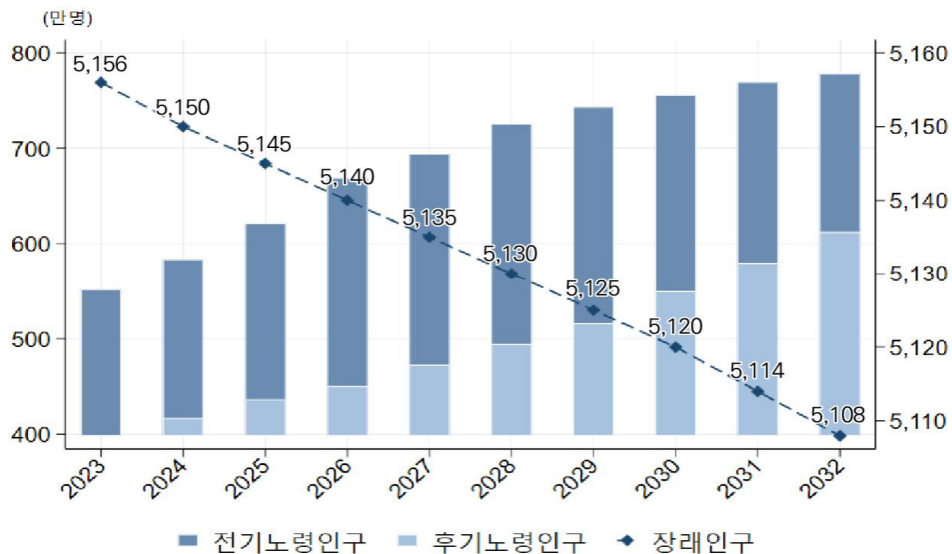
[표 20] 건강보험 전망의 주요 가정: 주요 인구 변수

(단위: 만명)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
장래인구	5,156	5,150	5,145	5,140	5,135	5,130	5,125	5,120	5,114	5,108
인구성장률 (%)	-0.14	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.10	-0.11	-0.12
65세 이상 인구	950	1,001	1,059	1,120	1,167	1,220	1,260	1,306	1,349	1,391
전기고령자 (65~74세)	551	584	622	669	694	726	744	756	769	778
후기고령자 (75세 이상)	399	417	437	451	473	494	516	550	580	613
기대수명(세)	84.3	84.5	84.7	84.9	85.1	85.3	85.5	85.7	85.9	86.1
사망률(%)	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4

자료: 통계청의 「장래인구추계」(2021.12.) 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

[그림 11] 장래인구추계: 2023~2032년



자료: 통계청의 「장래인구추계」(2021.12.) 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

(2) 거시경제변수

재정전망 모형에 적용하는 거시경제변수는 한국은행의 명목 GDP 실적치와 국회예산정책처가 전망(2023.10.)한 명목 GDP와 명목 GDP 성장률이다. 2023년 명목 GDP는 2,210조원으로 전망되었으며, 명목 GDP 성장률은 향후 10년(2023~2032년) 간 평균 4.0%로 나타난다.

[표 21] 건강보험 전망의 주요 가정: 주요 거시경제변수

변수	내용	출처
명목 GDP	2023년 2,210조원	국회예산정책처(2023.10.)
성장률	2023~2032년 기간 평균 4.0%	

자료: 국회예산정책처

(3) 주요 제도변수

제도변수는 건강보험 제도 운영에 따른 실적치로부터 도출한 주요 수치들로, 전망치의 추세와 분포를 현실적으로 가정하기 위해 모형에 투입하는 변수이다. 건강보험 실적치로부터 도출한 주요 제도변수로는 가입유형별 가입자 비율, 보험료 부과액 대비 실제 징수한 금액을 나타내는 징수율, 수입 및 지출 세부 항목별 비중 등이 있다.

그 밖에 실적치로부터 도출하는 제도변수 외에도 외생적으로 계산되는 정책변수 등도 포함한다. 건강보험정책심의위원회에서 결정하는 보험료율, 보건복지부가 정하는 국고지원비율, 각종 건강보험 정책 집행에 따라 발생하는 건강보험 수입 및 지출 증감 추계액(lump-sum) 등이 여기에 해당한다.

[표 22] 건강보험 전망의 주요 가정: 주요 제도변수

변수	내용
유형별 가입자 비율	◦ 직장가입자(근로자, 교원, 공무원) 및 지역가입자별 최근 3년(2020~2022년) 추계인구 대비 평균 비율 및 증감을 반영
징수율	◦ 최근 3년(2020~2022년) 평균 징수율 유지 가정 - (직장가입자) 99.3% - (지역가입자) 100.6%
기타수입	◦ 최근 3년(2020~2022년) 보험료 수입 대비 비율(2.5%) 유지 가정
건강검진비, 현금급여, 관리운영비	◦ 로그함수에 따라 급여비 대비 비율 변화 가정
보험료율	◦ (2023~2024년) 기결정 보험료율, (2025~2029년) 최근 3년(2021~2023년) 평균 보험료 인상률(2.06%) 유지, (2030~2032년) 8% 상한 적용
국고지원율	◦ (일반회계) 최근 3년(2020~2022년) 평균 보험료 수입 대비 일반회계 실국고지원율 11.4% 유지 가정 ◦ (기금) 2024년 예산(안) 상 담배부담금 예상수입액의 65% 유지 가정
부과체계 개편에 따른 수입 변동	◦ (직장) 최근 3년(2020~2022년) 상반기 평균 소득월액 보험료 증가율 유지 가정 ◦ (지역) 보건복지부 제출 자료에 보험료 증가율(전망치) 적용

자료: 국회예산정책처

보험료율

2023년, 2024년 건강보험료율은 기결정된 7.09%를 준용하며 2025년부터 2029년까지는 매년 2.06%(최근 3년간(2021~2023년) 보험료율 인상률)⁴⁸⁾씩 인상하는 것으로 가정한다. 다만, 보험료율 8% 상한 규정을 고려하여 2030년도 이후에는 보험료율 8%가 유지되는 것으로 가정한다.

[표 23] 건강보험료 보험료율 가정: 2023~2032년

(단위: %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
건강보험료율	7.09	7.09	7.24	7.39	7.54	7.69	7.85	8.00	8.00	8.00
보험료율 인상률	1.43	0.00	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.91	0.00	0.00

주: 2023년, 2024년 건강보험료율은 기결정된 보험료율을 준용하고 2025년부터 2032년까지는 매년 2.06%씩 인상하는 것으로 하되, 8% 상한 규정을 고려하여 추계

자료: 국회예산정책처

48) 이 수치는 보건복지부에서 발표하는 인상률과는 소폭 차이를 보이는데, 보건복지부에서는 건강보험료율 인상률 계산 시 소수점 둘째자리 이하까지 고려하는 반면에, 본고에서는 소수점 둘째자리까지만 고려하기 때문이다. 국민건강보험공단은 보험료 부과 시에 보험료율 소수점 둘째자리까지만 고려하고 있다.

국고지원금

건강보험에 대한 국고지원금은 건강보험 가입자 지원을 위한 일반회계 지원금과 국민건강증진기금으로부터의 지원금을 합산하여 전망한다. 2023년은 예산액을 반영하여 추계하며, 2024년부터는 최근 3년(2020~2022년)간 건강보험료 실제 수입액 대비 평균 국고지원 비율(결산 기준)을 적용한다. 정부는 매년 예산안을 통해 자체적으로 전망한 보험료 예상 수입액 대비 국고지원 비율을 발표하지만, 예상 수입액이 연례적으로 과소 추계되고 있으므로 본 보고서는 결산 기준 국고지원율을 모형에 적용한다. 일반회계의 경우 수입액 대비 11.4%가 유지되는 것으로 가정하며⁴⁹⁾, 기금은 최근 담배부담금 수입 추이를 고려하여 2024년 예산(안) 수준을 유지한다.⁵⁰⁾

국민건강증진기금의 경우 법정 지원율인 보험료 예상 수입액 6%에 상당하는 금액이 아닌 담배부담금(법정부담금)의 65% 수준에서 건강보험 재정을 지원하고 있다.⁵¹⁾ 보건복지부 2022년 결산자료에 따르면, 최근 4년간 담배부담금 예상수입액은 2.7~2.9조원 내에서 결정되었으며 연도별로 일정한 추이가 관찰되지 않는다.⁵²⁾ 또한 홍우형·김원기(2022)⁵³⁾의 담배부담금 전망결과⁵⁴⁾를 고려하여 본 전망에서는 2024년 정부 예산(안)상 지원액이 추계기간 중 유지되는 것으로 가정한다.

49) 일반회계의 경우, 「국민건강보험법」 제99조제8항제1호(용도 제한)와 동법 시행령 제71조제1항제1호(지원 규모 명시)에 따라 과징금 수입의 50%를 공단의 요양급여비용에 지급하도록 명시되어 있으며, 이에 근거해 보건복지부는 ‘건강보험가입자지원(일반회계)’ 사업에서 예산을 배정해왔다(2023년 기준 130억원). 그러나 보건복지부는 「국민건강보험법 시행령」 제71조제1항(2023.11.20. 시행예정)을 입법예고(2023.07.26.~2023.09.04)함에 따라 건강보험에 대한 과징금 수입 지원 규정을 삭제하고, 2024년 “건강보험 가입자지원(일반회계)” 예산안에 별도의 예산을 책정하지 않았다. 본 전망에서는 이상의 정책 변화를 반영하여 국고지원 비율을 전망한다.

50) 2024년 예산(안) 수치는 확정 예산이 아니나, 해당 수치가 최근 5년간 평균 수준으로 책정된 점과 정부의 지원 의지를 반영한다는 점을 고려해 전망에 반영함

51) 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항에 따라 국민건강증진기금에서 당해연도 예상수입액의 6%에 상당하는 금액을 지원하도록 규정하고 있으나, 기금 지원액은 담배부담금 예상 수입액의 65%를 초과할 수 없다.

52) 담배부담금 예상수입액은 '20년(2.89조원), '21년(2.95조원), '22년(2.79조원), '23년(2.8조원)이었으며, 예상수입액 대비 실제 수납률은 49.3~102.6%로 연도별로 편차가 크다. 이로 인해 담배부담금을 주 수입원으로 하는 국민건강증진기금은 부족한 사업비를 충당하기 위해 공공자금관리기금의 예수금을 차입하고 있는 상황이다.

53) 홍우형·김원기, 「주요 기금수입 추계방법 연구 및 전망모형 개발」, 국회예산정책처, 2022

54) 담배판매액을 결정요인으로 하는 기준전망에서는 2025년 이후 담배부담금이 감소하는 것으로 나타났으며, 흡연인구와 담배판매금액을 고려하는 보조전망에서는 2022년 이후 담배부담금이 감소하는 것으로 전망되었다.

2. 기본전망 결과

가. 수입 전망

(1) 건강보험 납부자 수

건강보험 납부자는 건강보험 가입자인 직장가입자, 직장피부양자, 지역가입자(세대주 및 세대원) 중 건강보험료 부과 대상인 직장가입자와 지역가입자 세대주를 말한다. 전망 기간 중 장래인구 감소에도 불구하고 경제활동인구와 취업자 수 증가, 1인 가구 증가 등의 이유로 건강보험 납부자 수는 2023년 2,803만명에서 2032년 3,416만명으로 증가할 전망이다.

또한 건강보험 제도 변화에 따른 가입자 행태 변화도 납부자 수 증가에 영향을 미칠 예정이다. 예를 들어, 건강보험료 부과체계 2단계 개편(2022.8.)에 따른 직장가입자 피부양자 소득기준 강화로 직장가입자 피부양자의 직장가입자 또는 지역가입자로의 자격 변동이 이어질 전망이다. 특히, 공적 연금수입에 대한 건강보험료 부과 기준 강화로 은퇴 피부양자 또는 지역가입자의 직장가입자 재편입 유인 증가 등이 예상된다.

가입자 유형별 납부자 수 전망을 살펴보면, 직장가입자는 2023년 2,008만명으로 추계인구의 약 40% 수준에서 2032년 46%인 2,369만명으로 증가할 것으로 보인다. 지역가입자(세대주) 또한 전망 기간 중 매년 증가하여 2023년 796만명(전체 추계인구의 15.4%)에서 2032년 1,046만명(전체 추계인구의 20.3%)에 도달한 전망이다.

[표 24] 건강보험 납부자 수 전망: 2023~2032년

(단위: 만명, %)

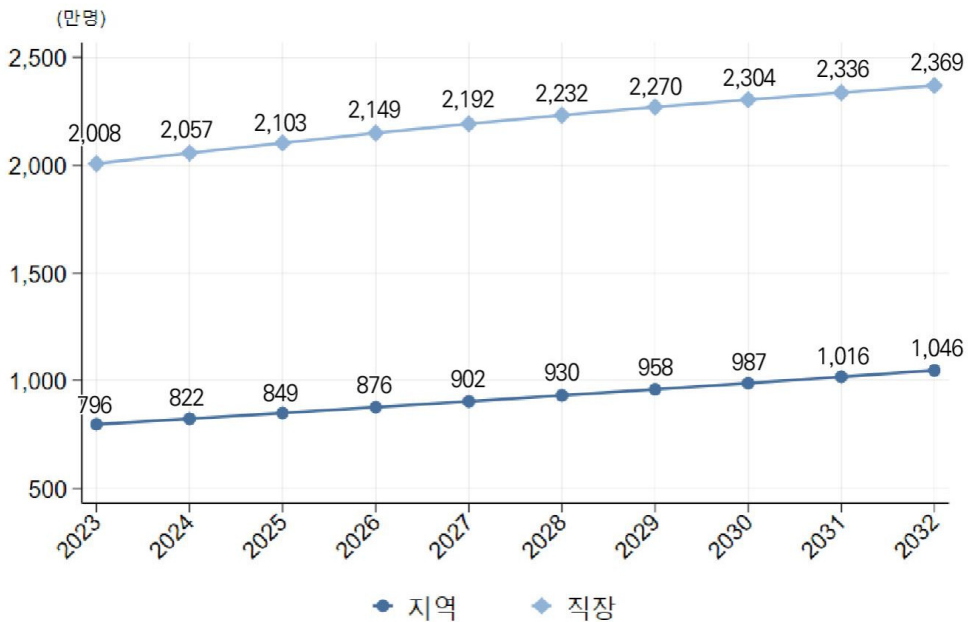
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
직장 가입자	2,008 (38.9)	2,057 (39.9)	2,103 (40.8)	2,149 (41.7)	2,192 (42.5)	2,232 (43.3)	2,270 (44)	2,304 (44.7)	2,336 (45.3)	2,369 (46.0)
지역 가입자 (세대주)	796 (15.4)	822 (15.9)	849 (16.5)	876 (17)	902 (17.5)	930 (18)	958 (18.6)	987 (19.1)	1,016 (19.7)	1,046 (20.3)
합 계	2,803 (54.4)	2,879 (55.8)	2,952 (57.2)	3,025 (58.7)	3,094 (60)	3,162 (61.3)	3,228 (62.6)	3,290 (63.8)	3,353 (65)	3,416 (66.2)

주: 1. 동 숫자는 연도 말 기준 직장가입자 본인과 지역가입자 세대주 인원으로 직장가입자 피부양자 및 지역
가입자 세대원은 제외한 숫자

2. 괄호 안은 인구 대비 비중

자료: 국회예산정책처

[그림 12] 건강보험 가입자 유형별 전망: 2023~2032년



자료: 국회예산정책처

(2) 수입

건강보험 수입은 2023년 93.3조원에서 보험료 및 국고지원금 증가에 따라 연평균 7.2%씩 꾸준히 증가하여 2032년 175.2조원에 도달할 전망이다. 항목별로 살펴보면, 건강보험료 수입은 2023년 80.3조원에서 2032년 152.2조원까지 매년 7.4%씩 증가할 것으로 보인다. 구체적으로, 건강보험료 수입은 2030년 보험료 8% 상한에 도달할 때까지는 연평균 7.7%로 증가하였으나, 2031년부터는 보험료율이 8%로 고정되며 납부자 수와 보수 및 소득월액이 증가함에도 증가율이 6.2% 수준으로 둔화된다.

국고지원금은 당해연도 예상보험료 수입에 연동하여 산출하므로 보험료 수입 상승에 따라 비례적으로 증가하여 2023년 11조원(예산)에서 2032년 19.2조원까지 증가할 전망이다.

마지막으로 기타수입⁵⁵⁾은 매년 7.4%씩 증가하여 2023년 2조원에서 2032년 3.8조원에 달할 전망이다. 기타수입 또한 보험료 수입에 비례하여 증가하기 때문이며, 매년 보험료 수입의 2.5%를 차지한다.

[표 25] 건강보험 수입 전망: 2023~2032년

(단위: 조원, %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	연평균 증가율
총수입	93.3	98.8	106.5	114.9	123.9	133.7	144.3	155.6	165.0	175.2	7.2
보험료수입	80.3	85.1	91.9	99.2	107.2	115.7	125.1	135.0	143.2	152.2	7.4
국고지원금	11.0	11.6	12.4	13.2	14.1	15.1	16.1	17.3	18.2	19.2	6.4
기타	2.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8	7.4

자료: 국회예산정책처

나. 지출 전망

건강보험 재정지출은 2023년 92조원에서 2032년 195.1조원까지 연평균 8.7% 증가할 전망이다. 이러한 증가 추이는 총지출의 약 97%를 차지하는 보험급여비의 증가 추이를 따르며, 보험급여비는 2023년 89.5조원에서 2032년 190.3조원으로 꾸준히 증가하는 것으로 나타난다. 보험급여비는 요양급여비와 건강검진비, 현물급여비로 구성되

55) 기타수입은 연체금, 기타징수금, 이자수입 등으로 구성된다.

며, 이 중 요양급여비가 약 93%를 차지한다. 요양급여비의 증가는 전술한 인구요인, 소득요인, 잔차요인에 따라 GDP 대비 비중이 2023년 3.77%부터 매년 증가한다는 점에 기인한다. 이와 더불어 전망 기간 내 명목 GDP 증가 추이를 반영하여 요양급여비는 2023년 83.4조원에서 2032년 175.9조원으로 증가할 전망이다.

[표 26] 건강보험 지출 전망: 2023~2032년

(단위: 조원, %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	연평균 증가율
총지출	92.0	100.2	109.7	121.6	132.7	144.4	154.8	166.1	180.1	195.1	8.7
보험급여비	89.5	97.5	106.8	118.4	129.2	140.6	150.8	161.9	175.6	190.3	8.7
(요양급여비)	83.4	90.7	99.3	110.0	120.0	130.4	139.8	149.9	162.5	175.9	8.7
관리운영비 등	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8	7.6

자료: 국회예산정책처

다. 재정수지 및 준비금

건강보험 재정수지는 2023년에 전년 대비 지출증가율이 소폭 감소하여 1.3조원 흑자를 나타낼 예정이나, 이후 평균 지출 증가율(8.7%)이 수입 증가율(7.2%)을 상회하면서 적자가 지속될 것으로 전망된다. 적자 폭은 2024년 1.3조원부터 2032년 20조원까지 매년 확대되며, 누적 준비금⁵⁶⁾은 2023년 25.2조원에서 2028년 소진된 후 2032년 누적적자가 61.6조원에 달할 전망이다. 2030년에는 건강보험료율이 8% 상한에 도달함에 따라 이후 건강보험료 수입 증가분이 감소할 예정이며, 2030년부터 재정수지 적자 폭이 확대되어 재정수지는 더욱 악화될 전망이다.

56) 준비금은 결산상의 잉여금을 적립한 금액을 의미하며, 「국민건강보험법」 제38조제2항에 따라 준비금은 부족한 보험급여 비용에 충당하거나 지출할 현금이 부족할 경우에만 사용할 수 있다. 따라서 준비금은 음수가 될 수 없으나, 본 보고서에서는 누적적자 수준을 가늠하기 위해 누적 준비금을 음수로 표기한다.

[표 27] 건강보험 재정수지 및 준비금 전망: 2023~2032년

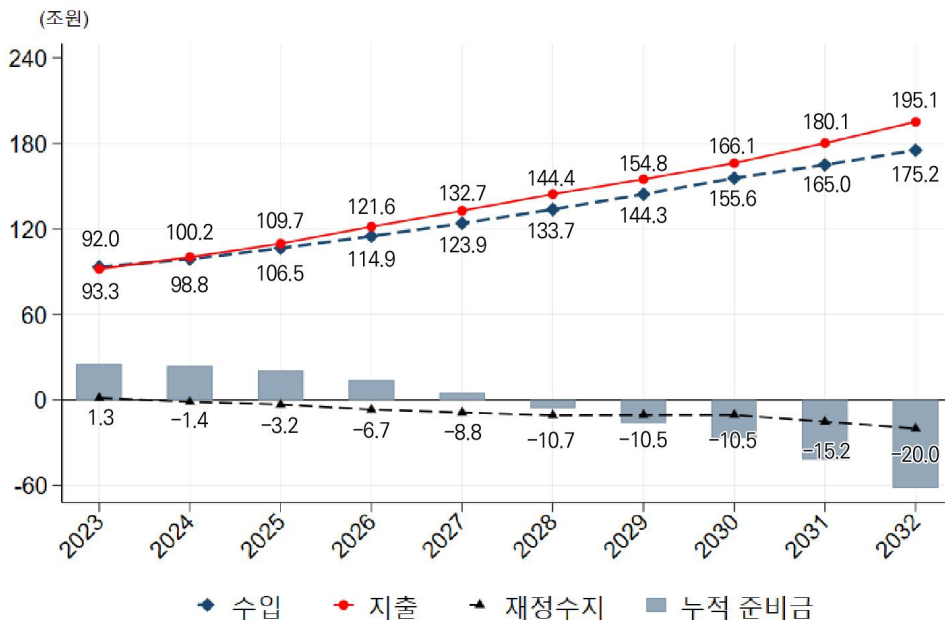
(단위: 조원, %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	연평균 증가율
수입	93.3	98.8	106.5	114.9	123.9	133.7	144.3	155.6	165.0	175.2	7.2
지출	92.0	100.2	109.7	121.6	132.7	144.4	154.8	166.1	180.1	195.1	8.7
재정수지	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-10.7	-10.5	-10.5	-15.2	-20.0	
누적 준비금	25.2	23.8	20.6	13.9	5.2	-5.5	-16.0	-26.5	-41.6	-61.6	

- 주: 1. 누적 준비금은 결산상 잉여금을 뜻하며, 음수로 표기된 준비금은 준비금 소진 후 발생한 누적 적자액을 뜻함
 2. 2023, 2024년 건강보험료율은 기결정된 7.09%, 2025~2032년은 매년 2.06%(최근 3년 평균)씩 인상하는 것으로 가정하되, 2030년부터 8% 상한 유지를 가정

자료: 국회예산정책처

[그림 13] 건강보험 수입, 지출 및 준비금 전망: 2023~2032년



- 주: 1. 준비금은 결산상 잉여금을 뜻하며, 음수로 표기된 준비금은 준비금 소진 후 발생한 누적 적자액을 뜻함
 2. 2023, 2024년 건강보험료율은 기결정된 7.09%, 2025~2032년은 매년 2.06%(최근 3년 평균)씩 인상하는 것으로 가정하되, 2030년부터 8% 상한 유지

자료: 국회예산정책처

[참고] 정부의 건강보험 재정전망⁵⁷⁾

□ 정부와 국회의 건강보험 재정전망 제도를 이해하기 위해서는 우선 건강보험이 국가재정이 아닌 국민건강보험공단 회계로 운영된다는 점을 고려해야 함

- 다른 사회보험(4대 연금 및 고용·산재보험)과 달리 건강보험과 장기요양보험은 국가재정 외로 운영되므로 건강보험 재정은 국회 심의를 받을 의무가 없음
- 다만, 국가가 건강보험에 지원하고 있는 의무지출^{*}만 국회 심의 대상에 해당하며, 그에 따라 정부는 의무지출 전망의 책임만 있음

* 국고지원금(일반회계+국민건강증진기금)과 공무원·사립학교교원 보험료부담금

□ 정부의 건강보험 재정전망은 크게 「국가재정법」에 따른 전망과 「국민건강보험법」에 따른 전망으로 이원화되어 있으며, 전망 결과 및 가정·모형 등을 투명하게 공개하지 않고 있음

- (국가재정법) 제7조제1항에 따라 매년 5회계연도 이상의 기간에 대한 재정운용계획과 제7조제4항에 따라 40회계연도 이상의 기간을 대상으로 5년마다 장기전망을 실시
 - 국가재정운용계획은 의무지출 전망만을 공개
 - 가장 최근 전망은 “2020~2060년 장기재정전망”(2020)⁵⁸⁾
- (국민건강보험법) 제3조의2에 따라 매 5년 종합계획을 수립하며, 중장기(5년) 재정전망을 포함
 - 가장 최근 전망은 “제1차 건강보험종합계획(2019~2023년)”(2019)
 - 참고로, 공단은 매년 중장기(5년) 재무관리계획을 발표하고 있으나, 재무전망 결과만을 공개하며 건강보험 전망에 대한 간단한 가정(보험료율 인상률, 정부지원금, 수가인상률)만을 밝히고 있음

57) 코로나19로 인한 예상치 못한 건강보험 급여비 추이 변화와 전망 시차가 존재하므로 각 전망 결과를 본 보고서 전망 결과와 비교하지는 않는다.

58) 보건복지부는 해당 전망 결과를 공표하지 않았으나, 감사원의 「감사보고서-건강보험 재정관리 실태-」(2022)를 통해 공개되었다.

[표] 정부의 건강보험 재정전망

(단위: 조원, %)

	「국가재정법」에 따른 재정전망	「국민건강보험법」에 따른 재정전망
전망 근거	○ 법 제7조제1항·제4항	○ 법 제3조의2
전망 기간 및 주기	○ (제1항) 매년 / 5년 전망 ○ (제4항) 5년 / 40년 전망	○ 5년 / 5년 전망
전망 주체	○ 보건복지부와 국민건강보험공단(건강보험연구원)이 작성하여 기획재정부에 제출	○ 국민건강보험공단(재정관리실)
최근 전망	○ “2020~2060년 장기재정전망”(2020)	○ “제1차 건강보험종합계획(2019~2023년)”(2019)
전망방법	○ 수입은 조성법, 지출은 시계열	○ 수입과 지출 조성법
공개수준	○ 미공개였으나, 2022년 감사원 보고서로 공개	○ 간략한 주요 가정과 전망 결과 공개
특징	○ 매년 국회에 제출하는 국가재정운용계획은 의무지출만 포함 ○ 기획재정부는 의무지출 외의 수입, 지출 전망에 관심도가 낮음	○ 지출효율화나 보장성강화 계획 등 담당부서의 사업계획을 반영

자료: 최슬기(2021), 「국가재정법」 및 「국민건강보험법」, 보건복지부 제출자료를 활용하여 국회예산정책처 작성

IV. 재정전망 심층 분석

1. 주요 정책 변화에 따른 재정전망

본 장에서는 주요 건강보험 정책의 변화가 건강보험 재정전망에 미치는 영향을 살펴본다. 건강보험 제도는 양출제입의 원칙에 따라 운영되는 단기보험이므로 향후 예상되는 지출 규모를 고려하여 수입 계획을 수립한다. 건강보험의 주 수입원은 보험료 수입이므로 매년 정해지는 보험료 인상률이 수입 확충을 위한 주요 제도변수임을 알 수 있다. 더불어 2023년 기준 10.97조원에 달하는 국고지원금 규모 또한 보험료 수입의 주요 변수이다. 이에 본 보고서에서는 ① 보험료율 조정에 따른 재정변화, ② 국고지원을 변화에 따른 재정변화를 시나리오별로 구분하여 분석한다.

가. 보험료율 조정

(1) 시나리오 가정

[표 28] 보험료율 조정에 따른 시나리오 개요

	가정	기본전망과의 보험료율 차이	근거
기본전망	◦ (2023~2024년) 7.09% ◦ (2025~2029년) 2.06% 인상 ◦ (2030~2032년) 8% 상한	-	◦ 최근 3년(2021~2023년) 평균 인상률(2.06%) ◦ 「국민건강보험법」 제73조제1항
시나리오 1	◦ (2023~2024년) 7.09% ◦ (2025~2032년) 2.06% 인상	8% 상한 폐지	-

주: 2023~2024년은 기결정 보험료율 준용

자료: 국회예산정책처

제Ⅲ장의 기본전망에서는 2023년과 2024년의 기결정된 보험료율(7.09%)을 준용하고 2025년 이후는 매년 2.06%(2021~2023년 평균 증가율)만큼 증가하되, 8% 상한⁵⁹⁾ 가정을 적용하였다. 보험료율 조정에 따른 건강보험 수입과 재정수지 변화를 살펴

보기 위해 본 소절에서는 보험료율 상한 폐지에 따른 시나리오 분석을 수행한다. 기본전망과 달리 보험료율 8% 상한을 폐지하여 2030~2032년에 보험료율이 지속적으로 증가한다고 가정하였으며 2032년 8.35%에 도달할 전망이다.

[표 29] 시나리오별 보험료율 가정: 2023~2032년

(단위: %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
기본전망	7.09	7.09	7.24	7.39	7.54	7.69	7.85	8.00	8.00	8.00
시나리오 1: 8% 상한 폐지	7.09	7.09	7.24	7.39	7.54	7.69	7.85	8.01	8.18	8.35

주: 1. 기본전망의 경우 2023년과 2024년의 기결정된 보험료율(7.09%)을 준용하고 2025년 이후는 매년 2.06%(2021~2023년 평균 증가율)만큼 증가하되, 8% 상한 가정을 적용함

2. 시나리오 1의 경우 보험료율 가정이 2029년까지는 기본전망과 동일하나, 2030년 이후에서 2.06%씩 증가 가정

자료: 국회예산정책처

(2) 전망 결과

보험료율 법정 상한인 8%를 폐지할 경우, 상한을 유지하는 것으로 가정했던 기본전망과 2030년부터 보험 수입과 재정수지에 차이가 발생한다. 2030년 재정수지는 10.2조원 적자, 2032년 재정수지는 12.7조원 적자 등 2030년부터 2032년까지 3년간 발생하는 건강보험 재정수지 누적적자는 기본전망 대비 11조원 감소한다.

보험료율 상한 폐지의 경우, 기본전망에서 준비금이 소진될 것으로 예상된 2028년 이후 적용되므로 준비금 소진 시점에는 영향을 미치지 못했다. 결과적으로 최근 3년 수준(2.06%)의 보험료 인상률을 가정할 경우, 보험료 상한 도달 전에 이미 재정수지 적자 폭이 확대된 상황에 직면하므로 상한 폐지만으로는 추후 급증하는 건강보험 지출 추세 하에서 재정수지를 달성하기는 어려워 보인다.

59) 「국민건강보험법」 제73조제1항1에 따라 직장가입자의 보험료율은 1천분의 80의 범위에서 심의위원회의 의결을 거쳐 대통령령으로 정한다.

[표 30] 보험료율 시나리오별 재정수지 전망: 2023~2032년

(단위: 조원)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	누적적 자 증감
기본전망 수지	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-107	-105	-105	-152	-200	-
시나리오 1: 8% 상한 폐지 (증가액)	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-107	-105	-102	-116	-127	-
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(3.5)	(7.3)	(11.0)

주: 2023년은 예산액을 준용하므로 변동하지 않음

자료: 국회예산정책처

[표 31] 보험료율 시나리오별 준비금 전망: 2023~2032년

(단위: 조원)

	준비금 소진	2032년 누적 준비금
기본전망	2028년	-61.6
시나리오 1: 8% 상한 폐지	2028년 (+0년)	-50.5 (11.0)

주: 1. 괄호는 기본전망과 각 시나리오 간 차이를 나타냄

2. 2023년은 예산액을 준용하므로 변동하지 않음

자료: 국회예산정책처

나. 국고지원을 변화

(1) 시나리오 가정

[표 32] 국고지원을 조정에 따른 시나리오 개요¹⁾

	가정	기본전망과의 국고지원을 차이	근거
기본전망	◦ (일반회계) 11.4% ◦ (기금) 담배부담금 65%²⁾	-	◦ 최근 3년(2020~2022년) 실 국고지원을 ◦ 「국민건강보험법」 제108조의2 ◦ 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항
시나리오 2-1	◦ (일반회계) 14% ◦ (기금) 담배부담금 65%²⁾	법정 지원을 준수 (기금 단서조항 ³⁾ 고려)	◦ 「국민건강보험법」 제108조의2 ◦ 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항
시나리오 2-2	◦ (일반회계) 14% ◦ (기금) 6%	법정 지원을 준수 (기금 단서조항 ³⁾ 미고려)	
시나리오 3	◦ (일반회계) 11.4% ◦ (기금) 6%	일반회계 현행 유지 및 기금 법정 지원을 준수 (기금 단서조항 ³⁾ 미고려)	

주: 1) 국고지원이 전망 기간 중 유지되는 것으로 가정함. 국고지원 규정은 2027년 12월 31일부로 일몰 예정이지만, 과거 4차례(2011년, 2016년, 2017년, 2023년) 연장된 연혁을 고려하여 2028~2032년에도 5년간 연장되는 것으로 가정

2) 2024년 예산(안)상 담배부담금 예상수입액의 65%가 전망 기간 중 유지된다고 가정

3) 기금 지원금은 당해연도 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없음

자료: 국회예산정책처

건강보험에 대한 국고지원금은 「국민건강보험법」 제108조의2에 따른 일반회계⁶⁰⁾의 지원금과 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항에 따라 담배부담금을 기반으로 하는 국민건강증진기금으로 구분된다. 동 법에 따르면 국가는 건강보험료 예상 수입액의 20%에 상당하는 금액을 지원하도록 정하고 있으나, 건강보험료 실제 수입액에 대한 국

60) 「국민건강보험법」 제99조제8항제1호(용도 제한)와 동법 시행령 제71조제1항제1호(지원 규모 명시)에 따라 과징금(요양기관이 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 보험자나 가입자, 피부양자에게 요양급여비용을 부담하게 한 경우 부과) 수입의 50%를 공단의 요양급여비용에 지급하도록 명시되어 있으며, 이에 근거해 보건복지부는 ‘건강보험가입자지원(일반회계)’ 사업에서 예산을 배정해왔다. (2023년 기준 130억원). 그러나 보건복지부는 「국민건강보험법 시행령」 제71조제1항(2023.11.20. 시행 예정)을 입법예고(2023.07.26.~2023.09.04) 함에 따라 건강보험에 대한 과징금 수입 지원 규정을 삭제하고, 2024년 “건강보험 가입자지원(일반회계)” 예산안에 별도의 예산을 책정하지 않았음. 본 전망에서는 이상의 정책 변화를 반영하여 국고지원 비율을 전망한다.

고지원금 비중은 14.1% 수준(2020~2022년 평균)이다. 국회와 의약단체 등 여러 유관 단체에서 연례적으로 법정 지원율 준수 필요성을 지적해왔으나, 국고지원율은 법정 지원율을 하회하고 있으며, 보건복지부의 예상 보험료 수입 추계 또한 결산상 보험료 수입에 미치지 못하고 있다.⁶¹⁾

기본전망에 따르면 2024년부터는 건강보험 재정수지 적자가 예상되며 국가는 건강보험 재정건전성 확보를 위한 의무가 있다.⁶²⁾ 이에 본 소절에서는 국고지원율 상향에 따른 건강보험 수입과 재정수지 변화를 세 개의 시나리오를 통해 살펴본다.⁶³⁾

한편, 건강보험에 대한 국고지원 규정을 5년 연장하는 것을 골자로 한 「국민건강보험법 일부개정법률안(대안)」과 「국민건강증진법 일부개정법률안(대안)」이 의결(23.7.27.)될 당시, 국고지원 규모와 방법 등에 대한 다양한 개정안들이 대안반영폐기되었는데, 각 의안 목록과 주요 내용은 [부록]에서 소개한다.

첫 번째 시나리오는 일반회계의 법정 지원율인 예상 보험료 수입의 14%를 지원하는 것으로 가정한다. 국민건강증진기금의 경우 건강보험에 대한 지원금이 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없다는 단서조항에 따라 기본전망과 동일하게 현행 수준을 유지한다. 두 번째 시나리오는 단서조항과 관계없이 일반회계와 국민건강증진기금 모두 법정 지원율인 예상 보험료 수입의 20%(14%+6%)를 지원한다고 가정하고,⁶⁴⁾ 마지막 시나리오에서는 일반회계 지원율을 현행 수준으로 유지하되 기금은 법정 지원율 6%를 지원하는 것으로 가정한다.⁶⁵⁾

61) 건강보험료 수입 결산상 실제 수입액과 보건복지부 예산서 상 예상 수입액의 차이는 아래와 같다.

일반회계	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
결산상 수입(조원)	47.3	50.0	53.3	58.7	62.5	69.2	76.6
복지부 추계(조원)	42.2	44.4	53.6	57.8	63.9	66.5	72.8

62) 「국민건강보험법」 상의 건강보험재정에 대한 정부지원 규모와 방식의 근거가 되는 「국민건강보험 재정건전화특별법」(2006.12.31. 만료)은 재정적자를 조기에 해소하고 재정수지의 균형을 이루도록 함을 목표로 하며, 이를 지원하기 위한 국고지원 조항을 신설하였다.

63) 「국민건강보험법」에 따른 국고지원 일몰 규정은 4차례(2011년, 2016년, 2017년, 2023년) 연장되었으므로, 본 전망에서도 국고지원 규정이 2027년 이후 연장되는 것으로 가정한다.

64) 담배부담금 결산액의 최근 5개년 연평균 증가율은 0.33%이며 뚜렷한 증가 또는 감소 추세가 발견되지 않으므로 건강보험에 대한 지원도 현행과 유사한 수준으로 이루어질 것으로 보이며, 현재 담배 부담금을 주 수입원으로 하는 국민건강증진기금은 부족한 사업비를 충당하기 위해 공공자금관리기금의 예수금을 차입하고 있는 상황이다. 이러한 배경과 현행법상에서 건강보험에 대한 기금의 지원율을 6%로 상향하는 것은 불가능하지만, 법 개정 당시의 취지를 고려하여 총 지원 비율 20%를 준용한 분석을 시행한다.

65) 21대 국회에서 발의된 「국민건강증진법 일부개정법률안」(신현영의원 대표발의, 의안번호: 2118234)

(2) 전망 결과

(시나리오 2-1) 법정 지원을 준수: 기금 단서조항 고려

국민건강증진기금 지원의 단서조항을 고려하여 법정 지원율을 준수한다고 가정할 경우, 매년 보험료 수입의 14%를 일반회계로, 담배부담금 예상수입액의 65%를 국민건강증진기금으로 지원하는 것으로 분석한다. 전망 결과, 기본전망에서 2024년부터 재정수지가 적자 전환된 것과 달리, 시나리오 2-1에서는 적자 전환 시기가 2025년으로 1년 늦춰졌으며 2032년 당기 재정수지는 16조원 적자를 나타냈다.

누적 준비금 소진 시점은 2030년으로 2년 연기됐으며, 2032년 기준 10년간 누적적자는 34조원으로 기본전망 대비 27.6조원 감소할 전망이다.

(시나리오 2-2) 법정 지원을 준수: 기금 단서조항 미고려

기금 단서조항과 관계없이 법정 지원율을 준수한다고 가정할 경우, 매년 보험료 수입의 20%를 국고지원금으로 지원하게 된다. 전망 결과, 재정수지 적자 전환 시점은 2026년으로 기본전망 대비 2년 미뤄졌으며, 2032년 당기 재정수지는 8.8조원 적자로 나타난다.

누적 준비금의 경우 2032년 누적 준비금이 12.1조원 수준으로 전망 기간 내에 고갈되지 않는 것으로 나타났다. 이는 기본전망과 시나리오 2-1에서 기금 지원금이 담배부담금 예상수입액의 65%⁶⁶⁾ 수준에서 고정된 것으로 가정한 반면에, 시나리오 2-2에서는 보험료 수입에 연동되어 지원금이 점차 인상된 것이 주요 요인이다. 참고로, 시나리오 2-2에서의 보험료 수입 6%에 해당하는 기금 지원금은 2024년 기준 5.1억원에서 2032년 9.1억원까지 증가할 것으로 예상된다.

(시나리오 3) 일반회계 현행 유지 및 기금 법정 지원을 준수(단서조항 미고려)

일반회계 지원금은 현행 수준(11.4%)을 유지하되, 국민건강증진기금은 단서조항과 관계없이 법정 지원율인 6%를 가정할 경우 재정수지 적자 전환 시점은 기본전망 대비 2년 미뤄진 2026년, 누적 준비금 소진 시점은 3년 늦춰진 2031년으로 전망된다. 2032년 기준 누적적자는 15.4조원으로 기본전망 대비 46.2조원 감소할 전망이다.

은 기금 지원금이 연례적으로 과소 지원됨에 따라 단서조항을 폐지하고 지원비율을 6%에서 3%로 낮출 것을 제안하였으나, 대안(일몰 5년 연장) 반영폐기되었다.

66) 2023년 1.8조원, 2024~2032년 1.9조원 유지 가정

[표 33] 국고지원율 시나리오별 재정수지 전망: 2023~2032년

(단위: 조원)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	누적 적자 증감
기본전망 수지	1.3	-1.4	-3.2	-6.7	-8.8	-10.7	-10.5	-10.5	-15.2	-20.0	-
시나리오 2-1: 법정 지원율 준수 (단서조항 고려)	1.3	0.8	-0.8	-4.1	-6.0	-7.6	-7.2	-6.9	-11.4	-16.0	-
(증가액)	(0.0)	(2.2)	(2.4)	(2.6)	(2.8)	(3.0)	(3.3)	(3.5)	(3.7)	(4.0)	(27.6)
시나리오 2-2: 법정 지원율 준수 (단서조항 미고려)	1.3	4.0	2.8	-0.1	-1.4	-2.6	-1.6	-0.7	-4.7	-8.8	-
(증가액)	(0.0)	(5.4)	(6.0)	(6.6)	(7.3)	(8.1)	(8.8)	(9.7)	(10.4)	(11.2)	(73.7)
시나리오 3: 일반회계 현행유지 (단서조항 미고려)	1.3	1.8	0.4	-2.7	-4.2	-5.6	-4.9	-4.3	-8.5	-12.7	-
(증가액)	(0.0)	(3.2)	(3.6)	(4.1)	(4.5)	(5.0)	(5.6)	(6.2)	(6.7)	(7.2)	(46.2)

주: 2023년은 예산액을 준용하므로 변동하지 않음

자료: 국회예산정책처

[표 34] 국고지원율 시나리오별 준비금 전망: 2023~2032년

(단위: 조원)

	준비금 소진	2032년 누적 준비금
기본전망	2028년	-61.6
시나리오 2-1: 법정 지원율 준수 (단서조항 고려)	2030년 (+2년)	-34.0 (27.6)
시나리오 2-2: 법정 지원율 준수 (단서조항 미고려)	전망 기간 내 미소진	12.1 (73.7)
시나리오 3: 일반회계 현행 유지 (단서조항 미고려)	2031년 (+3년)	-15.4 (46.2)

주: 1. 괄호는 기본전망과 각 시나리오 간 차이를 나타냄

2. 시나리오 2-2는 전망 기간 내 소진되지 않음

자료: 국회예산정책처

2. 필요 보험료율 분석

가. 재정목표별 가정

본 소절에서는 건강보험 재정목표에 대한 분석 시나리오를 세우고, 각 목표를 달성하기 위한 필요 보험료율을 도출하여 건강보험 중장기 운용을 위해 필요한 보험료율 수준을 가늠하고자 한다.

[표 35] 필요 보험료율 분석 시나리오 개요

	가정	근거
기본전망	◦ (2023~2024년) 7.09% ◦ (2025~2029년) 2.06% 인상 ◦ (2030~2032년) 8% 상한	◦ 최근 3년(2021~2023년) 평균 인상률(2.06%) ◦ 「국민건강보험법」 제73조제1항
분석 1	◦ 재정수지 균형 유지	
분석 2	◦ 2027년 12월 31일 국고지원 종료 ◦ 재정수지 균형 유지	◦ 「국민건강보험법」 제108조의2 ◦ 법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항
분석 3	◦ 준비금 소진 방지 - 보험급여비의 1개월분 수준 유지 - 준비금 소진 전까지는 재정수지 적자 허용	◦ 2022년~2026년 건강보험공단 중장기 재무관리계획 - 1~1.5개월 수준 유지 목표 제시

주: 2023~2024년은 기결정된 보험료율 준용

자료: 국회예산정책처

기본전망([표 27])에 따른 건강보험 지출 추계를 기준으로 총 세 가지의 분석 시나리오를 구성하여 ① 재정수지 균형 유지를 위한 건강보험료율, ② 국고지원 규정이 일몰(2027년 12월 31일 일몰예정)될 경우 재정수지 균형을 유지하기 위한 건강보험료율, ③ 준비금 흑자 유지를 위한 건강보험료율을 추계한다. 세 분석 모두 공통적으로 2023년과 2024년은 기결정된 보험료율 7.09%를 적용하고, 보험료율 상한(8%)은 고려하지 않는다.

첫 번째 분석에서는 재정수지 균형을 유지하기 위한 보험료율을 도출한다. 건강보험은 단기보험이므로 당해연도 수입으로 지출을 충당하는 시스템으로 운영된다. 따라서 재정수지 균형을 달성하기 위해 필요한 최소한의 보험료율을 도출하여 제도 유지를 위한 보험료율 인상률 수준을 전망한다.

두 번째 분석에서는 지금까지 연장될 것으로 가정했던 건강보험 국고지원 규정이 일몰될 경우를 가정한다. 2023년 6월 13일 개정된 「국민건강보험법」과 「국민건강증진법」은 한시적 국고지원에 대한 내용을 2027년 12월 31일까지 5년 연장하였다. 과거 일몰 규정이 4차례(2011년, 2016년, 2017년, 2023년) 연장되었으나, 항구적 지원에 대한 법적 근거는 마련되지 않은 상태이다. 따라서 본 분석에서는 국고지원이 종료되고 수입 부족분을 보험료로 충당할 경우, 재정수지 균형을 달성하기 위해 필요한 보험료율을 살펴본다. 국고지원이 유지되는 2027년까지는 분석 1과 동일한 필요 보험료율이 전망될 것이다.

마지막 분석에서는 준비금 소진 방지를 위해 당해연도 보험급여비의 1개월분을 준비금으로 유지한다고 가정한다. 준비금 운용 및 규모에 대한 공식적인 규정은 없으나,⁶⁷⁾ 국민건강보험공단이 2022년 8월 발표한 “2022~2026년 국민건강보험공단 중장기 재무관리계획”에서는 재무관리계획의 목표로 중 하나로 보험급여비 1.0~1.5개월분 유지를 명시하고 있다. 이는 미청구 급여비(급여충당부채) 지급을 대비하는 용도로, 건강보험 제도의 지속성을 확보하기 위한 장치로 이해할 수 있다.⁶⁸⁾ 한편, 본 분석에서는 준비금이 당해연도 보험급여비 1개월분까지 감소하기 전까지는 재정수지 적자를 허용한다.

67) 「국민건강보험법」 제38조제1항은 회계연도마다 결산상의 잉여금 중 그 연도의 보험급여에 든 비용의 5% 이상에 상당하는 금액을 당해연도 비용의 50%에 이를 때까지 준비금으로 적립할 것을 명시하고 있다. 이는 1999년 법률 제정 당시 유효했던 규정으로 현재 건강보험 재정 상황에는 적용하기 어려우며, 잉여금이 발생한 상황에서의 준비금 하한과 상한을 규정하고 있을 뿐이다.

68) 해당 계획서에 따르면, 한국과 유사한 제도를 운영하는 대만과 일본은 1~3개월분, 독일은 1개월 급여비의 25%를 준비금으로 보유하도록 규정하고 있다.

나. 전망 결과

(1) 재정수지 균형 유지를 위한 보험료율

매년 재정수지 균형을 유지하기 위해서는 2025년 보험료율을 7.46%까지 인상하여야 하며, 인상폭은 5.20%로 가장 높다. 2026년까지 보험료율 인상률은 4.92%로 높은데, 이는 2024년 보험료율이 동결되었으며 2025, 2026년 급여비 지출 증가율이 상대적으로 높기 때문이다. 이후 2027~2032년 전망 기간 내에는 평균 2.23% 수준의 인상률을 유지하며, 2032년 필요 보험료율은 8.93%로 전망된다.

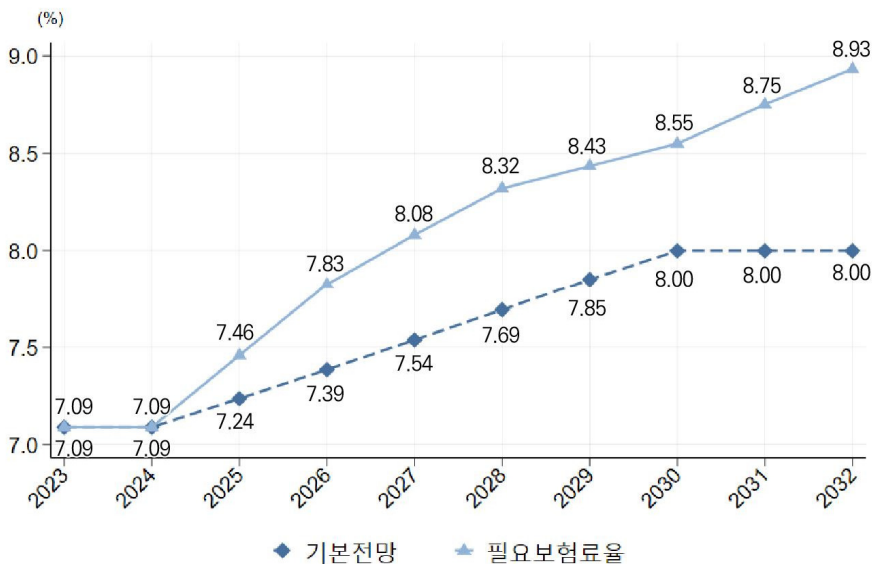
[표 36] 보험료율 가정: 재정수지 균형 유지

(단위: %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
[분석 1: 재정수지 균형 유지]										
필요 보험료율	7.09	7.09	7.46	7.83	8.08	8.32	8.43	8.55	8.75	8.93
보험료율 인상률	(1.43)	(0.00)	(5.20)	(4.92)	(3.27)	(2.95)	(1.37)	(1.37)	(2.36)	(2.07)

주: 2023, 2024년의 건강보험료율은 7.09%로 기결정되었으므로, 2025년부터 필요 보험료율을 도출함
자료: 국회예산정책처

[그림 14] 재정수지 균형 유지 보험료율 전망 결과: 2023~2032년



자료: 국회예산정책처

(2) 국고지원 종료 후 재정수지 균형 유지를 위한 보험료율

2027년 12월 31일부로 건강보험에 대한 국고지원이 종료된 후, 2028~2032년 매년 15.1~19.2조원에 해당하는 국고지원금을 보험료로 보전하기 위해서는 2028년 보험료율을 9.40%까지 급격하게 인상(16.36%)하여야 한다. 2032년 필요 보험료율은 10.06%로 전망된다.

[표 37] 보험료율 가정(2023~2032년): 국고지원 종료 후 균형 유지

(단위: %)

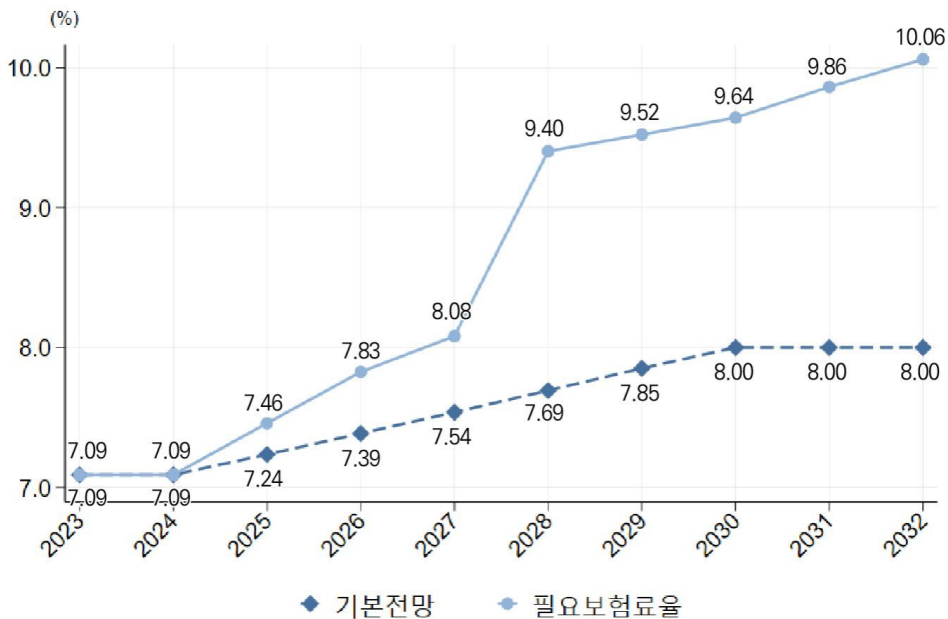
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[분석 2: 국고지원 종료 후 재정수지 균형 유지]

필요 보험료율	7.09	7.09	7.46	7.83	8.08	9.40	9.52	9.64	9.86	10.06
보험료율 인상률	(1.43)	(0.00)	(5.20)	(4.92)	(3.27)	(16.36)	(1.26)	(1.27)	(2.28)	(2.00)

주: 2023, 2024년의 건강보험료율은 7.09%로 기결정되었으므로, 2025년부터 필요 보험료율을 도출함
자료: 국회예산정책처

[그림 15] 국고지원 종료 후 재정수지 균형 유지 보험료율 전망 결과:
2023~2032년



자료: 국회예산정책처

(3) 준비금 소진 방지: 보험급여비의 1개월분 유지

기본전망 결과에 따르면([표 27]), 2023~2026년의 경우 이미 보험급여비의 1개월분에 해당하는 금액 이상을 준비금으로 적립하고 있으므로 추가 준비금이 필요한 2027년부터 필요 보험료율을 도출하였다.

분석 결과, 준비금 소진 방지를 위해서는 2027년 보험료율을 8.41%까지 인상하여야 하며, 인상폭은 13.90%로 대폭 증가한다. 2026년까지는 누적 준비금을 소진하고, 2027년부터 남은 준비금이 필요 준비금(보험급여비 1개월분)보다 적어짐에 따라 추가 준비금이 요구되기 때문이다. 이후 2028~2032년에는 전년도 준비금을 수입에 충당한 후 필요 준비금을 적립하는 형식으로, 보험료율 인상율을 평균 2%대로 유지할 필요가 있는 것으로 전망되었다. 2032년 필요 보험료율은 9.29%로 예상된다.

[표 38] 보험료율 가정: 준비금 소진 방지

(단위: 조원, %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[분석 3: 건강보험 준비금 소진 방지]

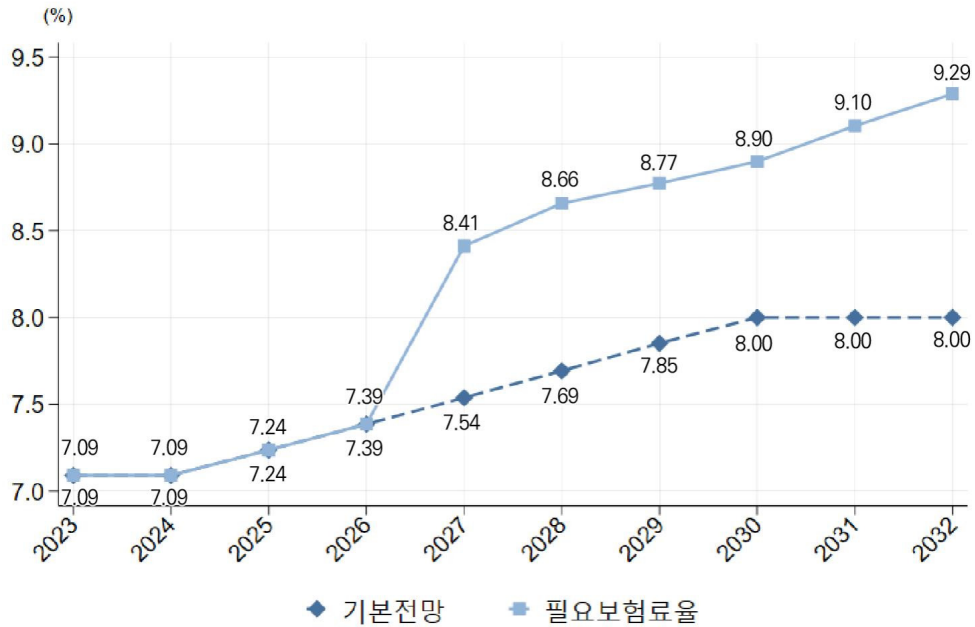
필요 준비금 (보험급여비 1개월분)	25.2*	23.6*	20.2*	13.2*	10.8	11.7	12.6	13.5	14.6	15.9
필요 보험료율	7.09	7.09	7.24	7.39	8.41	8.66	8.77	8.90	9.10	9.29
보험료율 인상률	(1.43)	(0.00)	(2.06)	(2.06)	(13.90)	(2.92)	(1.34)	(1.43)	(2.31)	(2.03)

주: 1. 괄호는 전년대비 인상률임

2. *는 기본전망 가정에서의 준비금으로, 이미 보험급여비 1개월분을 상회하므로 필요 보험료율 도출이 필요하지 않음

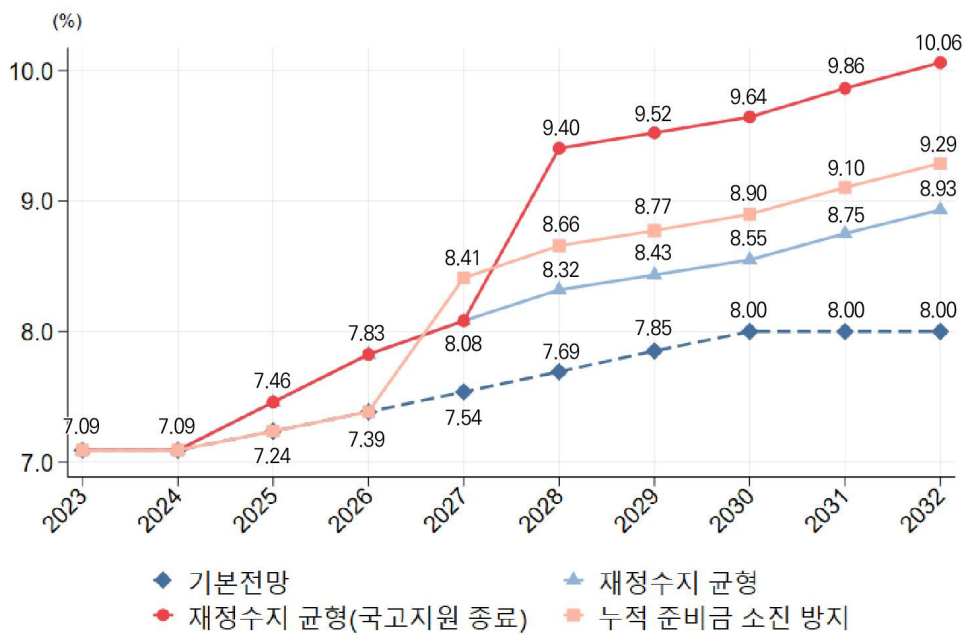
자료: 국회예산정책처

[그림 16] 준비금 소진 방지 보험료율 전망 결과: 2023~2032년



자료: 국회예산정책처

[그림 17] 재정목표별 필요 보험료율 전망 결과 요약: 2023~2032년



자료: 국회예산정책처

V. 결 론

1. 분석결과 요약

본 보고서는 전 국민을 가입 대상으로 하는 건강보험 제도의 연혁과 재정구조, 가입자의 의료이용 현황 등을 살펴보았으며 건강보험 재정전망 결과를 제시하여 향후 건강보험 재정건전성을 검토하였다. 특히 다양한 정책 시나리오에 따른 건강보험 재정의 변화를 비교·분석함으로써 향후 제도 운영의 시사점을 도출하고자 하였다.

건강보험 재정은 2022년 기준 수입 88.78조원, 지출 85.15조원으로 3.63조원의 당기수지 흑자를 보였으며, 이는 최근 코로나19로 인한 의료이용 감소 효과가 축소되고 있음을 보여준다. 코로나19의 영향력이 강했던 2020년의 급여비 증가율은 2.8%에 불과했으나, 2021년, 2022년 증가율은 각각 8.0%, 8.6%로 최근 10년(2013~2022년) 연평균 증가율 8.4% 수준을 회복했다.

이러한 건강보험 지출 증가에도 불구하고 2022년 당기수지 3.63조원의 흑자를 낼 수 있었던 것은 보험료 수입을 중심으로 한 건강보험 수입이 증가하였기 때문이다. 그러나 2022년 9월 시행한 2단계 부과체계 개편으로 인한 보험료 수입 증가분의 감소가 예상되며,⁶⁹⁾ “4차 보장성강화 대책”(2018.8)의 영향과 급격한 고령화 추세로 보험급여비 지출이 지속적으로 증가할 전망이다.

이에 본 보고서는 조성법과 OECD(2006, 2013) 모형에 기반한 국회예산정책처(NABO) 모형으로 향후 10년(2023~2032년)에 대한 건강보험 재정전망을 수행하였으며, 재정전망 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 기본전망⁷⁰⁾의 경우, 건강보험 수입은 2023년 93.3조원에서 보험료 수입 및 국고지원금 증가에 따라 연평균 7.2%씩 꾸준히 증가하여 2032년 175.2조원에 도달할 전망이다. 지출은 2023년 92조원에서 2032년 195.1조원까지 연평균 8.7% 증가할 전망이며, 이러한 추이는 총지출의 약 97%를 차지하는 보험급여비의 증가 추이를

69) 보건복지부에 따르면, 2022년 2월 추계 기준으로 2단계 부과체계 개편은 연 2.1조원 수준의 보험료 수입 감소를 유발할 전망이다.

70) 2024년은 보험료를 동결, 2025년~2032년은 최근 3년 평균 인상률(2.06%)을 가정(단, 2030년에 보험료를 상한 8% 도달 후 고정)한 결과이다.

따르는 것이다. 건강보험 재정수지는 2023~2032년 전체 전망기간 동안의 연평균 지출 증가율이 수입 증가율을 상회하면서 2024년부터 적자가 지속될 것으로 전망된다. 적자 폭은 2024년 1.4조원부터 2032년 20조원까지 매년 확대되다가 2028년에는 준비금이 고갈될 전망이다.

둘째, 주요 정책 변화에 따른 시나리오 분석을 수행하여 향후 정책 결정에 참고자료를 제공하고자 하였다. 주요 정책 변화로는 (1) 보험료율 조정, (2) 국고지원을 상향 설정하였다. (1) 보험료율 조정의 경우 기본전망에서 2030년 이후 보험료 8% 상한을 적용한 것과 달리 시나리오(1)에서 상한을 폐지할 경우, 2032년 보험료율은 8.35%까지 증가하고 2032년 누적적자는 50.5조원으로 기본전망 대비 11조원 감소한다. 다만, 기본전망에서 준비금이 소진될 것으로 예상된 2028년 이후인 2030년부터 보험료율을 인상함에 따라 준비금 소진 시점에는 영향을 미치지 못했다. 결과적으로 최근 3년 수준(2.06%)의 보험료 인상률을 가정할 경우, 보험료 상한 도달 전에 이미 재정수지 적자 폭이 확대된 상황에 직면하므로 상한 폐지만으로는 추후 급증할 건강보험 지출 추세 하에서 재정수지를 달성하기는 어려워 보인다.

(2) 국고지원을 변화에 따른 분석에서는 세 가지 시나리오를 적용하였다. 시나리오(2-1)에서 일반회계는 법정 지원율인 보험료 예상 수입액의 14%, 국민건강증진기금은 담배부담금 예상수입액의 65%(단서조항 준용⁷¹⁾) 지원을 가정할 경우, 적자 전환 시점은 2025년으로 기본전망 대비 1년, 준비금 소진 시점은 2030년으로 2년 연장되었다. 다음으로 시나리오(2-2)는 법정 지원율인 일반회계 14%, 국민건강증진기금 6%(단서조항 고려하지 않을 경우)를 가정하였으며, 이 경우 적자 전환 시점은 2026년으로 기본전망 대비 2년 연장되고 전망 기간 중 준비금은 소진되지 않는 것으로 나타나 전체 시나리오 중 재정 개선 효과가 가장 크게 나타났다. 마지막으로 시나리오(3)에서는 일반회계는 현행 수준(11.4%)의 지원율을 유지하되, 국민건강증진기금은 6%를 지원하는 것으로 가정하였다. 분석 결과, 적자 전환 시점은 2026년으로 2년, 누적 준비금 소진 시점은 2031년으로 3년 연장되었다.

셋째, 기본전망에서 가정했던 보험료율 상한(8%)을 고려하지 않고 각 재정목표별로 요구되는 필요 보험료율을 분석하여 추후 보험료율 논의에 참고자료를 제공하고자 했다. (1) 당해연도 재정수지 균형 유지를 위해서는 2027년에 8.08%, 2032년에

71) 건강보험에 대한 국민건강증진기금 지원금은 당해연도 담배부담금 예상수입액의 65%를 초과할 수 없다.

8.93%의 보험료율을 부과하는 등 향후 10년간 평균 2.61% 수준의 인상률을 유지하여야 한다. (2) 2027년부터 건강보험에 대한 국고지원(일반회계+국민건강증진기금)이 종료된 후 2028~2032년 매년 15.1~19.2조원에 해당하는 국고지원금을 보험료로 보전하고 재정수지 균형을 이루기 위해서는 2032년 보험료를 10.06%까지 인상할 필요가 있다. (3) 준비금 소진 방지(보험급여비 1개월분 유지)를 위해서는 2026년까지 적자발생분을 준비금으로 충당한 후, 2027년 보험료율을 8.41%까지 급격하게 인상(13.90%)하여야 한다. 이후에는 전년도 준비금을 수입에 충당한 후 필요 준비금을 적립하는 형식으로, 2032년 필요 보험료율은 9.29%로 예상된다.

2. 정책적 시사점

가. 수입 확충을 위한 건강보험 제도 및 관련 법령에 대한 논의 필요

(1) 국고지원금

「국민건강보험법」, 「국민건강증진법」에 따른 국고지원 한시규정은 2022년 12월 31일부로 일몰되었음에도 불구하고 일몰을 5년 연장하는 개정안은 2023년 6월에서야 시행되었다. 결과적으로 2023년 보건복지부 예산안에는 법적 근거 없이 국고지원금이 배정되었으며, 법적 근거의 부재로 예산 배정이 9월 이후로 미뤄지고 있는 상황이다.

2028년부터 건강보험 누적 준비금이 적자 전환될 것으로 전망되는 만큼 한시법 일몰 전에 해당 조항에 대한 충분한 논의를 거치고 법 개정을 통해 안정적 수입을 확보할 필요가 있다. 「국민건강보험법」 상의 건강보험 재정에 대한 정부지원 규모와 방식의 근거가 되는 「국민건강보험 재정건전화특별법」(2006.12.31. 만료)은 재정적자를 조기에 해소하고 재정수지의 균형을 이루도록 함을 제안 이유로 했다. 국가의 건강보험 재정에 대한 책임이 있는 만큼 재정 안정화를 위한 정책 추진이 필요하다.

한편, 21대 국회에서 논의된 건강보험 국고지원과 관련한 다양한 안들도 검토할 필요가 있다. 「국민건강보험법 일부개정법률안(대안)」(의안번호 제2122111호)⁷²⁾이 의결되면서 총 9개 의안이 대안반영 폐기되었다.⁷³⁾ 해당 안들의 내용을 넓게 분류하자면,

(1) 결산 기준 국고지원율 산정, (2) 국고지원율 상향, (3) 항구적 법제화 등이다.

72) 「국민건강보험법 일부개정법률안(대안)」(의안번호 제2122111호)는 국민건강보험공단에 대한 국고 지원 기간을 정한 규정을 2022년 12월 31일에서 5년 연장하여 2027년 12월 31일로 변경하였으며, 2023년 6월 13일 공포되었다.

73) 의안 리스트와 의안별 자세한 내용은 부록에 제시하였다.

(1)의 경우, 현재 예상 보험료 수입 대비 국고지원율을 산출함에 따라 발생하는 국고지원금의 변동성을 줄이고 정부의 의지에 따른 보험료 수입 추계 조정을 방지하기 위한 방안이다. (2) 국고지원율 상향의 경우, 해석의 여지가 존재하는 “14%에 상당하는 금액”이라는 모호한 표현을 제외하고 명확한 수치를 명시하여 정부의 지원을 조정을 방지하고 지원 비율을 상향하기 위한 내용이다. 이상의 방안들은 건강보험 누적 준비금 적자 전환(2028년)과 일몰 도래(2027년) 이전에 논의가 마무리될 필요가 있다.⁷⁴⁾

(2) 국민건강증진기금 단서조항 삭제

법률 제6619호 「국민건강증진법」 부칙 제2항에 따라 국민건강증진기금에서 당해연도 예상수입액의 6%에 상당하는 금액을 지원하도록 규정하고 있다. 그러나 기금 지원액은 담배 부담금 예상 수입액의 65%를 초과할 수 없다는 단서조항으로 인해 연례적으로 결산 기준 수입의 3%를 하회하는 금액이 지원되고 있다. 이는 보험료 수입이 14.3조원 수준이던 2002년에 시행된 내용이므로 지원 규모의 현실화가 필요해 보인다.

21대 국회에서는 「국민건강증진법 일부개정법률안(대안)」(의안번호 제2122117호)⁷⁵⁾도 함께 의결되고 총 7개 의안이 대안반영 폐기되었다. 대안에서는 기금 지원 연장만 다루고 있으나, 당시 논의된 기금 지원 방안도 살펴볼 필요가 있다.⁷⁶⁾ 개정안들의 내용은 앞서 살펴본 「국민건강보험법」과 대동소이하여 (1) 결산 기준 지원을 산정, (2) 국고지원율 변경, (3) 항구적 법제화 등을 담고 있다. 다만, 단서조항을 고려하여 기금 국고지원율을 하향하는 안들이 대다수였으며, 그 중 2개의 의안⁷⁷⁾만이 단서조항을 삭제하는 내용을 담고 있었다.

74) 한편, 정부는 「국민건강보험법 시행령」 개정(2023.11.20. 시행 예정)을 통해 과징금 수입에서 건강보험 재정에 지원하는 규정을 삭제함에 따라(2023년 기준 130억원) 2024년 “건강보험 가입자 지원(일반회계)” 예산안에 별도의 예산을 책정하지 않았다.

75) 「국민건강증진법 일부개정법률안(대안)」(의안번호 제2122117호)은 국민건강증진기금의 국민건강보험공단에 대한 지원 기간을 정한 부칙의 규정을 2022년 12월 31일에서 5년 연장하여 2027년 12월 31일로 변경하였으며, 2023년 6월 13일 공포되었다.

76) 의안 리스트와 의안별 상세 내용은 부록에 제시하였다.

77) 정춘숙의원안(의안번호 제2104289호), 신현영의원안(의안번호 제2118234호)

(3) 보험료율 상한

마지막으로, 보험료율 8% 상한에 대한 사회적 논의가 개시될 필요가 있다. 본 보고서의 기본전망에 따르면, 보험료율은 2030년 8%에 도달할 전망이다. 이는 2024년 보험료율 인상률 동결, 이후 2.06% 인상 가정을 적용한 것으로 추후 인상률에 따라 2030년 이전에 도달할 가능성도 있다. 보험료 수입이 감소할 경우, 현재 보험료 수입에 연동되어 배정되는 국고지원금의 규모도 축소될 수 있다. 다만, 건강보험은 전 국민을 가입자로 하는 제도로써 건강보험료는 준조세의 성격을 지니고 있다. 따라서 향후 보장성 확대 수준과 그에 따른 적정 건강보험료 상한에 대한 사회적 논의와 그에 따른 합의가 사전에 마련되어야 할 것이다.

한편, 정부는 “제1차 건강보험종합계획”(2019.9)에서 안정적인 재정운용을 위해 보험료율 인상율을 3.2% 수준에서 관리하겠다고 밝혔으나, 2020년 인상(3.20%) 이후에는 2021년(2.89%), 2022년(1.89%), 2023년(1.49%) 수준으로 하향 조정하였다. 대내외 변화에 대응하여 보험료율 인상률을 조정하는 것은 당연한 수순이지만, 매년 발표하는 시행계획에는 이러한 보험료율 조정 방안이나 근거가 제시되고 있지는 않다. 2023년 2월 발표한 「건강보험 지속가능성 제고방안」에서는 기존에 5년마다 보고하던 전망 보고를 매년 시행계획(단년도 전망) 보고 시 수행할 계획을 밝힌 만큼, 전망과 함께 가정에 활용한 보험료율, 필요 보험료율 등을 함께 공시할 필요가 있다.

나. 건강보험 지출효율화

건강보험에 대한 국고지원 규정이 안정되고 보험료 등의 조정으로 수입 확충방안이 마련될지라도, 고령화와 보장성 확대에 따른 건강보험 지출 증가율이 지속적으로 상승한다면 제도는 지속 가능하지 않다. 건강보험 지출 증가의 요인은 고령화와 보장성 확대 외에도 과다 의료이용⁷⁸⁾, 실손보험 보장⁷⁹⁾, 불법 개설기관 및 부당청구 등 의료 이용자와 공급자를 아우르는 다양한 문제들이 얹혀있다. 본 소절에서는 그 중에서도 정부 차원에서 장기적 시각으로 관리할 필요가 있는 건강보험의 구조적 문제를 살펴보고자 한다.

78) 개인의 과다 의료 이용(의료 쇼핑), 의료 전달 체계 문제(상급병원 쏠림) 등이 포함된다.

79) 관대한 실손보험 보장에 따라 의료기관의 급여 진료 항목이 증가하고 비급여 진료비가 인상되는 현상이 관찰되고 있다.

정부는 「필수의료 지원대책-중증·응급, 분만, 소아진료를 중심으로」(2023.1.31.)와 「건강보험 지속가능성 제고방안」(2023.2.28.) 등을 통해 기존 보장성 강화 계획을 재점검할 것을 밝혔으나, 당초 세부 항목 47개 중 38개 항목⁸⁰⁾인 약 80%가 이미 급여화 되었고, 비대면 진료 등 신규 수가가 계속해서 등재되기 때문에 기존의 급여비 증가 추이를 억제하기는 쉽지 않다.

이처럼 우리나라 의료서비스 지불제도는 행위별수가제를 근간으로 하기 때문에 총 의료비용이 증가할 수밖에 없는 구조이다. 행위별수가제는 의료인이 제공하는 의료서비스(행위, 약제, 치료재료 등)별로 가격(수가)을 책정하여 사용량에 따라 총 의료비용을 제공하는 형태이기 때문에 의료인의 자율성이 크고 과잉진료의 유인이 있어 진료비 통제가 어렵다. 일례로, 1977년 수가제 도입 당시 수가는 763개 항목이었으나 2023년 2월 기준 9,184개 항목으로 10배 이상 증가하였다. 이러한 지불제도를 보완하고 의료자원을 효율적으로 활용하기 위해 포괄수가제⁸¹⁾, 인두제⁸²⁾, 총액제와 같이 진료비 통제 가능한 ‘선불제’ 도입이 논의되어 왔으며, 7개 질병군에 대한 포괄수가제(DRG)와 정액수가제(요양기관, 보건기관 등), 실포괄수가제⁸³⁾를 일부 시행하고 있다.

그러나 실포괄수가제는 일부 병원을 대상으로 입원환자의 진료비를 관리하는 시범 사업으로 미시적 관리방안의 하나이다. 중장기 재정 안전성을 위해서는 구조적 개혁이 요구되며, 2023년 하반기 발표할 “제2차 건강보험종합계획(2024~2028년)”에는 지출 구조 개혁을 위한 구체적인 안이 제시될 필요가 있다.⁸⁴⁾

80) 초음파(복부, 생식기, 심장 등), MRI(뇌, 척추 등), 등재 비급여(노인·여성·아동 등 의료취약계층 질환, 중증질환 등), 선택진료비 폐지, 취약계층 지원(틀니, 난임치료수술) 등이 급여화되었으며, 혈관 및 근골격 초음파, 근골격계 MRI 등 6개 항목을 재검토하거나 조건부 급여화하기로 밝혔다.

81) 포괄수가제는 질병군별로 입원환자의 진료비를 보상하는 제도이다. 입원기간 동안 제공된 검사, 수술, 투약 등 의료서비스의 종류나 양에 관계없이 어떤 질병의 진료를 위해 입원하였는지에 따라 미리 책정된 일정금액을 보상한다.

82) 인두제는 등록자 수에 따라 비용을 지불하는 방식으로, 의료인의 환자 수에 1인당 단가를 곱하여 보수를 결정하며 일차의료에 적합하다.

83) 행위별수가제와 일부 질병군에만 적용하는 포괄수가제(7개)의 대안적 모델로, 포괄적 보상(기준 수가+일당수가)과 행위별 보상방식이 혼합된 형태다. 대부분의 의료서비스를 포괄로 묶고, 진료비 차이를 유발하는 고가 서비스를 행위별수가로 보상하는 제도이다.

84) 정부는 「건강보험 지속가능성 제고방안」(2023.2.28.)에서 지출 구조 개혁을 추진하겠다는 계획을 밝혔으나, 구체적인 안을 제시하지는 않은 상황이다.

다. 재정전망 수행 및 결과 공개의 필요성

건강보험은 당해연도 보험료 수입으로 당해연도 지출을 충당하는 단기성 보험이며, 양출제입의 원칙에 따라 예상되는 지출 규모를 고려하여 수입 계획을 수립한다. 이러한 건강보험 제도의 특성으로 인해 건강보험 중장기 재정전망의 필요성이 저해되기도 한다.

특히 정부의 재정전망 사례(제Ⅲ장의 [참고자료] 참조)에서도 살펴본 바와 같이, 다른 사회보험⁸⁵⁾과 달리 건강보험 재정은 국가재정이 아닌 국민건강보험공단 회계로 운영되고 있다.⁸⁶⁾ 따라서 건강보험 재정의 운용 및 예·결산은 국회의 심의·의결을 받지 않고 있으며, 「국가재정법」과 「국민건강보험법」에 따른 전망 및 결과 공개 또한 제한적으로 수행되고 있는 실정이다.⁸⁷⁾

비록 건강보험이 단기보험으로 운영되고 정부와 공단의 재정안정화를 위한 제도변수(보험료율, 보장성 범위 등)의 조정이 가능하다고 할지라도, 건강보험료가 준조세의 성격을 가지고 있다는 점을 감안한다면 건강보험정책심의위원회나 정부가 제약 없이 주요 제도변수를 조정하는 것은 재정 통제의 기능 측면에서 바람직하지 않다.⁸⁸⁾ 따라서 건강보험 재정을 국가재정에 포함하는 건강보험의 기금화를 비롯하여 건강보험 재정운영에 대한 절차적 통제 강화 방안을 마련할 필요가 있으며, 특히 법률과 정책 변화에 따라 실시하는 재정전망 결과를 투명하게 공개하고 교차 검증을 거쳐 향후 정책방향에 대한 사회적 합의를 도출할 필요가 있다.

85) 4대 연금(국민연금·공무원연금·사학연금·군인연금) 및 고용보험·산재보험을 포함한다.

86) 노인장기요양보험도 국가재정 외로 운용되고 있다.

87) 이에 21대 국회에서도 건강보험 재정을 국고에 포함(기금화)하려는 법안이 발의되었다.(서정숙 의원 대표발의안(의안번호 제2118157호), 강기운의원 대표발의안(의안번호 제2104727호))

88) 한편 감사원은 「건강보험 재정관리 실태 감사보고서」(2022)에서 연간 6,407억원의 재정 투입이 예상된 안건들이 건강보험정책심의위원회의 심의·의결 없이 결정된 사례와 정책의 재정효과에 대해서 정부가 의도적으로 위원들에게 충분한 자료를 제공하지 않은 사례를 지적하였다.

부 록

1. 건강보험 수입 추계 모형

건강보험 수입은 건강보험료 수입에 국고지원금과 기타수입을 합하여 추계한다.

먼저, 건강보험료 수입은 통계청 장래인구추계로부터 도출한 장래 납부자 수 전망치에 1인당 보수월액과 해당연도 보험료율을 곱하여 추계한다.⁸⁹⁾ 이때, 납부자 수와 보수월액은 가입자 유형별(직장가입자(근로자, 공무원, 교원), 지역가입자)·연령군별(5세 단위)로 구분하며 각각 추계인구 대비 납부자 수 비율, 최근 보수월액 증감 추이를 반영하여 전망한다.

국고지원금은 해당 연도 보험료 수입에 보험료 수입 대비 국고지원 비율을 곱하여 추계한다. 국고지원 비율은 일반회계와 국민건강증진기금을 구분하여 해당 연도 보험료 수입액(결산)을 기준으로 계산한 각각의 실 국고지원 비율을 활용한다. 국고지원 비율은 최근 3년 평균 비율이 전망 기간 중 유지되는 것으로 가정한다.

마지막으로 기타수입은 보험료 수입액 대비 기타수입 비율을 반영하여 추계한다. 국고지원금과 마찬가지로 최근 3년 평균 비율이 전망 기간 중 유지되는 것으로 가정한다.

89) 지역가입자의 경우, 건강보험료율을 기준으로 환산한 가상의 보수월액을 토대로 보험료를 산출하였다.

[표] 건강보험 수입 추계 방법

항목	산 식
수입	건강보험료 수입 + 국고지원금 + 기타수입
건강보험료 수입	$\sum_{j=1}^4 \sum_{a=1}^{15} (\text{납부자 수}_{ajt} \times 1\text{인당 평균 보수월액}_{ajt} \times 12\text{개월} \times \text{보험료율}_t^{3)})$ +소득월액 보험료⁴⁾+부과체계 개편에 따른 수입 변화분⁵⁾ 1) 가입자유형별·연령군별 납부자 수 추계 납부자 수_{ajt} = 인구_{at}[*] × 인구 대비 납부자 수 비중_{aj}^{**} * 통계청 장래인구추계 ** 최근 3년 평균 a는 5세 단위 15개 연령그룹(19세 미만, ..., 85세 이상) j는 가입자 유형(직장가입자(근로자/공무원/교원), 지역가입자) t는 추계연도 2) 1인당 평균 보수월액 추계 1인당 평균 보수월액_{ajt} = 1인당 평균 보수월액_{ajt-1}[*] × 증가율_{aj}^{**} * 1인당 평균 보수월액_{ajt} = 연도말 산정 총 보험료_{ajt} ÷ 납부자 수_{ajt} ÷ (보험료율_t × (1-0.5k)) k는 건강보험 가입유형(1=직장, 0=지역) **직장가입자는 2023년의 경우 최근 3년(2020~2022년) 평균, 이후는 과거 3년(2019~2021년) 평균 적용 지역가입자는 전망 기간 중 과거 3년(2019~2021년) 평균 적용⁹⁰⁾ 3) 보험료율 가정 2023, 2024년은 기결정된 7.09%, 이후는 매년 2.06%씩 인상하는 것으로 하되, 8% 상한 규정 적용 4) 소득월액 보험료 추계 2단계 부과체계 개편이 시행된 2022년 연도 말 산정 소득월액이 매년 증가하는 것으로 가정 5) 부과체계 개편에 따른 수입 변화분 지역가입자 보험료 수입 감소분과 피부양자 보험료 수입 증가분에 보험료 및 보험료율 인상률 적용
국고지원금 (일반회계)	건강보험료 수입 _t × 보험료 수입 대비 정부지원 비중 _t ¹⁾
국고지원금 (기금)	2024년 담배부담금 예상수입액 65% 유지 가정
기타수입	건강보험료수입 _t × 보험료 수입 대비 기타수입 비중 _t ¹⁾
	1) 최근 3년 평균 기타수입 비중 유지 가정

90) 2022년 부과체계 개편이 지역가입자 보험료에 미친 영향을 배제하기 위해 과거 3년 평균 증가율을 적용한다. 직장가입자의 보수월액 보험료의 경우 제도의 영향을 받지 않으므로 최근 3년 평균 증가율(직역 평균 3.5%)을 적용하나, 이후는 NABO 명목임금상승률 하락 전망을 고려하여 과거 3년 추이(직역 평균 3%)가 유지된다고 가정한다.

2. 건강보험 지출 추계 모형⁹¹⁾

부록에서는 본문에서 간단히 다루었던 인구요인, 소득요인, 잔차 요인별 추계 방법을 살펴본다.

인구요인

먼저, 인구요인에 의한 급여비 증가율은 t 기 기준 1인당 급여비를 $t+1$ 기의 고령화된 인구구조에 반영하여 장래 급여비 총액을 산출하고 $\frac{\text{급여비총액}}{\text{명목 GDP총액}}$ 증가율을 계산한다. 이 때, 급여비는 성별, 연령별(1세 단위)로 구분하고 사망자와 생존자⁹²⁾의 급여비 차이를 반영하고, 그룹별 해당 인구수를 나누어 1인당 급여비를 산출한다.

OECD(2013)에 따르면 노인인구 비중(고령화) 그 자체보다는 사망까지 남은 시간이 의료비용 지출에 매우 중요한 영향을 미친다. 따라서 사망 직전에 급증하는 의료비와 사망에 근접한 인구 비중을 인구요인에 고려할 필요가 있다. 본 전망에 활용한 2022년 데이터를 기준으로 사망자 진료비는 남성의 경우 생존자의 19배, 여성은 14배가 높은 것으로 확인되었다.

추가로, 본 전망에서는 기대수명 연장에 따른 “건강한 고령화”를 가정한다. 이는 질병상태의 압축(compression of morbidity) 이론⁹³⁾에 따라 증가한 기대수명만큼 건강하게 지내는 시간이 길어지지만, 사망 전 질병상태의 기간은 늘어나지 않는다고 가정한다. 현재 연령에서 미래 각 연도에 예측된 출생 기대여명(life expectancy at birth) 증가분을 차감한 유효연령⁹⁴⁾을 구하고, 전망 시에는 실제 연령 대신 유효연령을 적용한다.

91) 이태진, 「건강보험 중장기 재정추계 방법론 연구」, 국회예산정책처(2020)와 김우현, 「건강보험 보장성 강화 정책의 효과 분석」, 한국조세재정연구원(2018)을 참고하여 작성하였다.

92) 성별, 1세별, 사망여부별 급여비는 국민건강보험공단 빅데이터실로부터 제공받았다. 사망자의 급여비는 사망일자와 진료일자를 고려하여 사망 전 1년간 발생한 총 급여비를 의미하며, 생존자 급여비는 당해연도 전체 급여비에서 사망자 급여비를 차감하여 산출한다.

93) Fries(1992), Fries(2002)

94) 예시로, 2025년 70세 노인이 2009년 67세의 건강수준을 유지하고, 2050년 70세 노인이 2009년 64세의 건강수준을 유지한다면, 2025년 70세 노인은 2009년 67세 노인과 같은 의료비 수준을 유지하고 2050년 70세 노인은 2009년 64세 노인과 같은 의료비 수준을 유지한다고 가정한다.

소득요인

소득요인에 의한 급여비 증가율은 1인당 명목 GDP 증가율에 소득탄력성을 곱하여 산출한다. 소득탄력성이란 의료서비스 구매자의 소득이 증가하였을 때 의료서비스에 대한 수요가 어떻게 변화하는지를 측정하는 것으로 1을 초과할 경우 수요가 탄력적인 것으로 해석한다. 선행연구 결과를 종합한 Marino et al.(2017)은 소득탄력성이 집계 수준(개인, 국가 등)과 관계없이 1보다 작은 필수재이며 0.7~0.8수준에서 수렴하는 것으로 보았다.

잔차요인

잔차는 급여비 증가분에서 인구구조 요인과 소득요인을 제외한 모든 요인에 해당하며, 상대가격 변화, 신의료기술 발전, 건강보험 정책 및 제도 등이 포함된다. 잔차를 구성하는 요인들은 가변적이며 측정이 불가능한 경우가 많기 때문에 각 구성 요인들을 식별하여 추정하기에는 어려움이 있다. 따라서 잔차 지출 증가율은 의료비 지출 증가율에서 인구와 소득효과로 인한 지출 증가율을 차감한 값으로 정의한다. OECD(2016)에서 제시한 OECD 국가 평균 잔차(1995~2009)는 2.0%이며, 보건의료 제도가 안정된 선진국일수록 잔차 규모가 낮게 나타난다.

[표] 건강보험 지출 전망 모형

항목	산 식
건강보험 재정지출	건강보험 요양급여비 + 현금급여비 + 건강검진비 + 관리운영비 등 $\Delta \log \left(\frac{HE}{Y} \right) = \Delta \log(demo) + \Delta \log(Res) + (\epsilon - 1) \Delta \log \left(\frac{Y}{N} \right)$ $\Leftrightarrow \frac{\dot{HE}^{1)}}{Y} = Demo^{2)} + Res^{3)} + (\epsilon - 1) \left(\frac{\dot{Y}}{N} \right)^{4)}$
건강보험 급여비	1) 명목 GDP 대비 급여비 증가율 2) 인구구조 요인에 의한 명목 GDP 대비 급여비 증가율 (가정 1-1) 성별, 연령별(1세별), 사망여부별 급여비 증가율 산출 $HE_t = \sum_{d=1}^2 \sum_{s=1}^2 \sum_{a=1}^{101} (HE_{a,s,d,t} = \text{기준연도} \times Pop_{a,s,d,t})$ a는 1세 단위 101개 연령그룹(0세, 1세, ..., 100세 이상) s는 성별(1=남, 2=여) d는 사망여부(1=사망자, 2=생존자) $Pop_{a,s,d,t}$는 성별, 연령별, 사망여부별 장래인구추계 (가정 1-2) 기대수명 연장에 따른 “건강한 고령화” 가정 $Eff_Age_t = Age_t - (Life_Exp_t - Life_Exp_{t = \text{기준연도}})$ Eff_Age_t는 유효연령(effective age) $Life_Exp_t$는 기대수명 3) 잔차 요인에 의한 명목 GDP 대비 급여비 증가율 $Res = \dot{HE} - Demo - \dot{Y}$ $\dot{HE}$ 연평균 급여비 증가율 $Demo$ 연평균 인구 증가율 $\dot{Y}$ 연평균 명목 GDP 증가율 4) 소득요인에 의한 명목 GDP 대비 급여비 증가율 ϵ는 소득탄력성
현금급여비, 건강검진비, 관리운영비 등	급여비_t × 급여비 대비 각 항목의 비중¹⁾ 1) 급여비 대비 각 항목의 비중을 로그함수로 fitting

3. 민감도 분석 결과

기본전망에서는 ‘건강한 고령화’를 가정을 통해 기대수명 연장 및 사망률 하락에 따라 급여비 증가 속도가 완화될 것을 가정하였으나, 부록에서는 이를 고려하지 않고 실제연령에 기반한 분석 결과를 제시한다.

분석 결과, 건강보험 지출은 2023년 92조원에서 2032년 204.6조원으로 연평균 9.3% 증가하여 기본전망보다 더 높은 증가율을 보인다. 재정수지는 2024년부터 적자로 전환되며, 2032년에는 29.5조원의 당기수지 적자가 예상된다. 누적 준비금의 경우 2027년 소진되어 2032년에는 누적 적자액이 107.7조원에 달할 전망이다.

[건강보험 재정수지 및 준비금 전망: 2023~2032년]

(단위: 조원, %)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	연평균 증가율
수입	93.3	98.8	106.5	114.9	123.9	133.7	144.3	155.6	165.0	175.2	7.2
지출	92.0	101.3	112.4	124.6	136.0	147.9	160.6	174.3	188.9	204.6	9.3
재정수지	1.3	-2.5	-6.0	-9.7	-12.1	-14.2	-16.3	-18.7	-24.0	-29.5	
누적 준비금	25.2	22.7	16.7	7.0	-5.1	-19.3	-35.6	-54.3	-78.3	-107.7	

주: 누적 준비금은 결산상 잉여금을 뜻하며, 음수로 표기된 준비금은 준비금 소진 후 발생한 누적 적자액을 뜻함

자료: 국회예산정책처

[참고] 의료비 추계 모형 비교⁹⁵⁾

- 의료비 지출 전망 모형은 분석 단위에 따라 세 가지로 구분할 수 있으며, 국회예산정책처 모형은 성별·연령별 의료비 지출 특성을 반영하여 전망하는 조성법에 포함됨

[참고표] 의료비 추계 모형 비교

항목	미시 시뮬레이션 모형 (Microsimulation models)	조성법 (Component-based models)	거시 수준 모형 (Macro-level models)
분석 단위	• 개인	• 인구 하위그룹(Cell)	• 인구 전체
데이터	• 개인 단위의 자료 활용 위한 대규모 데이터 • 암 및 병원 의료 데이터, 제약업체 데이터, 인구건강조사, 임상시험 등 데이터	• 연령군으로 세분화된 의료비 추정치 • 성별, 질병 카테고리에 따른 의료비, 생존상태, 생애말기 비용 등의 정보	• 상대적으로 길고 일관성 있는 시계열 자료 • 인구집단 전체를 하나의 분석단위로 사용 • 의료지출 및 의료 시스템 관련 데이터
전망 방법	• 관심 모집단에서 대규모 샘플을 뽑아 샘플의 특성과 행동을 재현 • 정책의 영향을 평가하기 위해 정책 변화 유무에 따른 시나리오 결과를 비교 • 분석단위는 개인이며, 분석결과를 정책 관련 그룹으로 표현 가능	• 조성법으로 분류되는 모형 중 코호트 기반 모형 사용 • 셀마다 평균 의료비를 갖고 있고 셀에 속하는 사람 수가 변화함. 셀별 평균 비용과 사람 수를 곱하여 의료비 추계	• 시계열 자료를 적합(fitting)시켜 통계적 모형을 만들고 이를 외삽하여 미래 의료비 추계 • 분석단위는 개인이며, 분석결과를 정책 관련 그룹으로 표현가능 • CGE 모델의 경우, 의료지출 증가로 인한 경제 전반에 미치는 영향과 소비자 및 생산자로부터의 피드백을 포함하여 보다 광범위한 경제 결과를 분석함

장점	• 다양한 정책 옵션의 가상 시나리오를 분석 혹은 테스트 할 수 있음 • 개인 단위로 정밀한 예측이 가능하며, 이를 정책 결정 및 리스크 측면에서 유용하게 활용가능	• 필요한 자료의 양이 적으면서도 의료비 추계의 구체성과 복잡성 유지 가능 • 구현 및 유지가 간단하고 비용이 많이 들지 않음 • 정책 관련 변수 설정 후, 정책 변화의 영향 평가 가능 • 다른 모델과 쉽게 통합하여 다양한 분석에 활용 가능	• 일반적으로는 많은 자료를 필요로 하지 않음 (CGE는 제외) • 명확한 경향성이 있거나 혹은 외부 변수에 의한 영향이 덜한 단기 예측에 적합
한계	• 많은 양의 데이터를 필요로 함 • 데이터의 질과 양에 크게 의존하기 때문에, 부족한 데이터로 인한 정확성의 문제 발생가능 • 거시적 경제요인을 모델에 적용하기 어려움	• 정책 영향의 분포를 탐색하는 데 어려움 • 다양한 시나리오 영향력을 테스트하는 데 한계 존재 • 의료지출 분포 영향과 같은 복잡한 분포에 대한 분석이 어려움 • 국가별로 데이터가 없는 경우, 가정을 적용하여 다른 국가 데이터를 활용해야 함	• 총 의료비(aggregate health expenditure)만 추계가능 • 특정 정책의 시행이나 자료의 한계로 인하여 끊김이 생기는 경우 결과에 비틀림 발생가능 • 회귀분석 모형에서 설명변수를 식별하는 것이 복잡함
사례	• 캐나다 Population Health Model • 스웨덴 SESIM	• OECD 모형 • EU Ageing WG model • 국민건강보험공단(2015), 김우현(2018), 이태진(2020)⁹⁶⁾	• 미국 메디케어, 메디케이드 CGE 모형

95) 이태진(2020) 제2장, Astolfi et al.(2012) Chapter 4, Marino et al.(2017), 송창길(2022) 제3장을 요약 정리하였다.

96) 국내·외 선행연구들이 국민의료비 또는 공공의료비를 전망한 후 각 상위 의료비 대비 건강보험 지출 비중을 적용한 탑다운 방식을 적용한 한편, NABO 모형은 가장 하위 범주인 급여비를 추계한 후 건강보험 지출을 전망한다는 차이가 있다. 전체 의료비 증가율과 급여비 증가율은 상이한데, 예를 들어 보장성 강화 대책에 따라 최근 급여비 증가율이 본인부담금 또는 민간의료비(전액본인부담금) 증가율보다 훨씬 높게 나타나고 있다. 본 보고서의 목적은 건강보험 지출 전망이므로 전망의 정확성을 높이기 위해 급여비를 직접적으로 추계하는 방법을 선택한다.

4. 국고지원금에 대한 법 논의사항

[표] 국고지원금에 대한 법 논의사항: 「국민건강보험법」

대표발의자 (의안번호)	일몰여부	지원액	단서조항
이정문의원안 (2102035)	-	전전연도 보험료 수입액의 16%에 해당하는 금액	국민건강증진기금에서 전전연도 보험료 수입의 100분의 7에 해당하는 금액을 지원하지 못하는 경우 그 금액의 차액을 국고에서 지원
정춘숙의원안 (2104286)	일몰 폐지	전전연도 결산상 수입액의 17%에 해당하는 금액	
기동민의원안 (2100750)	-	보험료 예상 수입액의 14%에 해당하는 금액	해당 연도 보험료 예상 수입액과 실제 수입액의 차이로 발생하는 차액은 다음다음 연도의 예산에 계상하여 정산
이종성의원안 (2113292)	일몰 폐지	전전연도 건강보험 지출액의 14%에 해당하는 금액	
김원이의원안 (2117074)	일몰 폐지	전전연도 보험료 수입액의 17%에 해당하는 금액	국민건강증진기금 지원액이 해당하는 금액에 미치지 못하는 경우 그 부족분을 국고에서 부담
신현영의원안 (2118232)	일몰 폐지	전전연도 보험료 수입액의 최소 17% 이상의 금액	
이종배의원안 (2118456)	일몰 연장 (5년)	해당연도 보험료 예상 수입액의 14%에 상당하는 금액	
강은미의원안 (2118047)	일몰 폐지	전전연도 결산상 보험료 수입액의 17%에 해당하는 금액	
전혜숙의원안 (2118574)	일몰 폐지	해당연도 보험료 예상 수입액의 17%에 해당하는 금액	해당 연도 보험료 예상 수입액과 실제 수입액의 차이로 발생하는 차액은 다음다음 연도의 예산에 계상하여 정산

자료: 의안정보시스템을 바탕으로 국회예산정책처 작성

[표] 국고지원금에 대한 법 논의사항: 「국민건강증진법」

대표발의자	의안번호	일몰여부	지원액	단서조항
이정문의원안	2102037	일몰 폐지	전전연도 보험료 수입의 7%에 해당하는 금액	부담금 수입의 60%
정춘숙의원안	2104289	일몰 폐지	전전연도 결산상 보험료 수입액 3%에 해당하는 금액	삭제
이종성의원안	2113291	일몰 폐지	전전연도 건강보험 지출액의 6%에 해당하는 금액	부담금 수입의 65%
김원이의원안	2117075	일몰 폐지	전전연도 보험료 수입액의 3%에 해당하는 금액	부담금 수입의 65%
신현영의원안	2118234	일몰 폐지	전전연도 보험료 수입액의 최소 3% 이상의 금액	삭제
이종배의원안	2118455	일몰 연장 (5년)	당해연도 보험료 예상수입액의 6%에 해당하는 금액	부담금 수입의 65%
전혜숙의원안	2118575	일몰 폐지	당해연도 보험료 예상수입액의 3%에 해당하는 금액	부담금 수입의 65%

자료: 의안정보시스템을 바탕으로 국회예산정책처 작성

참고문헌

- 감사원, 「감사보고서-건강보험 재정관리 실태-」, 2022.
- 국민건강보험공단, 「2021 건강보험 주요통계」, 2022.
- 국민건강보험공단·건강보험심사평가원, 「2020 건강보험통계연보」, 2021.
- 국회예산정책처, 「NABO 재정추계&세제 이슈」, 2022, pp. 73~79
- 김우현, 「건강보험 보장성 강화 정책에 대한 소고」, 한국조세재정연구원, 2021.
- 김윤희, 「「건강보험 보장성 강화대책」 재정추계」, 국회예산정책처, 2017.
- 보건복지부, 「건강보험 보장성 강화대책」, 2017.08.
- 보건복지부 보도자료, “필수의료 지원대책-중증·응급, 분만, 소아진료를 중심으로”, 2023.1.31.
- 보건복지부 보도자료, “건강보험 지속가능성 제고방안”, 2023.2.28.
- 송창길, 「사회보장 재정추계 방법론 개선 방안 연구-재정추계모형을 중심으로」, 한국보건사회연구원, 2022.
- 이은경, “우리나라 건강보험제도에 관한 고찰”, 「재정포럼」, 2010.
- 이태진, 「건강보험 중장기 재정 추계 방법론 연구」, 국회예산정책처, 2020.
- 최슬기, 「국민건강보험의 재정전망 현황과 감사방법에 관한 연구」, 감사원 감사연구원, 2021.
- 홍우형·김원기, 「주요 기금수입 추계방법 연구 및 전망모형 개발」, 국회예산정책처, 2022.
- Astolfi et al.(2012). Informing Policy Makers About Future Health Spending: A Comparative Analysis of Forecasting Methods in OECD Countries. Health Policy, 107.
- Fries, J. F.(1992). Strategies for Reduction of Morbidity. The American Journal of Clinical Nutrition, 55(6), S1257-S1262.
- Fries, J. F.(2002). Aging, natural death, and the compression of morbidity. Bulletin of the World Health Organization, 80(3), 245-250.
- Marino, A., Morgan, D., Lorenzoni, L., & James, C.(2017). Future Trends in Health Care Expenditure: A Modelling Framework for Cross-country Forecasts.
- OECD(2006). Projecting OECD health and long-term care expenditures: What are the main drivers?, OECD Economics Department Working Papers, 477, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2013). Public Spending on Health and Long-term care: A New Set of Projections, OECD Economic Policy Papers, 6, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2016). Better Ways to Pay for Health Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris.

2023~2032년 건강보험 재정전망

발간일	2023년 10월
발행인	국회예산정책처장 조 의 섭
편 집	추계세제분석실 사회비용추계과
발행처	국회예산정책처 서울특별시 영등포구 의사당대로 1 (tel 02 · 2070 · 3114)
인쇄처	경성문화사(tel 02 · 786 · 2999)

내용에 관한 문의는 국회예산정책처 사회비용추계과로 연락해주시
기 바랍니다. (tel 02 · 6788 · 3729)

ISBN 979-11-6799-163-8 93350

© 국회예산정책처, 2023

새로운 **희망**을 만드는 국회



(07233)서울특별시 영등포구 의사당대로 1
Tel. 02-2070-3114 www.nabo.go.kr

발 간 등 록 번 호

31-9700491-002044-01



국회의산정책처
NATIONAL ASSEMBLY BUDGET OFFICE